Lorena Dias Monteiro

Renata Andrade de Medeiros Moreira

CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE CONSELHEIROS E CONSELHEIRAS DE SAÚDE PARA PARTICIPAÇÃO POPULAR E O CONTROLE SOCIAL NO SUS



CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE
ETSUS ESCOLA TOCANTINENSE DO SUS DR. GISMAR GOMES
SECRETARIA DA SAÚDE
GOVERNO DO TOCANTINS

Lorena Dias Monteiro
Renata Andrade de Medeiros Moreira

CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE CONSELHEIROS E CONSELHEIRAS DE SAÚDE PARA PARTICIPAÇÃO POPULAR E O CONTROLE SOCIAL NO SUS

CADERNO DO EDUCANDO

Secretaria de Estado da Saúde
Palmas, TO
2026

Creative Commons "by-nc-sa" licenses O conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença CC Atribuição 4.0.

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
Wanderley Barbosa

SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE
Carlos Felinto Júnior

CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE – CES
Raimundo de Sousa Morais

SUPERINTENDENTE DE GESTÃO PROFISSIONAL E EDUCAÇÃO NA SAÚDE
Leide Idaine Barros da Silva

DIRETORA DA ESCOLA TOCANTINENSE DO SUS DR. GISMAR GOMES – ETSUS
Raimunda Fortaleza de Sousa

SECRETARIA GERAL DE ENSINO (SGE)
Creusa Alves Miranda

GERÊNCIA DE GESTÃO DA ETSUS (GGES)
Gildete Ferreira dos Santos

GERÊNCIA DE CIÊNCIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE (GCIS)
Rosimeire Rodrigues de Menez

GERENTE DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUS (GEPSUS)
Ana Paula Machado Silva

COORDENADORA DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E EQUIDADE – NEPopS-E
Lorena Dias Monteiro

Equipe NEPopS-E
Lorena Dias Monteiro
Jamison Pereira Nascimento
Andersson Dias da Costa

Revisão:
Jamison Pereira Nascimento
Andersson Dias da Costa
Raimunda Fortaleza de Sousa
Marcelo Neves Diniz (diagramação)
Magna Dias Leite

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) - RDA (Resource Description and Access)

M775c

Monteiro, Lorena Dias, autora

Curso de qualificação de conselheiros e conselheiras de saúde para participação popular e o controle social no SUS : caderno do educando / Lorena Dias Monteiro, Renata Andrade de Medeiros Moreira. – 2. ed. – Palmas, TO : Secretaria de Estado da Saúde, 2026.
248 páginas : ilustrações coloridas ; 30 cm.

Inclui bibliografias.
ISBN 978-65-87830-38-4

1. Conselhos de saúde. 2. Participação social. 3. Sistema Único de Saúde (Brasil). I. Moreira, Renata Andrade de Medeiros, autora. II. Título

CDD 362.10425
CDU 614.2:005.742:316.334.3(811.7)(075)
NLM WA 525

Elaborada por Marcelo Diniz - Bibliotecário - CRB 2/1533. Resolução CFB nº 184/2017.

Como referenciar este documento (ABNT NBR 6023)
MONTEIRO, Lorena Dias Monteiro; MOREIRA, Renata Andrade de Medeiros. **Curso de qualificação de conselheiros e conselheiras de saúde para participação popular e o controle social no SUS**: caderno do educando. Palmas, TO: Secretaria de Estado da Saúde, 2026. ISBN 978-65-87830-38-4.

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO 9
MÓDULO I 11
TEXTO 1 - Democracia e Sociedade: Desafios para a efetiva participação popular e o controle social na gestão do SUS na prática da conselheira e do conselheiro de saúde 12
1 DEMOCRACIA E SOCIEDADE COMO FUNDAMENTOS DO SUS 13
1.2 Estado, Democracia e Políticas Públicas 15
1.3 Função e Desafios do Estado na Garantia do Direito À Saúde 17
1.4 Democracia e seus tipos na prática do SUS 20
1.5 Cidadania, Participação Popular, Participação Comunitária e Controle Social 23
1.6 Políticas Públicas: Função, Tipos, Importância e o Ciclo Decisório 28
1.7 O que são políticas públicas? 28
1.8 Tipos de políticas públicas no SUS 30
1.9 Importância das políticas públicas para a atuação no Conselho 33
1.10 O ciclo decisório das políticas públicas e onde o Conselho entra 33
1.11 Quais dados devem sustentar a escolha? 36
2 DESAFIOS PARA A EFETIVA PARTICIPAÇÃO POPULAR E O CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS 41
2.1 Desafios das instâncias colegiadas formais e informais 42
2.2 Desafios políticos, culturais e institucionais 44
2.3 O Desafio permanente da construção democrática do SUS 44
BIBLIOGRAFIA 46
TEXTO 2 - CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO À SAÚDE NO BRASIL 48
3 A ORIGEM E A HISTORICIDADE DA SEGURIDADE SOCIAL: DA PROTEÇÃO RESTRITA AO DIREITO SOCIAL UNIVERSAL 49
3.1 Reforma sanitária brasileira e a conquista política do SUS 53
3.2 A Constituição de 1988 e a institucionalização do direito à saúde 57
3.3 O SUS como conquista popular, política pública e patrimônio social 59
3.4 Considerações finais 61
BIBLIOGRAFIA 62
TEXTO 3 - A criação e a implementação do SUS 64
4 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E LEIS 8.080 DE 1990 E 8.142 DE 1990 64
4.1 O SUS na Constituição de 1988 65
4.2 O que a Constituição garante e por que isso muda seu trabalho no conselho 65
4.3 Artigo 196 - A saúde como direito e dever do Estado. 65

4.4 Artigo 197 - As ações e serviços de saúde são de relevância pública. 66
4.5 Artigo 198 - A rede do SUS e suas diretrizes..... 66
4.6 Artigo 199 - A assistência à saúde e a iniciativa privada. 67
4.7 Artigo 200 - Competências do SUS. 67
4.8 Promover, Proteger e Recuperar 68
4.8.1 Promoção da saúde..... 68
4.8.2 Proteção da saúde 68
4.8.3 Recuperação da saúde 69
4.8.4 Da Constituição para as leis do SUS 69
4.10 Lei 8.080 de 1990 - Lei Orgânica da Saúde: organização, funcionamento e responsabilidades... 69
4.10.1 O SUS é mais amplo que assistência..... 70
4.11 Lei 8.142 de 1990..... 71
4.11.1 Participação social e financiamento: o lugar formal do conselho e da conferência 71
4.11.2 Dois pilares para a atuação do conselho..... 71
4.11.2.1 Participação social com método e regra 71
4.11.2.2 Recurso público com critério e transparência 72
4.11.3 Onde você atua com protagonismo 73
4.12 Princípios e diretrizes do SUS..... 74
4.12.1 Entendendo o que é princípio e o que é diretriz no Sistema Único de Saúde 74
4.12.2 Princípios e diretrizes do SUS..... 74
4.12.2 Os três princípios do SUS 75
4.12.4 As diretrizes do SUS 77
4.12.4.1 Como o sistema deve ser organizado para garantir os princípios 77
4.12.4.2 A descentralização como diretriz organizativa 77
4.12.4.3 Regionalização e hierarquização da rede 79
4.12.4.4 Participação da comunidade como diretriz do sistema..... 80
4.12.4.5 Epidemiologia como base do planejamento..... 80
4.13 A lei 8080 como instrumento de poder do controle social..... 81
BIBLIOGRAFIA..... 83
TEXTO 4 - Redes de Atenção à Saúde no SUS..... 84
5 O QUE SÃO REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE – RAS? 84
5.1 Por que falar de Redes de Atenção à Saúde no SUS? 84
5.2 De onde vem essa ideia de redes? 86
5.3 Relatório Dawson, 1920..... 87
5.4 Plano Beveridge, 1942 88
5.5 Redes, pessoas e interesses econômicos..... 89

5.6 Redes de Atenção à Saúde no Brasil 89
5.7 Por que redes importam para a integralidade? 91
5.8 O que significa integralidade neste debate? 91
5.9 O desafio brasileiro: rede integral em municípios pequenos 92
5.10 Regulamentação das RAS 94
5.11 O que caracteriza uma rede bem organizada? 96
5.11.1 População e território 96
5.11.2 Diferentes tipos de serviços 97
5.11.3 Sistemas de apoio 98
5.11.4 Comunicação e fluxos 98
5.11.5 Gestão e pactuação 99
5.11.6 Integração na rede: o coração do funcionamento 99
5.11.6.1 Instrumentos que ajudam a integrar a rede: 100
5.11.6.2 Regulação do acesso 101
5.11.6.3 Matriciamento 101
BIBLIOGRAFIA 102
TEXTO 5 - A Educação Popular em Saúde para a atuação ético-política da conselheira e do conselheiro de saúde 104
6 EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE COMO FUNDAMENTO ÉTICO-POLÍTICO DA ATUAÇÃO NO SUS 105
6.1 Educação popular em saúde no território, na atenção primária e nos serviços do SUS 108
6.2 Educação popular em saúde como mobilização da participação social e da democracia 110
6.3 Educação popular em saúde como caminho para fortalecer o sus e a democracia 111
BIBLIOGRAFIA 113
MÓDULO II 115
TEXTO 6 - O Regimento Interno como Instrumento Político, Normativo e Pedagógico do Conselho de Saúde 116
7 CONCEITO E FUNÇÃO DO REGIMENTO INTERNO, A REGRA QUE PROTEGE A DECISÃO COLETIVA 117
7.1 Natureza normativa, política e organizativa, o regimento como arquitetura do poder no conselho 119
7.2 Regimento como critério de legitimidade deliberativa, quando a decisão é válida e respeitável . 120
7.3 Do texto do regimento para a prática registrada em atas: o que o caso do CMS de Vitória-ES ensina 122
7.4 Como elaborar ou revisar o regimento, um roteiro prático para conselhos que querem maturidade institucional 124

BIBLIOGRAFIA 127
MÓDULO III 128
TEXTO 7 - Funcionamento e organização do Conselho de Saúde – Resolução 453 129
8 RESOLUÇÃO Nº 453/2012 - MARCO NORMATIVO QUE ORIENTA A INSTITUIÇÃO, A REFORMULAÇÃO, A ORGANIZAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE SAÚDE EM TODAS AS ESFERAS DE GOVERNO 129
8.1 Resolução Nº 453, de 10 de maio de 2012 130
8.1.1 Da definição de conselho de saúde 131
8.1.2 Da instituição e reformulação dos conselhos de saúde 133
8.1.3 DA Organização dos Conselhos de Saúde 134
8.1.4 Estrutura e funcionamento dos Conselhos de Saúde 137
8.1.5 Competências dos Conselhos de Saúde 141
8.1.6 Desafios acerca da aplicação da Resolução nº 453/2012 144
BIBLIOGRAFIA 147
TEXTO 8 – Os instrumentos de gestão na pauta do Conselho de Saúde 148
9 OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DA SAÚDE E DO ORÇAMENTO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL NO SUS 148
9.1 Quem elabora o Plano Plurianual – PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA e como esses instrumentos se articulam ao planejamento em saúde e ao controle social no SUS 150
9.2 O Plano de Saúde para o controle social 153
9.2.1 O que é o Plano de Saúde e qual sua função no SUS 154
9.2.2 O Plano de Saúde como pacto público entre Estado e sociedade 155
9.2.3 Etapas para a elaboração do Plano de Saúde 156
9.2.4 A análise da situação de saúde como base do Plano de Saúde 157
9.2.5 Diretrizes, objetivos, metas e indicadores: núcleo estratégico do Plano de Saúde 162
9.2.6 O Plano de Saúde e sua relação com o orçamento público 163
9.2.7 O Plano de Saúde na prática do controle social 164
9.3 Programação Anual de Saúde (PAS) no SUS para o controle social 165
9.3.1 Funções técnicas da Programação Anual de Saúde, o que ela precisa conter para permitir controle e fiscalização 166
9.3.2 Como a Programação Anual de Saúde funciona no ciclo de planejamento e gestão 167
9.3.3 Estrutura mínima da PAS, o esqueleto que o Conselho precisa exigir 168
9.4 Relatório anual gestão no sus, para que ele existe e por que ele muda a prática do controle social 174
9.4.1 O que o Relatório Anual de Gestão precisa ter para análise do Conselho de Saúde 176

9.4.2 Fluxo, prazos, sistemas e transparência do Relatório Anual de Gestão 179
9.4.3 A análise do Relatório Anual de Gestão pelo Conselho..... 180
9.5 O Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior – RDQA 182
9.6 Indicadores de saúde para monitoramento do conselho de saúde 185
9.7 Agenda dos gestores..... 187
9.8 Agenda dos conselhos 193
9.9 Ferramentas de apoio ao planejamento no sus e seu uso estratégico no trabalho da conselheira e do conselheiro de saúde 195
BIBLIOGRAFIA..... 202
Texto 9 - Financiamento do SUS: História, marcos legais, desafios e a luta do controle social 205
10 HISTÓRIA DO FINANCIAMENTO DO SUS 205
10.1 As Emendas Constitucionais nº 86/2015 e nº 95/2016 e o processo de subfinanciamento do SUS – a chamada “PEC da morte”..... 207
10.2 Legislação sobre o financiamento do Sistema Único de Saúde: da Constituição Federal às normas infraconstitucionais 208
10.3 A lei complementar Nº 141/2012 para o controle social, leitura aplicada e minuciosa 212
10.3.1 Percentuais mínimos e regra federal, com base de cálculo explícita..... 213
10.3.2 O que pode ser contabilizado como ações e serviços públicos de saúde, e o que é vedado..... 214
10.3.3 Fundos de Saúde, rastreabilidade e regra de movimentação..... 215
10.3.4 Como o mínimo é apurado ao longo do ano, restos a pagar e correções quadrimestrais 215
10.3.5 Rateio e transferências, critério de equidade e pactuação com aprovação do conselho..... 218
10.3.6 Transparência, prestação de contas e instrumentos que o conselho precisa exigir, com prazos 219
10.3.7 Sistema de Informação sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) como instrumento legal de controle, fé pública e integração com controle externo..... 220
10.3.8 Condicionamento, medidas restritivas e responsabilização, o que o conselho deve acionar ... 221
10.3.9 Planejamento e orçamento, onde o conselho ganha poder de indução..... 222
10.3.10 Desafios para o financiamento do Sistema Único de Saúde: o desfinanciamento como projeto político..... 222
10.4 O financiamento do SUS como luta permanente do controle social 225
BIBLIOGRAFIA..... 227
TEXTO 10 – Participação Social No SUS: Caminhos para a equidade..... 228
11 EQUIDADE NO SUS, O QUE É E SUA APLICAÇÃO 228
11.1 Iniquidades e necessidades de saúde, demandas por políticas para populações vulnerabilizadas 230
11.2 A função do controle social para a promoção da equidade no SUS..... 231

11.3 Educação Popular em Saúde como instrumento para a equidade, contribuições de Paulo Freire233
BIBLIOGRAFIA..... 240
GUIA DE LEGISLAÇÃO 241

APRESENTAÇÃO

Prezadas educandas e prezados educandos,

Sejam bem-vindas e bem-vindos ao **Curso de Qualificação de Conselheiras e Conselheiros de Saúde para a participação popular e o controle social no SUS**, desenvolvido pelo Núcleo de Educação Popular em Saúde, Participação Social e Equidade, NEPopS-E. Este caderno de curso foi elaborado como parte integrante do percurso pedagógico da formação e se apresenta como um instrumento técnico, político e formativo, pensado para apoiar o processo de ensino aprendizagem de forma articulada à prática cotidiana dos Conselhos de Saúde e às realidades vividas nos territórios.

Ao longo do curso, o caderno orienta uma caminhada formativa, na qual conceitos, marcos legais e experiências se conectam de maneira contínua. O percurso inicia no **Módulo I**, no qual o Texto 1 estabelece a relação entre democracia e sociedade, ao mesmo tempo em que problematiza os desafios da participação popular e do controle social na gestão do SUS, situando a atuação da conselheira e do conselheiro como prática política. Em seguida, o Texto 2 apresenta a construção histórica do direito à saúde no Brasil e, ao fazê-lo, permite compreender o SUS como resultado de lutas sociais e de disputas por cidadania. Na sequência, o Texto 3 aprofunda a criação e a implementação do SUS, conectando os fundamentos constitucionais do sistema às responsabilidades do Estado na garantia do direito à saúde. Logo após, o Texto 4 introduz as Redes de Atenção à Saúde no SUS, ampliando a compreensão sobre a organização do cuidado, os fluxos assistenciais e os desafios da integralidade. Por fim, ainda no Módulo I, o Texto 5 aborda a Educação Popular em Saúde como base para a atuação ético política da conselheira e do conselheiro, reforçando o vínculo entre território, participação social e defesa do SUS.

Na continuidade do percurso, o **Módulo II** aprofunda dimensões da prática do controle social. Nesse momento, o Texto 6 analisa o Regimento Interno como instrumento político, normativo e pedagógico do Conselho de Saúde e, desse modo, evidencia sua importância para a organização do trabalho, para a democracia e para a sustentação das deliberações colegiadas.

O **Módulo III** amplia essa reflexão ao aproximar ainda mais o conteúdo da prática cotidiana dos Conselhos. Inicialmente, o Texto 7 trata do funcionamento e da organização do Conselho de Saúde à luz da Resolução nº 453, de 10 de maio de 2012, do Conselho Nacional de Saúde (CNS), reafirmando o caráter deliberativo, permanente e representativo do controle

social no SUS. Em seguida, o Texto 8 discute os instrumentos de gestão na pauta do Conselho de Saúde, oferecendo subsídios técnicos para a análise de planos, programações, relatórios e orçamentos, indispensáveis para a defesa da equidade e para o acompanhamento responsável das políticas públicas. O percurso se completa com o Texto 10, que aborda a participação social no SUS como caminho para a equidade, reafirmando o papel estratégico do controle social na identificação das iniquidades e na defesa de decisões públicas orientadas pelas necessidades reais da população.

Este caderno foi concebido como material de leitura para reflexão crítica, deslocamento de olhar e articulação permanente entre teoria e prática. Assim, cada texto convida as conselheiras e os conselheiros a relacionar normas, instrumentos e conceitos com os desafios enfrentados nos Conselhos de Saúde e nos territórios.

Desejamos que este percurso formativo fortaleça sua atuação política, amplie sua capacidade de análise crítica e reafirme o Conselho de Saúde como espaço vivo de democracia, participação popular e promoção da equidade no SUS. Que este caderno acompanhe sua prática e contribua para o fortalecimento do direito à saúde como expressão de justiça social.

MÓDULO I



Participa+SUS

QUALIFICAÇÃO DE CONSELHEIRAS E CONSELHEIROS DE SAÚDE PARA A PARTICIPAÇÃO POPULAR E CONTROLE SOCIAL NO SUS

TEXTO 1 - Democracia e Sociedade: Desafios para a efetiva participação popular e o controle social na gestão do SUS na prática da conselheira e do conselheiro de saúde

A proposta deste capítulo é ajudar você a compreender como **Estado**, **democracia**, **cidadania**, **participação popular**, **controle social** e **políticas públicas** se conectam com a prática cotidiana de quem atua nos Conselhos de Saúde e em outras instâncias de participação. Ao longo do texto, cada tópico traz um **diálogo com você** para aproximar o conteúdo da realidade de atuação, porque o controle social não se aprende apenas por conceitos, mas também pela leitura crítica do cotidiano, pelo discernimento político e pela capacidade de transformar demandas sociais em pautas, deliberações e monitoramento efetivo.



Fonte: Conselho Nacional de Saúde, 2016.

1 DEMOCRACIA E SOCIEDADE COMO FUNDAMENTOS DO SUS

A Constituição de 1988 instituiu o Brasil como um **Estado Democrático de Direito**, expressão que indica um modelo de organização política em que o poder deve obedecer às leis e, ao mesmo tempo, garantir direitos fundamentais e reduzir desigualdades. A ideia de "Estado de Direito" aponta para a legalidade, isto é, a atuação do poder público deve seguir regras e limites institucionais, enquanto "Democrático" indica que esse poder se funda na soberania popular, o que significa que a sociedade não é mera destinatária das políticas, mas fonte de legitimidade das decisões públicas.

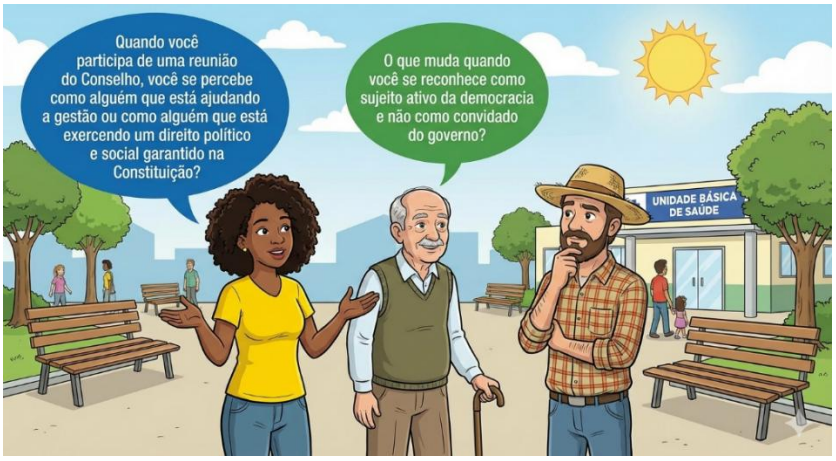
A **democracia**, nesse marco, não se reduz ao ato de votar. A democracia envolve o direito real de participar, influenciar e fiscalizar as decisões do Estado, especialmente quando estão em jogo direitos sociais, como saúde, educação, assistência, previdência e outros. Por isso, quando a **Constituição Federal afirma que a saúde é direito de todos e dever do Estado**, ela também cria um compromisso político com a participação social como condição para que esse direito não fique só no papel. O SUS nasce dentro desse processo histórico e político e se fortalece quando a sociedade ocupa os espaços de debate e deliberação, definindo prioridades e cobrando resultados.

Em outras palavras, quando a população participa, a democracia ganha densidade e o SUS ganha força. Quando a participação é enfraquecida ou tratada como formalidade, a democracia se estreita e o SUS tende a ser administrado por interesses de poucos, inclusive com risco de desigualdades maiores no acesso e na qualidade do cuidado.



Fonte: https://ceap-rs.org.br

Diálogo com o educando



Fonte: Autoria de IA.

Situação problema para reflexão e prática



Fonte: Autoria de IA.

Em uma região do município, a comunidade reclama que a Unidade de Saúde funciona com falta de profissionais e cancelamentos frequentes. A Secretaria informa que "está dentro do possível" e que não há previsão de melhora. O Conselho recebe a demanda, mas parte dos conselheiros considera que isso é problema "interno" da gestão e não assunto para deliberação.

Como você justificaria, com base no sentido de democracia e no fundamento do SUS, que essa pauta deve ser discutida e acompanhada pelo Conselho?

***

1.2 Estado, Democracia e Políticas Públicas

O **Estado** é a estrutura institucional que organiza o poder político, define regras, administra recursos públicos e executa políticas que afetam a vida coletiva. Em termos práticos, quando falamos de Estado no cotidiano, estamos falando do **conjunto de órgãos e instituições que tomam decisões e executam ações como financiamento, organização da rede, contratação de equipes, compra de insumos, funcionamento de serviços, fiscalização e regulação.** Esse Estado atua por meio de governos, mas não se confunde com o governo do momento. O Estado deve manter o compromisso com os direitos constitucionais independentemente de quem esteja no comando político.

A **democracia**, por sua vez, é o princípio que legitima o Estado, porque reconhece que a autoridade do poder público deve responder ao interesse coletivo e prestar contas à sociedade. A democracia, quando levada a sério, exige que o Estado seja transparente, dialogado e controlável, principalmente nas políticas sociais, onde o risco de desigualdade e exclusão é maior.



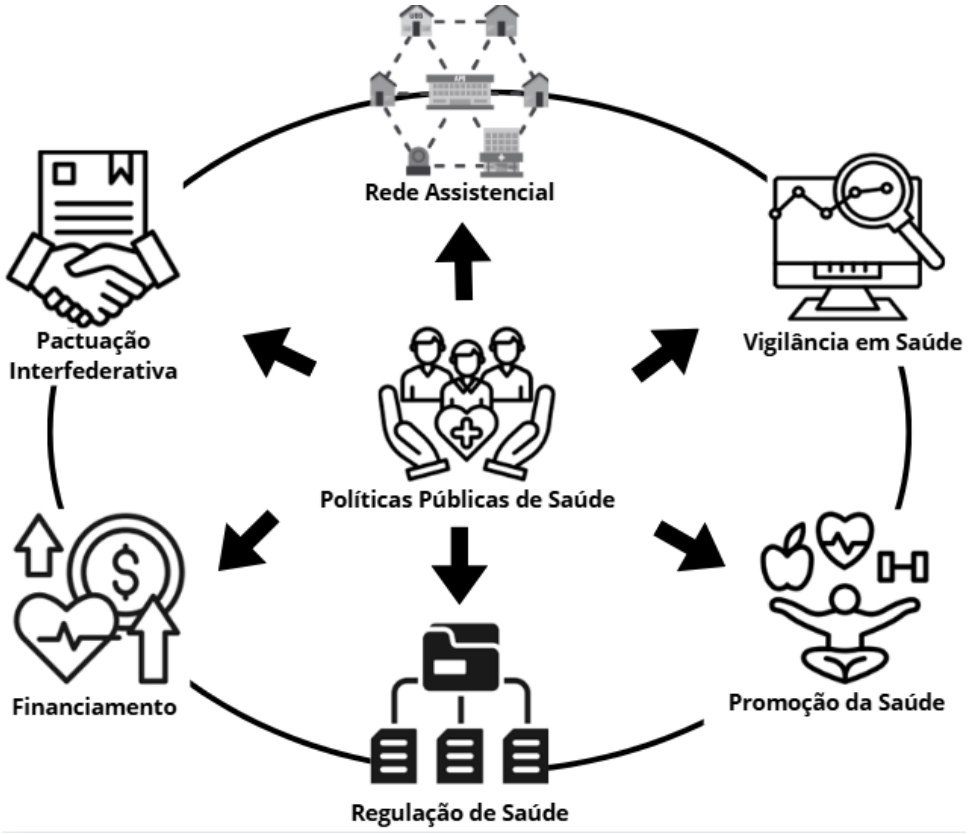
Fonte: https://cee.fiocruz.br/saude-e-democracia/

As **políticas públicas** são os instrumentos que traduzem direitos em ações. Elas não são apenas programas ou serviços isolados, mas decisões organizadas que envolvem planejamento, orçamento, prioridades, implementação, avaliação e correção de rumos. Uma política pública

de saúde se expressa na organização da rede assistencial, na vigilância, na promoção da saúde, na regulação de acesso, no financiamento e nos pactos interfederativos (Figura 1). Por isso, a política pública é um campo de disputa, porque define quem vai receber o quê, quando e com qual qualidade, e isso nunca é neutro.

Aqui entra um ponto que interessa diretamente ao controle social. Quando o Conselho acompanha uma política pública, ele não está apenas "olhando um serviço", mas está avaliando o modo como o Estado cumpre, ou deixa de cumprir, o pacto constitucional do direito à saúde.

Figura 1 – Como a política pública se organiza e materializa no território.



"No SUS, tudo está conectado: quando um eixo falha, todo o sistema sente"

Fonte: Autoral, com recursos do Canva, 2026 e adaptação da UFMA, 2018.

Diálogo com o educando



Fonte: Autoria de IA.

Situação problema para reflexão e prática



Fonte: Autoria de IA.

O município apresenta um plano de saúde com metas genéricas, sem indicadores claros, e com pouco detalhamento do orçamento.
A gestão diz que isso é "técnico demais" para debate no Conselho e sugere apenas aprovação rápida para cumprir prazos administrativos.

Como você responderia a isso a partir do conceito de Estado, democracia e políticas públicas, e quais perguntas você faria para impedir que o Conselho se torne apenas homologador?

***

1.3 Função e Desafios do Estado na Garantia do Direito À Saúde

A Constituição define que a saúde é um direito social e um dever do Estado. Isso significa que o Estado deve garantir condições para que as pessoas não apenas sejam atendidas quando adoecem, mas também tenham ações e políticas que reduzam riscos, previnam doenças

e agravos, protejam a vida e ampliem bem-estar (Figura 2). A saúde, portanto, não se resume ao consultório, ao hospital ou ao exame. Ela depende de um conjunto de políticas sociais e econômicas e também de uma organização de serviços que funcione de modo planejado e com responsabilidade pública.

Ao mesmo tempo, os desafios para o Estado cumprir esse dever são conhecidos e precisam ser lidos com atenção. Há limitações de financiamento, desigualdade entre territórios, falta de profissionais em áreas específicas, precarização do trabalho, demora em regulações, fragilidade de sistemas de informação, interesses privados disputando recursos e prioridades, e dificuldades de coordenação entre as esferas federal, estadual e municipal. Tudo isso pode enfraquecer a capacidade do SUS responder às necessidades reais da população.

Figura 2 – Ações de saúde desenvolvidas pelo Estado.



Fonte: Autoral, com recursos do Canva, 2026

Nesse cenário, o controle social é uma forma de fortalecer a capacidade pública do Estado de cumprir seu dever constitucional. Quando o Conselho atua com base em evidências, com leitura do território e com compromisso público, ele amplia a transparência e reduz a margem de arbitrariedades, improvisos e desigualdades.



Fonte: Ministério da Saúde.

Diálogo com o educando



Fonte: Autoria de IA.

Situação problema para reflexão e prática	
 Fonte: Autoria de IA.	A comunidade relata falta frequente de medicamentos e insumos na unidade, e a gestão local afirma que "não é responsabilidade do município", atribuindo ao Estado ou à União.
Como você analisaria essa justificativa? **Quais documentos, fluxos e informações você pediria para identificar responsabilidades e organizar uma cobrança institucional correta?**	

***

1.4 Democracia e seus tipos na prática do SUS

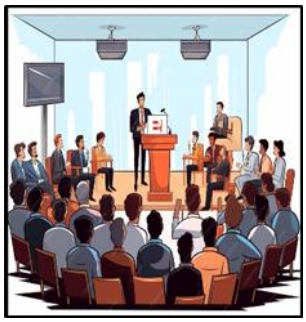
É importante compreender que a democracia possui dimensões que se complementam, podendo ser uma **democracia representativa,** ou uma **democracia participativa** ou uma **democracia deliberativa**.



Democracia representativa se baseia no voto e na eleição de candidatos. Ela é necessária, mas insuficiente para sustentar um sistema público universal, porque as decisões de saúde ocorrem diariamente e exigem acompanhamento permanente.



Democracia participativa se expressa quando a sociedade participa de forma contínua em conselhos, conferências e espaços públicos. Ela é essencial no SUS porque permite que a política de saúde responda a necessidades e não apenas a prioridades definidas por cima.



Democracia deliberativa se manifesta quando as decisões são construídas com base em debate qualificado, argumentação, escuta e pactuação, em vez de imposição. Essa dimensão é central para conselhos de saúde, porque deliberação exige que diferentes interesses e perspectivas sejam organizados em decisões com legitimidade pública.

Essas dimensões ajudam você a entender por que a participação social no SUS não é “um detalhe”, mas uma forma de organizar o Estado de modo democrático e transparente.



Fonte: Universidade de São Paulo (USP).

Diálogo com o educando



Fonte: Autoria de IA.

Situação problema para reflexão e prática	
 Fonte: Autoria de IA.	Uma reunião do Conselho tem pauta extensa e tempo curto, e a presidência conduz votações rápidas sem debate, justificando que “o importante é aprovar”.
Como isso afeta a democracia deliberativa? **Quais estratégias você poderia propor para garantir que deliberações sejam construídas com debate e não apenas formalizadas?**	

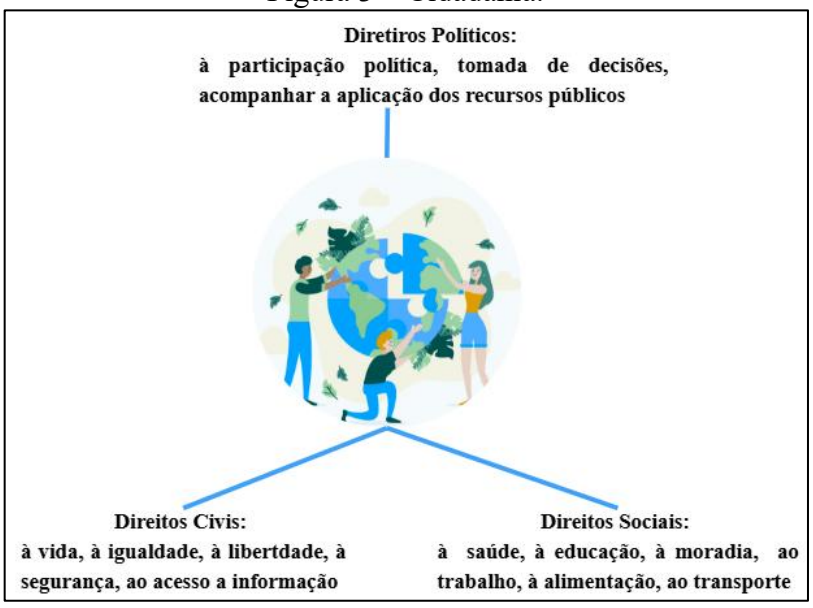
***

1.5 Cidadania, Participação Popular, Participação Comunitária e Controle Social

A compreensão dos conceitos de **cidadania**, **participação popular**, **participação comunitária** e **controle social** é fundamental para a atuação qualificada das conselheiras e dos conselheiros de saúde, pois esses pilares estruturam a base democrática sobre a qual se organiza o Sistema Único de Saúde. Não se trata apenas de categorias teóricas, mas de dimensões da vida social e política que orientam a forma como a sociedade se relaciona com o Estado e incide sobre as políticas públicas.

A **cidadania** constitui a condição política e social que reconhece cada pessoa como sujeito de direitos e deveres. No Brasil, a cidadania se consolida como princípio constitucional a partir de 1988, quando a Constituição institui um Estado Democrático de Direito comprometido com a redução das desigualdades sociais e com a garantia de direitos fundamentais, entre eles o direito à saúde (Figura 3).

Figura 3 – Cidadania.



Fonte: Autoral, com recursos do Canva, 2026.

No campo das políticas públicas, exercer a cidadania não se limita ao acesso aos serviços, mas envolve a possibilidade real de participar das decisões, acompanhar a aplicação dos recursos públicos, exigir transparência da gestão e intervir nos rumos das políticas que impactam diretamente as condições de vida da população. A cidadania, portanto, não é uma

condição passiva. Ela se materializa na ação política cotidiana, na organização coletiva, na capacidade de reivindicar direitos e na construção permanente de espaços públicos de deliberação.

No SUS, a cidadania se expressa quando a população não apenas utiliza os serviços, mas participa de sua organização, planejamento e avaliação, reconhecendo-se como parte legítima da gestão do sistema.

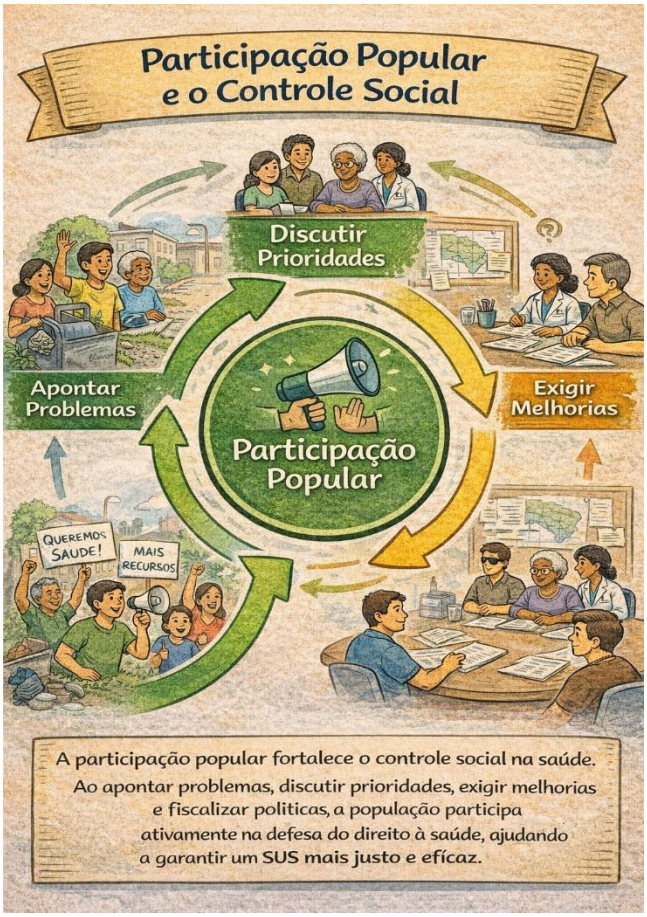


Fonte: Foto divulgação / Dia Mundial da Saúde - 07/04/2017 São Paulo

A **participação popular** corresponde à forma mais ampla de organização da sociedade civil na defesa de direitos e na incidência sobre as decisões do Estado. Trata-se de um processo político coletivo por meio do qual diferentes sujeitos sociais se mobilizam, constroem pautas, formulam propostas e disputam prioridades no espaço público. No campo da saúde, a participação popular é fruto da trajetória histórica do Movimento da Reforma Sanitária Brasileira, que articulou trabalhadores, usuários, pesquisadores e movimentos sociais na luta pela universalização do direito à saúde e pela criação do SUS.

A participação popular se expressa nos movimentos sociais, nas frentes de defesa do SUS, nas articulações intersetoriais, nos fóruns regionais, nas conferências de saúde e nos próprios conselhos de políticas públicas. Ela não se restringe a um território específico, mas se projeta na escala municipal, regional, estadual e nacional, disputando o modelo de atenção, o financiamento, a organização da rede e a orientação das políticas públicas.

Ao atuar nos Conselhos de Saúde, a conselheira e o conselheiro tornam-se sujeitos ativos da participação popular, pois representam segmentos sociais e contribuem para que as demandas coletivas sejam incorporadas ao processo decisório do SUS. Dessa forma, a participação popular se converte em instrumento de democratização do Estado e de corresponsabilização entre governo e sociedade.



Fonte: Autoria de IA.

A **participação comunitária**, por sua vez, constitui a base territorial e cotidiana da participação social. Ela se enraíza na vida das comunidades, nos bairros, nas localidades rurais, nas periferias urbanas, nos territórios tradicionais, nas associações de moradores, nos coletivos populares, nas pastorais, nos fóruns locais e nas organizações de base. A participação comunitária emerge quando a própria população se organiza para enfrentar problemas que afetam diretamente suas condições de vida, como a falta de acesso a serviços de saúde, saneamento precário, ausência de transporte, violência, insegurança alimentar e degradação ambiental.

A participação comunitária é compreendida como uma das expressões mais avançadas da democracia, pois estabelece uma relação direta entre Estado e sociedade, reconhecendo que as

comunidades detêm conhecimento profundo sobre sua realidade social, sanitária e territorial. A participação comunitária não é apenas uma estratégia de mobilização social, mas um campo legítimo de produção de saberes, diagnósticos e propostas para a formulação das políticas públicas.

Enquanto a participação popular atua na arena política mais ampla, a participação comunitária constitui o chão onde as necessidades de saúde se manifestam de forma direta e cotidiana. Ela é o espaço da escuta, da organização local e da construção de soluções territorializadas. Sem participação comunitária, a participação popular perde enraizamento. Sem participação popular, a participação comunitária perde capacidade de incidência institucional.

O **controle social** é a forma institucionalizada da participação da sociedade na gestão pública. No SUS, ele se concretiza principalmente por meio dos Conselhos e das Conferências de Saúde, instâncias criadas pela Constituição de 1988 e regulamentadas pela Lei nº 8.142 de 1990. O controle social não se limita à fiscalização, mas envolve as funções de deliberação, acompanhamento, monitoramento, avaliação e proposição das políticas de saúde.

O controle social permite que a participação popular e a participação comunitária se convertam em decisões públicas, orientem o planejamento do sistema, acompanhem a execução das políticas e avaliem seus resultados. Trata-se de um instrumento democrático que conecta o território ao Estado, a vida cotidiana à gestão pública, a necessidade social à política pública. No cotidiano do SUS, o controle social exige método, compromisso ético, acesso à informação e capacidade de articulação. Exige também que as conselheiras e os conselheiros reconheçam seu papel como representantes da sociedade e não como auxiliares da gestão. O Conselho de Saúde é um espaço de poder público compartilhado, no qual a sociedade exerce a soberania popular de forma direta e permanente.

Assim, cidadania, participação popular, participação comunitária e controle social formam um mesmo campo político de construção democrática do SUS. A cidadania confere legitimidade à participação. A participação popular organiza a disputa política. A participação comunitária dá enraizamento territorial às demandas sociais. O controle social transforma essas demandas em decisões públicas. É nesse entrelaçamento que se constrói a força social do Sistema Único de Saúde e é nesse espaço que se inscreve a atuação histórica, política e ética das conselheiras e dos conselheiros de saúde como sujeitos fundamentais da democracia brasileira.



Fonte: Autoria de IA.

Diálogo com o educando



Fonte: Gemini / nano banana

Situação problema para reflexão e prática	
 Fonte: Autoria de IA.	Uma comunidade denuncia que os agentes comunitários de saúde não estão conseguindo visitar as famílias. O Conselho recebe a denúncia, mas não sabe como proceder além de “pedir explicações”.
Como você transformaria isso em um ciclo de controle social com passos claros, evidências e devolutiva pública?	

***

1.6 Políticas Públicas: Função, Tipos, Importância e o Ciclo Decisório

Para uma conselheira ou um conselheiro de saúde, entender **políticas públicas** é como ter um mapa do caminho do direito à saúde. Sem esse mapa, a gente até identifica problemas na ponta, mas tem dificuldade para saber onde pressionar, que documento pedir e em que momento o Conselho deve agir com mais força.

1.7 O que são políticas públicas?

Políticas públicas são decisões e ações organizadas do Estado para enfrentar problemas coletivos e garantir direitos. Elas não são só "programas" ou "projetos". Elas incluem:



Fonte: Autoral, com recursos do Canva, 2026.

Quando o SUS vacina, regula consultas, organiza a rede de urgência, financia a Atenção Primária, define protocolos, contrata serviços, constrói uma unidade, ou reorganiza fluxos de referência e contrarreferência, ele está executando políticas públicas.

Função das políticas públicas no SUS

A função das políticas públicas no SUS é transformar o direito à saúde em cuidado real e acessível. Isso envolve, ao mesmo tempo, proteger a população de riscos, organizar serviços para responder às necessidades e reduzir desigualdades. Na prática, uma política pública cumpre as seguintes funções:

- ✓ Define prioridades, porque o orçamento é limitado e o Estado precisa escolher onde investir primeiro.
- ✓ Distribui recursos e organiza responsabilidades entre União, Estado e Município, o que impacta diretamente a vida da população.
- ✓ Estabelece regras de acesso, por exemplo critérios para exames, cirurgias e atendimentos especializados, evitando que o sistema funcione por favorecimento.
- ✓ Organiza a rede, definindo o papel de cada ponto de atenção, a forma de encaminhamento e o modo de acompanhamento dos usuários ao longo do tempo.
- ✓ Cria mecanismos de transparência e prestação de contas, permitindo que a sociedade acompanhe metas, gastos e resultados.

Para o controle social, a política pública é o lugar onde se decide se o SUS será de fato universal e equânime ou se ficará capturado por interesses particulares e por desigualdades silenciosas.

Diálogo com o educando



Fonte: Gemini / nano banana

Situação problema para reflexão e prática	
 Fonte: Autoria de IA.	Uma comunidade afirma que a fila de ultrassom nunca anda, mas "quem conhece alguém consegue".
Isso aponta para qual falha de política pública? Falha de acesso regulado? Falha de transparência? Falha de monitoramento? **Que evidências e documentos o Conselho pode solicitar para transformar a denúncia em deliberação?**	

***

1.8 Tipos de políticas públicas no SUS

No SUS, as políticas públicas podem ser organizadas de várias formas, mas para a prática da conselheira e do conselheiro é útil reconhecer três classificações.

A primeira é por alcance, podendo ser políticas universais ou políticas focalizadas ou direcionadas, não contradizendo o SUS, pois na prática, muitas vezes garantir equidade exige políticas direcionadas para reduzir desigualdades históricas. **A segunda classificação é pelo tipo de ação** como as de promoção da saúde, que buscam melhorar condições de vida e reduzir riscos antes do adoecimento; as de prevenção e vigilância, que atuam sobre agravos, riscos e doenças, organizando resposta e controle; e as assistenciais que organizam consultas, exames, cirurgias, urgência e internação. **A terceira classificação é pelo nível de decisão**, que podem ser definidas nacionalmente, pactuadas regionalmente, ou organizadas localmente. Para o controle social, isso é essencial, porque ajuda a identificar quem tem responsabilidade sobre cada problema e qual instância deve ser acionada (Quadro 1).

Quadro 1 – Características dos Tipos de Políticas Públicas de Saúde.

Classificações das Políticas Públicas	Tipo de Política	População	Exemplo
Por Alcance	Políticas Universais	População em geral	Atenção primária, Vacinação, Assistência farmacêutica essencial Saúde bucal
	Políticas Focalizadas ou Direcionadas	Grupos mais vulnerabilizados ou cm necessidades específicas	População em situação de rua, Saúde indígena, Saúde da mulher, Saúde mental, Pessoas com deficiência
Por Tipo de Ação	Promoção da saúde	População em geral	Promoção da Saúde Alimentação e nutrição
	Prevenção e Vigilância	População em risco de desenvolvimento de doença ou com algum agravo	Doenças crônicas não transmissíveis Doenças transmissíveis Vigilância em saúde
	Assistenciais	População em geral Organização do SUS Profissionais de saúde	Gestão Em Defesa do SUS Vigilância em Saúde Regionalização, Regulação, Financiamento, Planejamento, Trabalho, Educação em saúde Educação permanente em saúde Humanização
Nível de decisão	-	Nacional Regional Local	Rede de Atenção à Saúde

Fonte: As autoras



Fonte: Autoria de IA.

Diálogo com o educando



Fonte: Gemini / nano banana

Situação problema para reflexão e prática	
 Fonte: Autoria de IA.	O município afirma que não consegue ofertar determinados exames porque “isso é do Estado”. O Conselho aceita a justificativa e encerra o assunto.
O que deveria ser feito de modo tecnicamente correto antes de encerrar a pauta? Que pactuações, fluxos e responsabilidades precisam aparecer na discussão?	

***

1.9 Importância das políticas públicas para a atuação no Conselho

A importância das políticas públicas para o trabalho do Conselho é que elas são o território real onde o poder público se materializa. Sem política pública, o SUS vira improviso. E onde há improviso contínuo, há desigualdade e favorecimento.

Quando o Conselho acompanha políticas públicas, ele fortalece três dimensões do SUS. Ele fortalece justiça, porque cobra que a distribuição de recursos e o acesso sigam critérios públicos e não privilégios. Ele fortalece qualidade, porque exige metas, indicadores e melhoria contínua. Ele fortalece confiança, porque obriga o Estado a prestar contas, e a população passa a perceber que existe um caminho institucional para defender seus direitos.

Por isso, o Conselho não atua apenas reclamando problemas. Ele atua interrogando a política: qual é a regra, qual é a meta, qual é o orçamento, qual é o resultado, e quais correções serão feitas.

1.10 O ciclo decisório das políticas públicas e onde o Conselho entra

O **ciclo decisório** é o caminho pelo qual uma política nasce, se organiza, é executada e depois é avaliada. Na prática, o ciclo não é sempre linear, mas ele ajuda a conselheira e o conselheiro a identificar onde agir.

I. **Identificação do problema e formação da agenda -** A política começa quando um problema ganha visibilidade e passa a ser reconhecido como prioridade pública. Isso pode acontecer por pressão da comunidade, por dados epidemiológicos, por denúncias, por crises, por recomendações técnicas ou por compromissos de gestão. Aqui o Conselho tem força quando coloca o problema na pauta com evidências e relatos, tornando impossível ignorá-lo.



Fonte: JASB, 2022.

Diálogo com o educando



Fonte: Gemini / nano banana

Situação problema para reflexão e prática	
 Fonte: Autoria de IA.	A comunidade denuncia falta de médico e fechamento da unidade em alguns dias, mas o tema aparece e desaparece da pauta. O que pode ser feito para transformar a demanda em agenda permanente com prazos e retorno?

II. **Formulação de alternativas e tomada de decisão** - Uma vez reconhecido o problema, o Estado define caminhos possíveis. Essa etapa envolve escolhas e disputas, porque as soluções variam em custo, alcance e impacto. No SUS, essa etapa aparece em planos, programações anuais, pactuações e decisões administrativas. Aqui o Conselho deve perguntar quais opções foram analisadas, quais critérios foram usados, qual orçamento sustenta a decisão e quais metas serão monitoradas.

Diálogo com o educando



Fonte: Gemini / nano banana

Situação problema para reflexão e prática	
 Fonte: Autoria de IA.	A gestão decide reduzir horário de atendimento de uma unidade para "adequar equipe". A comunidade sofre, mas a decisão é apresentada como inevitável.
Que alternativas o Conselho pode exigir que sejam estudadas? Redistribuição de profissionais? Apoio regional? Mudança de fluxo? Contratação emergencial?	

***

1.11 Quais dados devem sustentar a escolha?

III. **Implementação e execução** - É quando a política vira ação. Aqui aparecem as falhas mais comuns: falta de recursos, falta de equipe, problema de logística, baixa coordenação, fragilidades de informação e barreiras de acesso. É também aqui que uma política bem escrita pode se perder na prática. O Conselho deve acompanhar a execução com indicadores simples, prazos e verificação de barreiras reais.

Diálogo com o educando



Fonte: Autoria de IA.

Situação problema para reflexão e prática	
 Fonte: Autoria de IA.	O município anuncia "programa de redução de filas", mas não publica critérios, não informa fila real, não apresenta metas. O Conselho aceita a narrativa.
O que precisa ser solicitado para verificar se houve implementação real?	

***

IV. Monitoramento e avaliação - Monitorar é acompanhar continuamente se a política está andando e se está produzindo resultados. Avaliar é julgar se ela está funcionando, se é justa, se precisa de correção, se deve ser ampliada ou substituída. No SUS, monitoramento e avaliação aparecem em relatórios, indicadores, auditorias, ouvidorias e dados de produção. Para o Conselho, essa etapa é decisiva porque é onde se cobra prestação de contas.

Quadro 2 – Diferença entre Monitoramento e Avaliação em Saúde.

Monitoramento	Avaliação
Acompanhamento sistemático sobre as características da política e da condição de saúde	Julga os serviços em um determinado local e período de tempo
Produz informações para a realização de uma avaliação	Analisa se o serviço ou política de saúde melhorou ou não a condição de saúde
Supervisão contínua de um serviço de saúde ou uma política	Utiliza dados coletados de indicadores de saúde
Verifica se os planos e processos estão sendo seguidos	Verifica se as metas estipuladas foram atendidas

Fonte: As autoras

Monitorar e avaliar não exige apenas números sofisticados. Exige dados simples, transparentes e periódicos. Por exemplo, tempo médio de espera, número de faltas, oferta versus demanda, cobertura territorial, taxa de retorno, satisfação do usuário, e registro de barreiras de acesso.

Diálogo com o educando



Fonte: Autoria de IA.

Situação problema para reflexão e prática	
 Fonte: Autoria de IA.	A gestão apresenta “muitos números”, mas não responde ao essencial: quem ficou sem atendimento, por que, e o que vai mudar.
Como o Conselho pode exigir uma avaliação que seja compreensível e que responda ao direito à saúde?	

***

V. **Revisão, correção e reinício do ciclo** - Depois de monitorar e avaliar, a política deve ser corrigida. Quando isso não ocorre, a gestão se acostuma a repetir falhas e a população perde confiança. A correção pode significar reorganizar fluxos, redefinir metas, ampliar equipe, mudar critérios de acesso, fortalecer regulação, ajustar orçamento e melhorar transparência. O Conselho deve transformar a avaliação em deliberação com encaminhamentos claros, prazos e devolutiva pública

Diálogo com o educando



Fonte: Autoria de IA.

Situação problema para reflexão e prática	
 Fonte: Autoria de IA.	O Conselho reconhece que a fila de especialidades é injusta, mas não define plano de correção. Passam seis meses e tudo continua igual.
Que tipo de encaminhamento mínimo deveria existir para fechar o ciclo?	

***

2 DESAFIOS PARA A EFETIVA PARTICIPAÇÃO POPULAR E O CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS

Mesmo com a força normativa do SUS, há desafios persistentes. Um deles é a desigualdade no acesso à informação. Quando dados, orçamento e decisões ficam restritos a poucas pessoas, a participação tende a se tornar simbólica. Outro desafio é a burocratização. Reuniões com linguagem excessivamente técnica, pautas extensas e pouco vínculo com problemas reais do território afastam conselheiros e comunidade.

Há também desafios políticos, como tentativas de capturar o Conselho, desvalorizar deliberações, limitar acesso a informações, pressionar conselheiros e transformar o espaço colegiado em instância de homologação. Além disso, a heterogeneidade da sociedade civil, com disputas internas, interesses distintos e desigual capacidade de organização, pode fragilizar a representatividade.

Para enfrentar esses desafios, o controle social precisa de formação permanente, organização, métodos de trabalho, rotinas de monitoramento e forte conexão com as comunidades, com devolutiva pública, porque a legitimidade do Conselho não nasce do regimento, mas do vínculo real com a vida coletiva.

Diálogo com o educando



Fonte: Autoria de IA.

Situação problema para reflexão e prática	
 Fonte: Autoria de IA.	O Conselho aprova várias deliberações, mas a comunidade não sabe. Meses depois, os mesmos problemas retornam e as pessoas dizem que “o Conselho não faz nada”.
Como você organizaria um modelo de devolutiva pública contínua, simples e acessível, para fortalecer legitimidade e participação?	

***

2.1 Desafios das instâncias colegiadas formais e informais

As **instâncias colegiadas formais**, como os Conselhos de Saúde e as Conferências, enfrentam desafios que comprometem sua efetividade como espaços democráticos. Um deles é a representação social limitada. Muitas vezes, os conselheiros representam segmentos restritos da sociedade, com pouca conexão com os territórios mais vulnerabilizados, como populações periféricas, rurais, tradicionais, indígenas e quilombolas.

Outro desafio é a rotatividade excessiva dos conselheiros, sem processos sistemáticos de formação inicial e continuada. A ausência de uma política permanente de educação para o controle social gera descontinuidade, fragiliza a memória institucional e dificulta a consolidação de uma atuação técnica e politicamente qualificada.

HÁ também dificuldades na articulação regional dos Conselhos, especialmente em regiões de saúde que envolvem vários municípios. A ausência de espaços efetivos de integração regional limita a capacidade de enfrentamento de problemas que ultrapassam os limites municipais, como a regulação de especialidades, a oferta de leitos e o transporte sanitário.

As **instâncias colegiadas informais**, como fóruns populares, associações comunitárias, coletivos territoriais, movimentos sociais e redes de usuários, desempenham papel fundamental na mobilização social e na construção de agendas públicas. No entanto, enfrentam desafios relacionados à precariedade organizativa, à dependência de lideranças individuais e à ausência de reconhecimento institucional.

Muitas dessas instâncias atuam de forma voluntária, sem apoio financeiro ou técnico, o que limita sua capacidade de acompanhamento sistemático das políticas públicas. Além disso, frequentemente não conseguem dialogar de forma estruturada com os Conselhos de Saúde, perdendo a oportunidade de transformar demandas territoriais em deliberações institucionais.

Outro desafio importante é a fragmentação das pautas e das lutas, que dificulta a construção de agendas comuns e a articulação em escala municipal, regional e estadual. Sem integração entre participação comunitária e controle social institucional, as demandas tendem a se dispersar e perder força política.

Diálogo com o educando



Fonte: Autoria de IA.

<table>
<tr><th colspan="2">Situação problema</th></tr>
<tr><td> 

Fonte: Autoria de IA.</td><td>Um coletivo de usuários denuncia a falta de medicamentos em uma unidade, mas não consegue ser ouvido pela gestão.
O Conselho toma conhecimento informalmente, mas não pauta o tema.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Como transformar essa denúncia em deliberação pública?</td></tr>
</table>

***

2.2 Desafios políticos, culturais e institucionais

A efetivação da participação popular e do controle social também enfrenta desafios de ordem política e cultural. A cultura autoritária ainda presente em muitas gestões públicas dificulta o reconhecimento da sociedade como parceira legítima na condução das políticas. Soma-se a isso a naturalização das desigualdades sociais, que leva parte da população a não se reconhecer como sujeito de direitos. Além disso, a crescente terceirização da saúde, a expansão do setor privado e a disputa por recursos públicos tensionam permanentemente o caráter universal do SUS. Nesse cenário, o controle social se torna ainda mais necessário para proteger o sistema público contra processos de privatização indireta, terceirizações predatórias e captura do fundo público.

2.3 O Desafio permanente da construção democrática do SUS

A participação popular e o controle social não são conquistas consolidadas, mas processos em permanente construção. Eles exigem investimento contínuo em formação política, fortalecimento institucional dos Conselhos, ampliação dos espaços de diálogo com a sociedade, transparência ativa da gestão e compromisso ético com o interesse público.

Para a conselheira e o conselheiro de saúde, atuar nesse campo significa assumir o papel de mediador entre o Estado e a sociedade, articulador de demandas territoriais, defensor do direito à saúde e guardião do caráter público e universal do SUS. Significa também compreender que cada reunião, cada deliberação, cada parecer e cada relatório são instrumentos de construção democrática. O desafio da participação popular e do controle social é, portanto, o desafio de sustentar o SUS como política de Estado e como patrimônio social da população brasileira.

BIBLIOGRAFIA

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil**: texto constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988, compilado até a Emenda Constitucional no 116/2022. Brasília, DF: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2022. 435 p. ISBN: 978-65-5676-185-5. Disponível em: https://www.gov.br/defesa/pt-br/acesso-a-informacao/governanca/governanca-do-setor-de-defesa/legislacao-basica-1/arquivos/2022/constituicao-da-republica-federativa-do-brasil.pdf/view. Acesso em: 15 jan. 2026.

BRASIL. Lei 8080 de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, ano 128, n. 182, p. 18055-18059, 20 set. 1990. Disponível em: https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=1&data=20/09/1990. Acesso em: 12 jan. 2026.

BRASIL. Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, ano 128, n. 249, p. 25694 – 25695, 31 dez. 1990. Disponível em: https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=4&data=31/12/1990. Acesso em: 12 jan. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. **Política Nacional de Educação Popular em Saúde no SUS.** Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2013.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. **Participação social no SUS**: conceitos, desafios e práticas. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2014.

FIOCRUZ. **O que é o SUS.** Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz, 2019. Disponível em: https://fiocruz.br/livro/que-e-o-sus-e-book-interativo-o. Acesso em: 12 jan. 2026.

FLEURY, Sônia; OUVERNEY, Assis Mafort. Política de saúde: uma política social. *In*: GIOVANELLA, Ligia et al. (org.). **Políticas e sistema de saúde no Brasil.** 2. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2012.

GERSCHMAN, Silvia. **Democracia, políticas sociais e reforma sanitária.** Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2004.

GIOVANELLA, Ligia et al. (org.). **Políticas e sistema de saúde no Brasil.** 2. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2012.

GOMES, José Felipe de Freitas; ORFÃO, Nathalia Halax. Desafios para a efetiva participação popular e controle social na gestão do SUS: revisão integrativa. **Saúde em Debate**, v. 45, p. 1199-1213, 2021.

LOPES, Ana Carolina de Freitas; SOÁREZ, Patrícia Coelho. Estado, sociedade civil e democracia na perspectiva da participação social para incorporação de tecnologias no SUS. **Boletim do Instituto de Saúde**, São Paulo, v. 25, n. 2, p. 21–27, 2024.

MOROSINI, Márcia Valéria Guimarães Cardoso; FONSECA, Angélica Ferreira (org.). **Educação popular em saúde**: desafios atuais. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2018.

NÚCLEO TELESSAÚDE SC UFSC. **Apostila de participação comunitária e controle social no SUS.** Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2022.

SANTOS, Boaventura de Sousa. **A difícil democracia**: reinventar as esquerdas. São Paulo: Boitempo, 2016.

SILVA, Silvio Fernandes da; LIMA, Luciana Dias de. **Estado, democracia e políticas públicas no Brasil.** Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2020.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO. UNA-SUS/UFMA. **A Atenção à Saúde Organizada em Redes.** São Luís, 2018. Acesso em 15 de fevereiro de 2026. Disponível em: https://repocursos.unasus.ufma.br/redes-atencao-saude-2018/modulo1/ebook/13.html. Acesso em: 15 jan. 2026.

TEXTO 2 - CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO À SAÚDE NO BRASIL

Este capítulo ajuda você a entender por que o **direito à saúde** no Brasil não nasceu pronto nem foi "presente do Estado", ele resultou de disputas sociais, de denúncias sobre desigualdades e de uma construção coletiva que ganhou forma institucional na **Seguridade Social** da **Constituição Federal de 1988 (CF 1988)** e no **Sistema Único de Saúde (SUS)**. Ao longo da história, o acesso à saúde refletiu relações sociais marcadas por desigualdades de classe, raça, etnia, gênero e território, e isso não ficou no passado, porque parte dessas marcas ainda reaparece nas filas, nos vazios assistenciais e na diferença de oferta entre bairros e regiões.



Fonte: https://laps.ensp.fiocruz.br/linha-do-tempo/57

3 A ORIGEM E A HISTORICIDADE DA SEGURIDADE SOCIAL: DA PROTEÇÃO RESTRITA AO DIREITO SOCIAL UNIVERSAL

Para compreender o **Sistema Único de Saúde (SUS)** como uma conquista social e política, é fundamental reconhecer que, durante grande parte da história brasileira, a saúde não foi tratada como direito, mas como privilégio.

A **Seguridade Social** não surge de forma espontânea na Constituição Federal de 1988. Ela é resultado de um longo processo histórico de disputas em torno da proteção social, marcado por conflitos entre projetos de sociedade, modelos de Estado e concepções de cidadania. Sua origem está vinculada às transformações do capitalismo industrial e às lutas da classe trabalhadora por proteção contra os riscos sociais produzidos pelo próprio modelo de desenvolvimento econômico.

No mundo, os primeiros sistemas de proteção social surgem no final do século XIX, especialmente na Alemanha de Bismarck, com os seguros sociais obrigatórios para trabalhadores, baseados na contribuição individual e no vínculo empregatício. Esse modelo foi difundido internacionalmente e estruturou o chamado sistema de seguro social, no qual a proteção é um benefício condicionado ao trabalho formal. Mais tarde, após a Segunda Guerra Mundial, países europeus como Inglaterra e França passam a construir sistemas de proteção social mais amplos, baseados na ideia de cidadania social, como propôs o Plano Beveridge, dando origem ao chamado Estado de Bem-Estar Social.

No Brasil, a proteção social se desenvolveu de forma tardia, fragmentada e profundamente desigual. Durante a Primeira República e boa parte do século XX, a política social foi organizada sob a lógica do seguro social contributivo, restrito aos trabalhadores do mercado formal. A **criação das Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPS)** em 1923 e, posteriormente, dos **Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPS)** nos anos 1930, representou a institucionalização de um modelo que vinculava direitos sociais ao vínculo empregatício.

Esse sistema consolidou um padrão excludente de cidadania. Apenas quem tinha carteira assinada tinha direito à previdência e à assistência médica. A maioria da população brasileira, composta por trabalhadores rurais, informais, desempregados, mulheres fora do mercado formal, população negra e comunidades tradicionais, permanecia fora da proteção estatal e dependia da filantropia, da caridade ou de serviços públicos precários.

Durante o regime empresarial-militar, a unificação dos institutos no **Instituto Nacional de Previdência Social (INPS)** e a posterior criação do **Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS)** reforçaram a centralização do sistema e a compra de serviços privados com recursos públicos, consolidando um modelo médico-previdenciário-privatista que aprofundou as desigualdades no acesso à saúde. Esse modelo expressava uma concepção de sociedade em que os direitos sociais não eram universais, mas privilégios corporativos. **A saúde era tratada como mercadoria, benefício ou favor, e não como direito.**

É somente a partir das lutas sociais dos anos 1970 e 1980, no contexto da redemocratização do país, que se constrói no Brasil uma nova concepção de proteção social, baseada na ideia de **Seguridade Social**. Inspirado nas experiências internacionais de **Estados de bem-estar** e nas reflexões críticas da saúde coletiva latino-americana, o **Movimento da Reforma Sanitária Brasileira** passa a defender um sistema de proteção social integrado, universal, solidário e financiado por toda a sociedade.



Fonte: Manifestação Pró-Constituinte Foto: Erik B. Pinto (Acervo Radis) https://abrasco.org.br/fomos-rebeldes-e-revolucionarios-esquentaabrascao-debatera-saude-coletiva/

Essa concepção rompe com a lógica do seguro social e afirma que os riscos sociais não são individuais, mas coletivos. Doença, velhice, desemprego, pobreza e deficiência não são falhas pessoais, mas expressões das condições de vida produzidas pela organização econômica e social. Por isso, a proteção contra esses riscos deve ser responsabilidade do Estado e da sociedade.

A **Constituição Federal de 1988** materializa esse novo projeto de sociedade ao instituir, pela primeira vez na história brasileira, a Seguridade Social como um sistema integrado de saúde, previdência e assistência social, financiado por múltiplas fontes e orientado pelos princípios da universalidade, da equidade, da solidariedade e da justiça social.

Ao inscrever a saúde no interior da Seguridade Social, a Constituição rompe definitivamente com a herança excludente do modelo previdenciário e afirma a saúde como direito de cidadania. O SUS nasce, portanto, como parte de um pacto civilizatório que busca enfrentar as desigualdades históricas do país e reconstruir a democracia a partir da garantia de direitos sociais.



Fonte: SINPOJUD

Toda essa trajetória histórica importa para a conselheira e para o conselheiro porque ela explica por que **o SUS não é um programa focal para "pobres"**, mas uma política pública de cidadania, estruturada para enfrentar desigualdades históricas e garantir acesso universal, com organização pública, participação social e responsabilidades compartilhadas. A leitura histórica também ajuda a entender que o acesso à saúde sempre espelhou uma sociedade escravocrata e de classes, na qual a cidadania era restrita, e por que a CF 1988 reposiciona a saúde como direito e dever do Estado, com base em políticas sociais e econômicas e não apenas em serviços assistenciais.

Diálogo com você, conselheira e conselheiro



Fonte: Autoria de IA.

Situação problema	
 Fonte: Autoria de IA.	Em uma reunião comunitária, um médico afirma que "antigamente era melhor, porque quem contribuía tinha direito e quem não contribuía não pesava para o sistema".
Como essa fala expressa a lógica excludente do antigo modelo previdenciário? Como você explicaria que o SUS nasce justamente para romper com essa injustiça histórica?	

***

3.1 Reforma sanitária brasileira e a conquista política do SUS

A Reforma Sanitária Brasileira (RSB) pode ser entendida como movimento político e social que se articula com a luta contra a ditadura e com a abertura democrática, e que defende a saúde como direito de cidadania, com sistema público universal, descentralizado e com participação social.

Esse movimento não nasce em gabinetes, ele se fortalece em universidades, serviços, sindicatos, comunidades, entidades e espaços de formulação crítica do campo da saúde coletiva, e se transforma em projeto capaz de disputar o Estado e produzir mudanças institucionais. A ideia de "reforma" aqui não é ajuste técnico, é reposicionamento do que significa saúde, ampliando o olhar para condições de vida e reconhecendo desigualdades como determinantes do adoecimento.

A partir da década de 1970, em meio ao agravamento das desigualdades sociais e ao aprofundamento da crise econômica, começa a se formar no Brasil um amplo movimento crítico ao modelo de saúde vigente. Esse movimento reúne profissionais da saúde, pesquisadores, docentes universitários, trabalhadores do setor, sindicatos, entidades científicas, organizações populares e setores progressistas da sociedade civil.

Esse processo ficou conhecido como **Movimento da Reforma Sanitária Brasileira (RSB)**. Com a força da luta popular por acesso à saúde houve enfrentamentos históricos, especialmente das populações colocadas à margem, como trabalhadoras e trabalhadores negros, indígenas, mulheres, moradores de periferias urbanas e de áreas rurais, que se organizaram para resistir a um sistema que não os reconhecia plenamente como cidadãos.

Essa lembrança é pedagógica e política ao mesmo tempo, porque impede que a conselheira e o conselheiro naturalizem desigualdades atuais como se fossem apenas "dificuldades de gestão", quando muitas vezes são continuidade de estruturas sociais.

A **Reforma Sanitária** não foi uma proposta técnica de reorganização do sistema de saúde. Ela se constituiu como um **projeto político de transformação social**, articulado à luta pela redemocratização do país. Para os sanitaristas, não era possível garantir saúde sem democracia, e não era possível construir democracia sem garantir direitos sociais.

Inspirado pelas experiências internacionais de sistemas universais e pelas reflexões críticas da medicina social latino-americana, o movimento defendia uma concepção ampliada de saúde, entendida como resultado das condições de vida e trabalho, do acesso à educação, à

moradia, ao saneamento, ao transporte, à alimentação e à renda. A saúde passou a ser compreendida como expressão da organização social e econômica da sociedade.



Fonte: Fiocruz.

Nesse contexto, surgem instituições fundamentais para a formulação das propostas do SUS, como o **Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes)** e a **Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco)**. Esses espaços produziram conhecimento crítico, formularam propostas e articularam politicamente a defesa de um sistema público, universal, integral e democrático.

ABRASCO

cebes
Centro Brasileiro de Estudos de Saúde

Fonte: Associação Brasileira de Saúde Coletiva, 2026.

O marco político mais importante desse processo foi a realização da **8ª Conferência Nacional de Saúde (8ª CNS)**, em março de 1986. Pela primeira vez na história, uma conferência nacional de saúde contou com ampla participação da sociedade civil, reunindo milhares de delegados de todo o país, representantes de movimentos populares, trabalhadores da saúde, gestores públicos, pesquisadores e parlamentares.

A 8ª CNS rompeu com a tradição tecnocrática e autoritária das conferências anteriores e se tornou um espaço de deliberação política. Seu relatório final estabeleceu as bases do que

viria a ser o SUS, afirmando de forma categórica que saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida por políticas econômicas e sociais.



Fonte: Ministério da Saúde.

A 8ª CNS foi convocada e realizada em 1986, sob a presidência de **Sérgio Arouca**, e reuniu mais de quatro mil participantes, com ampla representação de diferentes segmentos sociais. Ao final do processo, foram sistematizadas propostas centrais para a política de saúde no Brasil, que orientaram a Reforma Sanitária e a construção do SUS.

Entre as principais deliberações, destacaram se:

- ✓ Universalização da saúde como direito de todos e dever do Estado, com caráter essencialmente público;
- ✓ **Reformulação do Sistema Nacional de Saúde**, incluindo a criação de um comando único, a transferência do INAMPS para o Ministério da Saúde e a separação progressiva dos recursos da previdência e do financiamento da saúde;
- ✓ Proposta da **criação da Comissão Nacional da Reforma Sanitária**, com a finalidade de subsidiar os debates sobre a política de saúde na Assembleia Nacional Constituinte;
- ✓ Defesa de expansão e o fortalecimento do setor estatal nos níveis federal, estadual e municipal, com a perspectiva de ampliação progressiva da atuação pública;
- ✓ **Controle dos prestadores privados**, subordinando os serviços à direção do Estado e assegurando a participação dos usuários por meio de suas organizações representativas.

Diálogo com você, conselheira e conselheiro



Fonte: Autoria de IA.

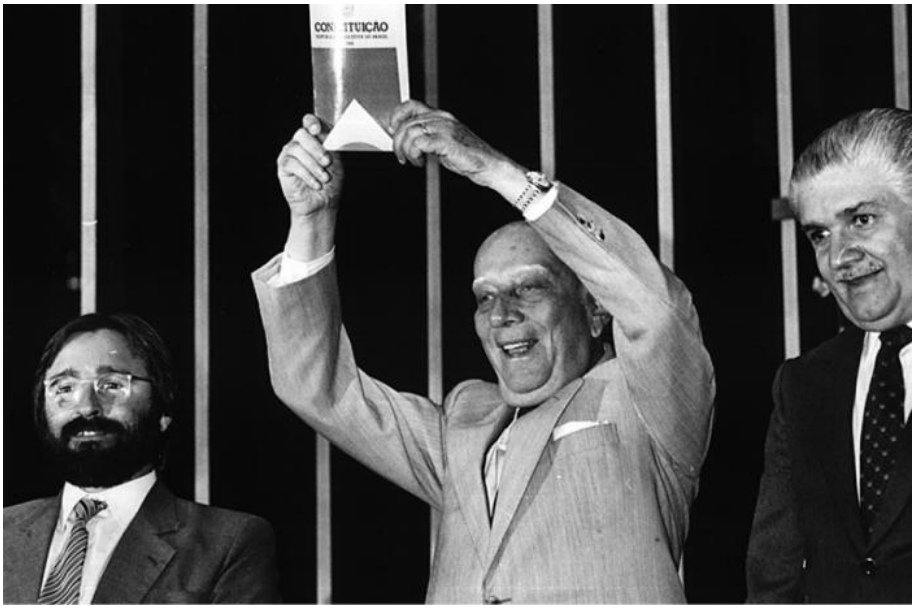
Situação problema	
 Fonte: Autoria de IA.	Em uma formação para novos conselheiros, percebe-se que muitos acreditam que o SUS foi criado apenas por iniciativa governamental.
Como o Conselho pode resgatar a memória da Reforma Sanitária e da 8ª CNS para fortalecer o compromisso político com a defesa do sistema?	

***

3.2 A Constituição de 1988 e a institucionalização do direito à saúde

A **Assembleia Nacional Constituinte (ANC)** de 1987 a 1988 foi o espaço em que as propostas da Reforma Sanitária se transformaram em normas jurídicas. A atuação articulada dos sanitaristas, dos movimentos sociais e das entidades científicas foi decisiva para a inclusão da saúde no capítulo da **Seguridade Social** e para a formulação dos artigos que criaram o SUS.

Sessão de aprovação da Constituição de 1988



Fonte: Acervo SEDI/CD.

A **Constituição Federal de 1988 (CF/88)** reconhece a saúde como direito social fundamental e estabelece que ela é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços.

A criação do SUS rompe definitivamente com a lógica do seguro social e institui um sistema público de acesso universal, financiado por toda a sociedade, com base nos princípios da universalidade, da integralidade e da equidade, e organizado de forma descentralizada, regionalizada e participativa.



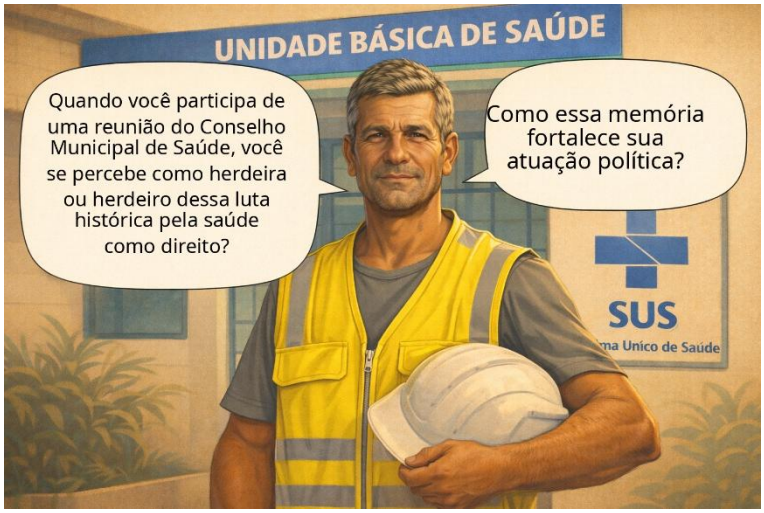
Fonte: Autoria de IA.

A saúde passa a integrar o sistema de Seguridade Social, ao lado da previdência e da assistência social, consolidando um modelo de proteção social baseado na solidariedade e na justiça social.



Fonte: CEDI - Câmara dos Deputados

Diálogo com você, conselheira e conselheiro



Fonte: Autoria de IA.

Situação problema	
 Fonte: Autoria de IA.	O município anuncia a ampliação de contratos com hospitais privados enquanto reduz investimentos na rede pública do SUS.
Como essa decisão dialoga com a história de mercantilização da saúde no Brasil? Que posicionamento político o conselho deve assumir diante desse cenário?	

***

3.3 O SUS como conquista popular, política pública e patrimônio social

O SUS não é apenas uma política pública. Ele **é uma conquista popular** construída por décadas de lutas sociais, mobilizações, produção científica e resistência política. Trata-se de um dos maiores sistemas universais de saúde do mundo e da maior política de inclusão social da história brasileira.

Ao longo de mais de três décadas, o SUS tem garantido avanços expressivos na ampliação do acesso, na redução da mortalidade infantil, na expansão da cobertura vacinal, no enfrentamento de epidemias, na interiorização dos serviços e na construção de uma rede pública capilarizada em todo o território nacional.

No entanto, o SUS segue enfrentando desafios estruturais relacionados ao subfinanciamento crônico, à precarização do trabalho em saúde, à pressão do setor privado e às profundas desigualdades sociais que atravessam o país.

Ser conselheira ou conselheiro de saúde é assumir o compromisso com a defesa desse patrimônio social, acompanhando sua gestão, fiscalizando o uso dos recursos públicos e lutando para que o direito à saúde não seja reduzido a mercadoria. Como afirma Jairnilson Paim, compreender o SUS é compreender uma construção histórica marcada por disputas, resistências e lutas permanentes em defesa da vida e da democracia.

Diálogo com você, conselheira e conselheiro



Fonte: Autoria de IA.

Situação problema	
 Fonte: Autoria de IA.	Durante uma audiência pública, vereadores defendem a privatização de unidades básicas de saúde como solução para a crise do sistema.
Como essa proposta dialoga com a história da saúde no Brasil? **Quais argumentos históricos, políticos e técnicos você utilizaria para defender o SUS público?**	

***

3.4 Considerações finais

A construção histórica do **direito à saúde no Brasil é inseparável da luta pela democracia, pela justiça social e pela cidadania**. Do modelo excludente do seguro social à consolidação da Seguridade Social, da resistência popular à Reforma Sanitária, da 8ª CNS à criação do SUS, o que se afirma é um projeto civilizatório baseado na dignidade humana.

O SUS é fruto da luta do povo brasileiro. Ele não nasceu pronto, não está garantido para sempre e depende, cotidianamente, da atuação consciente, crítica e comprometida das conselheiras e dos conselheiros de saúde. Defender o SUS é defender a democracia.

BIBLIOGRAFIA

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil**: texto constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988, compilado até a Emenda Constitucional no 116/2022. Brasília, DF: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2022. 435 p. Disponível em: https://www.gov.br/defesa/pt-br/acesso-a-informacao/governanca/governanca-do-setor-de-defesa/legislacao-basica-1/arquivos/2022/constituicao-da-republica-federativa-do-brasil.pdf/view. Acesso em: 15 jan. 2026.

BRASIL. Lei 8080 de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, ano 128, n. 182, p. 18055-18059, 20 set. 1990. Disponível em: https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=1&data=20/09/1990. Acesso em: 12 jan. 2026.

BRASIL. Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, ano 128, n. 249, p. 25694 – 25695, 31 dez. 1990. Disponível em: https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=4&data=31/12/1990. Acesso em: 12 jan. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. **Política Nacional de Educação Popular em Saúde no SUS.** Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2013.

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (Fiocruz). **Construção histórica do SUS:** princípios e diretrizes: curso de especialização em preceptoria para educação profissional em saúde com ênfase na Atenção Primária à Saúde e Vigilância em Saúde. Brasília, DF: CONASEMS, 2025.

CHAGAS, Juliana; TORRES, Raquel. **Do seguro à Seguridade Social.** EPSJV Fiocruz, 1 set. 2008. Atualizado em 1 jul. 2022. Disponível em: https://www.epsjv.fiocruz.br/noticias/reportagem/do-seguro-a-seguridade-social. Acesso em: 13 jan. 2026.

GIOVANELLA, Lígia; ESCOREL, Sarah; LOBATO, Lenaura de Vasconcelos Costa; NORONHA, José Carvalho de; et al. **Políticas e sistema de saúde no Brasil.** 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2012. *E-book*. Disponível em: https://fiocruz.br/livro/politicas-e-sistema-de-saude-no-brasil. Acesso em: 13 jan. 2026.

PAIM, Jairnilson Silva et al. **O Que É o SUS**: e-book interativo. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2015. 93 p. Disponível em: https://fiocruz.br/livro/que-e-o-sus-e-book-interativo-o. Acesso em: 8 jan. 2026.

PAIVA, Carlos Henrique Assunção; TEIXEIRA, Luiz Antonio. **A reforma sanitária e a criação do Sistema Único de Saúde.** História, Ciências, Saúde, Manguinhos, Rio de Janeiro, 2014.

TEXTO 3 - A criação e a implementação do SUS

4 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E LEIS 8.080 DE 1990 E 8.142 DE 1990

Conversa inicial com você, conselheira ou conselheiro

O SUS nasce de uma ideia simples e forte: **todas as pessoas têm direito à saúde**. Esse direito não depende de "merecimento", de pagar previdência, de provar pobreza, nem do dinheiro no bolso. Também não depende de caridade. O SUS parte de uma visão de **seguridade social**, que supõe uma sociedade solidária e democrática, com valores de igualdade e equidade, sem privilégios.

Para reflexão! Chega ao conselho uma mãe dizendo que não conseguiu consulta para seu filho porque "não tem plano" ou dinheiro para pagar consulta. O SUS existe exatamente para não aceitar essa lógica como normal. Quando o SUS funciona, o acesso acontece **por direito**, não por favor. Saúde não é mercadoria.

Diálogo com você, conselheira e conselheiro de saúde



Fonte: Autoria de IA.

4.1 O SUS na Constituição de 1988

Título VIII - Da Ordem Social - Capítulo II - Da Seguridade Social - Seção II - Da Saúde



Fonte: SINPOJUD

4.2 O que a Constituição garante e por que isso muda seu trabalho no conselho

Em 1988, a Constituição reconheceu a saúde como **direito social**, ligado à cidadania: **saúde é direito de todos e dever do Estado**. Isso não apareceu do nada. Foi resultado de lutas e esforços do Movimento da Reforma Sanitária, especialmente entre 1976 e 1988.

A Constituição não fala apenas “atender doentes”. Ela define que o Estado deve garantir a saúde por meio de **políticas sociais e econômicas**, com redução de riscos e com acesso universal e igualitário às ações e serviços para **promoção, proteção e recuperação** da saúde.

4.3 Artigo 196 - A saúde como direito e dever do Estado.

O Art. 196 diz que o dever do Estado se cumpre com políticas sociais e econômicas que reduzam o risco de doença e de outros agravos e assegurem acesso universal e igualitário às ações e serviços para promover, proteger e recuperar a saúde.

Na prática do conselho: Quando o conselho cobra melhoria do transporte sanitário, reforço de equipe na UBS, acesso a exames, ou ações de prevenção em áreas de risco, isso é Art. 196 virando realidade.

Exemplo: Na sua cidade, aumentaram acidentes de moto e atendimentos no hospital. O Art. 196 ajuda a perguntar: o município está fazendo só atendimento do trauma ou também políticas para reduzir risco, como educação no trânsito, iluminação, fiscalização, organização do SAMU e da regulação?

4.4 Artigo 197 - As ações e serviços de saúde são de relevância pública.

O Art. 197 afirma que as ações e serviços de saúde são de relevância pública. O poder público deve regulamentar, fiscalizar e controlar, e pode executar diretamente ou por terceiros.

Na prática do conselho: Aqui entra uma pergunta objetiva: quando o serviço é terceirizado, conveniado ou contratado, a qualidade e o acesso seguem o interesse público ou viram um produto? O conselho atua exigindo transparência, metas, indicadores, filas, ouvidoria, regulação e fiscalização. Saúde não é mercadoria.

Reflexão!

No seu território, quais serviços de saúde são diretamente públicos e quais são contratados? O que muda para o usuário quando muda o gestor do serviço?

4.5 Artigo 198 - A rede do SUS e suas diretrizes.

O Art. 198 afirma que ações e serviços públicos de saúde integram uma **rede regionalizada e hierarquizada** e constituem um sistema único, com diretrizes como descentralização, atendimento integral com prioridade para ações preventivas e participação da comunidade.

Na prática do conselho: Rede regionalizada e hierarquizada significa: o cuidado tem portas de entrada, caminhos e referências. A pessoa não deveria "peregrinar" de serviço em serviço. A prevenção não é enfeite. Ela precisa aparecer no planejamento e no financiamento. E participação da comunidade não é simbólica: é controle social ativo.

Situação problema: A UBS encaminha para especialista, mas a pessoa não consegue vaga e fica meses esperando. O conselho pode pedir: como está a regulação? qual tempo médio? quais critérios? há fila única? há transparência? há pactuação com a região?

4.6 Artigo 199 - A assistência à saúde e a iniciativa privada.

O Art. 199 afirma que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, dentro de regras.

Na prática do conselho: Este artigo exige atenção constante para o risco de o interesse do mercado disputar o rumo do sistema. Controle social significa vigiar para que o SUS não vire um "resto" para quem não pode pagar e para que as parcerias não enfraqueçam a universalidade.

4.7 Artigo 200 - Competências do SUS.

O Art. 200 lista atribuições do SUS como fiscalização, vigilâncias, saúde do trabalhador e da trabalhadora, participação em saneamento, formação de recursos humanos, ciência e tecnologia e outras ações. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:

I. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos
II. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador e da trabalhadora
III. Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde
IV. Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico
V. Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação
VI. Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano
VII. Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos
VIII. Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

Para reflexão! O SUS não é apenas consulta e hospital. Ele inclui vigilância sanitária e epidemiológica, saúde do trabalhador, controle de alimentos e água, e articulação com saneamento. Se há surto de diarreia por água contaminada, isso não é "problema fora da saúde". É SUS.

4.8 Promover, Proteger e Recuperar

A tríade que organiza o dever do Estado e também a cobrança do conselho.

A Constituição usa três verbos para organizar o SUS: Promover, Prevenir e recuperar.



4.8.1 Promoção da saúde

Promoção é fortalecer a vida. Envolve ações gerais que aumentam qualidade de vida das pessoas e das comunidades. Entra aqui educação, alimentação, atividade física, lazer, cultura, paz, ambiente saudável e outras condições que fazem a saúde melhorar antes da doença aparecer.

Exemplo: Um conselho identifica aumento de depressão em adolescentes. Promoção não se resolve só com consulta. Pode incluir ações com escolas, esporte, cultura, apoio psicossocial, combate à violência e fortalecimento de vínculos comunitários.

4.8.2 Proteção da saúde

Proteção é reduzir ou eliminar riscos com medidas específicas. Pode incluir vacinação, controle de vetores, ações de vigilância, segurança no trânsito, controle de água e alimentos e medidas de prevenção para doenças e agravos.

Para refletir! Aumentou dengue no bairro. Proteção envolve vigilância, limpeza urbana articulada, orientação comunitária, controle de criadouros, organização do serviço para manejo de casos e proteção de grupos mais vulneráveis.

4.8.3 Recuperação da saúde

Recuperação exige diagnóstico precoce, tratamento oportuno e limitação de danos, evitando complicações e sequelas. Inclui atenção na comunidade, ambulatório, hospital e domicílio, de forma articulada.

Para refletir! Uma pessoa com diabetes não consegue insulina regularmente. Recuperação aqui é acesso contínuo ao tratamento, acompanhamento na APS, exames de rotina e rede organizada para evitar amputações e internações evitáveis.

4.8.4 Da Constituição para as leis do SUS

Por que a Constituição precisou da Lei 8.080 e da Lei 8.142 de 1990

A Constituição diz o que o Brasil escolhe como direito e dever. As leis detalham como organizar e como fazer acontecer.

Pense assim: a Constituição é o mapa do destino. As leis são as regras da estrada e o jeito de manter o caminho aberto.

4.10 Lei 8.080 de 1990 - Lei Orgânica da Saúde: organização, funcionamento e responsabilidades

A Lei 8.080 regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde e define bases para organização e funcionamento do SUS. Ela trata das condições para promoção, proteção e recuperação da saúde e da estrutura do sistema.

O que você precisa guardar para a prática do conselho. A lei ajuda o conselho a cobrar três coisas que quase sempre aparecem nos problemas reais do território:

a) **Organização do sistema e responsabilidades** - A lei orienta como o SUS se organiza e como as responsabilidades se distribuem. Isso ajuda a responder a uma pergunta comum em reuniões: “isso é do município, do estado ou da União?” Em vez de empurra empurra, o conselho pede fluxo, pactuação e compromisso.

b) **Ações e serviços como sistema, não como ilhas** - A lei reforça que serviços devem funcionar articulados. Quando a APS não consegue referência, quando exames atrasam, quando transporte falha, isso não é azar: é falha de organização.

4.10.1 O SUS é mais amplo que assistência

A lei dialoga com vigilâncias, saúde do trabalhador e da trabalhadora e outras frentes. Isso fundamenta o conselho quando precisa cobrar ações integradas e não apenas atendimento individual.

Situação problema: a fila invisível	
 Fonte: Autoria de IA.	Chegam ao conselho relatos de que "quem conhece alguém" consegue exame mais rápido.
Perguntas para o conselho conduzir 1 Que regra de regulação existe hoje no município? 2 Há fila única e critérios públicos? 3 O usuário consegue acompanhar sua solicitação? 4 O conselho tem acesso a relatórios de tempo de espera por procedimento?	

***

4.11 Lei 8.142 de 1990

4.11.1 Participação social e financiamento: o lugar formal do conselho e da conferência

O SUS é criado a partir da organização histórica dos movimentos populares, sanitários e sociais que, no processo de redemocratização do país, lutaram pela saúde como direito de todos e dever do Estado. Essa mobilização social foi decisiva para que a participação social se consolidasse como um pilar estruturante e fundante do SUS, incorporada de forma permanente à sua concepção, organização e gestão.

A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, regulamenta esse princípio constitucional ao dispor sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde, por meio das conferências e dos conselhos de saúde, e também sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, estabelecendo as bases legais para o controle social e para o financiamento tripartite do sistema. A Lei 8.142/1990 é a base legal direta para o controle social que você exerce.

4.11.2 Dois pilares para a atuação do conselho

4.11.2.1 Participação social com método e regra

A lei estabelece instâncias formais de participação, como conselhos e conferências de saúde. Isso significa que a participação popular não depende da boa vontade do gestor. Ela é obrigação legal.



Fonte: Ilibio & Vieira, 2022.

4.11.2.2 Recurso público com critério e transparência

Transferência de recursos entre governos precisa seguir regras. Para o conselho, isso vira uma pauta necessária: acompanhar plano, relatório, metas, execução e coerência entre necessidade do território e gasto.

Situação problema: orçamento que não conversa com o território	
 Fonte: Autoria de IA.	A comunidade pede há anos ampliar horário da UBS, mas o orçamento prioriza reforma estética de prédio administrativo.
Perguntas para o conselho conduzir 1 O Plano Municipal de Saúde prioriza o que a população aponta? 2 A Programação Anual de Saúde traduz o plano em ações? 3 O Relatório Anual de Gestão mostra resultado e gasto com clareza? 4 Que evidências do território o conselho pode levar para reorientar o gasto?	

Situação problema: conferência que vira evento e perde força	
 Fonte: Autoria de IA.	A conferência termina com propostas, mas nada volta para o conselho
Perguntas para o conselho conduzir 1 As propostas viraram deliberações com responsáveis e prazos? 2 O conselho criou uma rotina de monitoramento dessas deliberações? 3 O gestor apresenta devolutiva formal do que foi implementado?	

***

4.11.3 Onde você atua com protagonismo

O controle social como prática cotidiana, não como reunião

Você atua com protagonismo quando transforma princípios e leis em perguntas objetivas, pedidos de informação, recomendações e acompanhamento contínuo.



Fonte: Autoria de IA.

Perguntas que abrem caminho

1 Qual problema, quem é mais afetado, onde acontece, desde quando?

2 Qual serviço deveria responder, qual fluxo existe, onde travou?

3 Qual evidência temos, relato, mapa, fila, indicador, visita?

4 Qual decisão cabe ao conselho e qual encaminhamento precisa ser pactuado?



1. Escolham um problema real do território

2. Digam qual artigo da Constituição ajuda a fundamentar a cobrança

3. Digam qual lei ajuda a exigir organização, participação ou transparência

4. Escrevam 5 perguntas que o conselho fará ao gestor

5. Definam qual evidência o conselho vai buscar para acompanhar

***

4.12 Princípios e diretrizes do SUS

4.12.1 Entendendo o que é princípio e o que é diretriz no Sistema Único de Saúde

A Lei nº 8080 de 19 de setembro de 1990 organiza o funcionamento do Sistema Único de Saúde em todo o território brasileiro. Ela regulamenta o direito à saúde previsto na Constituição Federal de 1988 e define como o SUS deve funcionar na prática.

No Capítulo II da lei, intitulado "Dos Princípios e Diretrizes", o Artigo 7º apresenta um conjunto de fundamentos que orientam as ações e os serviços de saúde. No entanto, a própria lei não separa de forma explícita o que são princípios e o que são diretrizes. Tudo aparece reunido no mesmo artigo, o que gera confusão para muitos profissionais, gestores e conselheiros.

Por isso, é fundamental compreender corretamente essa distinção. Do ponto de vista técnico, jurídico e político, o SUS possui apenas três princípios estruturantes **Universalidade, Integralidade e Equidade.**

Esses três princípios estão na Constituição Federal e orientam toda a organização do sistema. Eles expressam os valores fundamentais do SUS e o sentido do direito à saúde no Brasil.

Todos os demais dispositivos apresentados no Artigo 7º da Lei 8080 são diretrizes organizativas. Ou seja, são orientações sobre como o sistema deve ser estruturado, planejado, gerido e executado para garantir os três princípios constitucionais. Em outras palavras, os princípios dizem qual é o direito. As diretrizes dizem como o Estado deve organizar o SUS para garantir esse direito.

4.12.2 Princípios e diretrizes do SUS

O que são princípios e diretrizes e por que essa diferença confunde tanta gente?

Quando lemos a Constituição e a Lei 8080, percebemos algo importante, pois a Constituição fala em diretrizes e a Lei 8080/1990 fala em princípios e diretrizes. Isso gera confusão. Mas a diferença é fundamental.

Podemos compreender assim:

	Respondam à pergunta
Princípios são os valores, as ideias centrais, as bases éticas e políticas do SUS. São aquilo que dá identidade ao sistema.	Que SUS queremos?
Diretrizes são os caminhos, as estratégias, os modos de organização. São os meios para colocar os princípios em prática	Como o SUS deve funcionar?
Princípios são a raiz, como se fossem os mandamentos da bíblia. Diretrizes são os caminhos, como se deve fazer para alcançar os princípios.	Como podemos contribuir para o SUS funcionar?

4.12.2 Os três princípios do SUS

O SUS é um sistema público de saúde criado para garantir um direito social. Esse direito está baseado em **três princípios** fundamentais.



Fonte**:** Ministério do Desenvolvimento Social, 2023.

A **universalidade** significa que todas as pessoas têm direito ao acesso aos serviços de saúde, sem qualquer tipo de discriminação. Não importa a renda, a cor da pele, a religião, a orientação sexual, a idade ou o local onde a pessoa mora. O SUS é para todos.



Fonte: Albuquerque, 2016.



Fonte: Cartão do SUS, 2026.

A **integralidade** significa que o cuidado em saúde deve ser completo. A pessoa não é apenas um corpo doente, mas um sujeito com história, família, trabalho, território e cultura. A integralidade envolve promoção da saúde, prevenção de doenças, tratamento e reabilitação, considerando as dimensões biológica, psicológica e social da vida.

A **equidade** significa tratar de forma diferente quem é diferente, reconhecendo que algumas populações vivem em condições mais vulneráveis. O SUS deve investir mais onde há mais necessidade. Isso inclui populações do campo, da floresta, indígenas, quilombolas, pessoas em situação de rua, pessoas com deficiência, mulheres vítimas de violência, crianças, idosos e territórios periféricos.

Esses três princípios são inseparáveis. Eles formam a base ética, política e social do Sistema Único de Saúde.

Diálogo com você, educando

Se um serviço atende apenas quem mora no território, **ele fere a universalidade.** Se atende sem olhar para a realidade da pessoa, **fere a integralidade.** Se trata desigualmente quem mais precisa, **fere a equidade.**

O papel do conselho é defender esses três princípios em todas as decisões da gestão.

4.12.4 As diretrizes do SUS

4.12.4.1 Como o sistema deve ser organizado para garantir os princípios

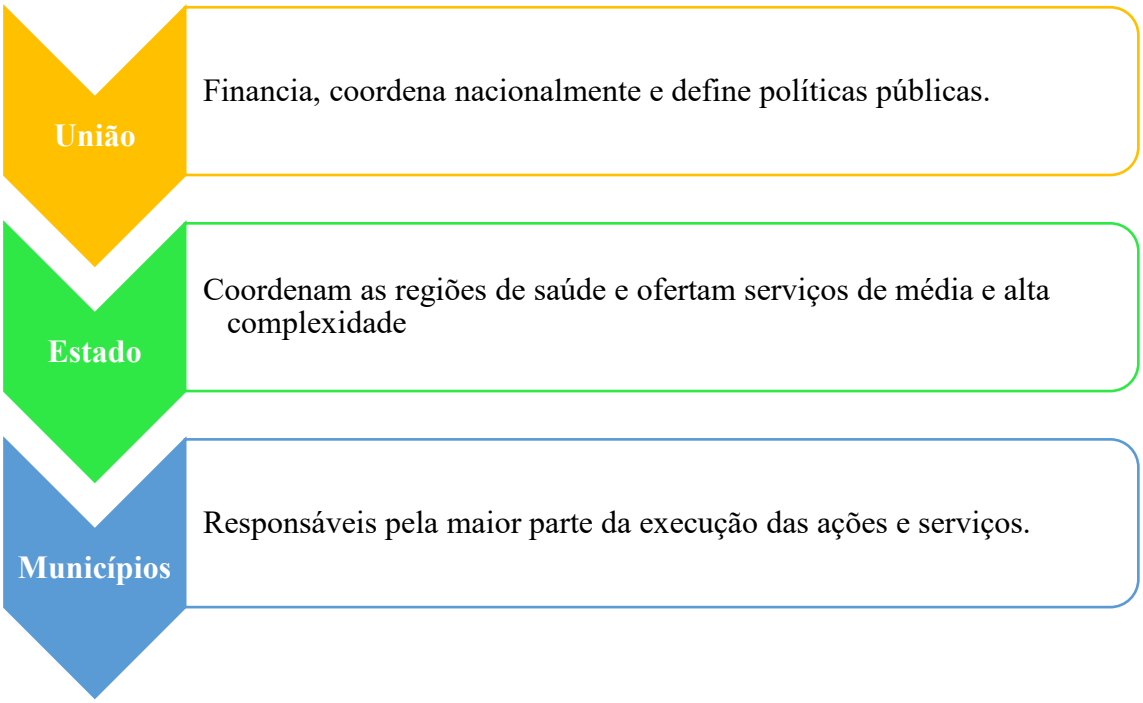
A Lei 8080/1990 estabelece diretrizes que orientam a organização e o funcionamento do SUS para alcançar os princípios. São essas diretrizes que estruturam a rede de serviços, a gestão, o planejamento, o financiamento e a participação social. As diretrizes não substituem os princípios, pois elas existem para tornar os princípios possíveis na vida real.
Entre as principais diretrizes do SUS previstas no Artigo 7º da Lei 8080/1990 estão:



Essas diretrizes mostram que o SUS não é apenas um conjunto de unidades de saúde. Ele é um sistema público organizado, planejado, financiado e controlado socialmente.

4.12.4.2 A descentralização como diretriz organizativa

A descentralização significa que o SUS é organizado em três esferas de governo: União, Estados e Municípios. Cada uma tem responsabilidades próprias.

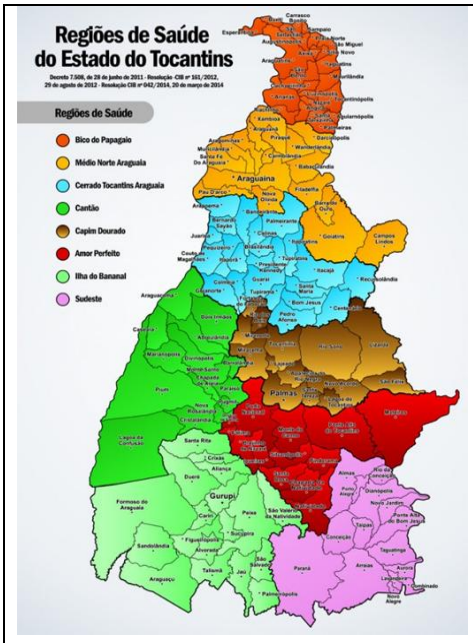


A descentralização aproxima o SUS da população. Permite que as decisões sejam tomadas mais perto dos territórios e das realidades locais.

Exemplo do cotidiano do conselho

Se falta médico na unidade básica, a responsabilidade é do município.
Se falta vaga de UTI, a responsabilidade é da região de saúde e do estado.
Se falta financiamento, a responsabilidade é também da União.
O conselho precisa saber quem cobrar.

4.12.4.3 Regionalização e hierarquização da rede

	O SUS é organizado em **regiões de saúde formadas por vários municípios.** Isso permite que os serviços sejam compartilhados e que a população tenha acesso a diferentes níveis de atenção.
	A hierarquização significa que os serviços são organizados por nível de complexidade, começando pela atenção básica e seguindo para os serviços especializados e hospitalares. A pessoa entra no SUS pela atenção básica e, quando necessário, é encaminhada para outros serviços da rede. Essa organização evita desperdício de recursos, melhora o acesso e garante continuidade do cuidado

4.12.4.4 Participação da comunidade como diretriz do sistema

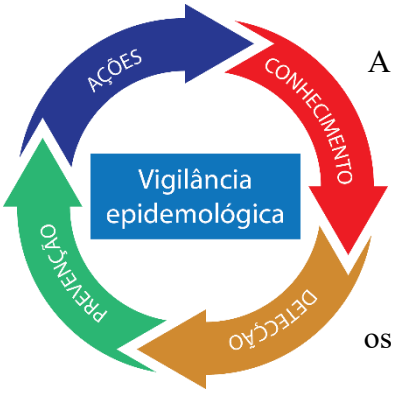


A participação social é uma diretriz legal do SUS. Ela não é opcional e está prevista na Constituição, na Lei 8080 e na Lei 8142. A população participa da gestão do SUS por meio dos conselhos e das conferências de saúde. O conselho não é apenas consultivo, ele é deliberativo e aprova planos, acompanha orçamentos, fiscaliza a execução das políticas e defende os direitos dos usuários.

Diálogo com você, conselheira e conselheiro

Quando você participa de uma reunião do conselho, você está exercendo um direito constitucional. Quando você fiscaliza o orçamento da saúde, você está protegendo recursos públicos. Quando você cobra melhorias nos serviços, você está defendendo a vida.

4.12.4.5 Epidemiologia como base do planejamento



A Lei determina que o SUS deve planejar suas ações com base em dados epidemiológicos e isso significa conhecer a realidade de saúde da população para definir prioridades.

O planejamento deve considerar os principais problemas de saúde, os territórios mais vulneráveis, os grupos mais afetados e os riscos existentes.

Sem dados, não há planejamento.
Sem planejamento, não há equidade.
Sem equidade, não há SUS.

4.13 A lei 8080 como instrumento de poder do controle social

Todo conselheiro deve conhecer a Lei 8080, pois ela é a base legal para cobrar gestores, analisar planos, fiscalizar contratos, acompanhar metas e defender direitos. Quando o conselho conhece a lei, ele deixa de ser figurativo e passa a ser protagonista. A lei transforma a participação popular em instrumento de transformação social.

Leia a Lei 8080/1990 na íntegra, isso te fortalecerá na prática das ações como conselheiro(a).

<table>
<tr><th colspan="2">Situação problema para reflexão</th></tr>
<tr><td> 

Fonte: Autoria de IA.</td><td>Imagine que o município decida fechar uma unidade básica sem consultar o conselho.
A pergunta não é apenas se isso é uma boa ideia. A pergunta é se isso respeita os princípios do SUS e as diretrizes da Lei 8080.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Se não respeita, é ilegal.
Se é ilegal, deve ser questionado.
Se deve ser questionado, o conselho precisa agir.

Como o conselheiro deve usar a Lei 8080?
Para cobrar gestores
Para fundamentar deliberações
Para fiscalizar contratos
Para defender direitos
Para orientar a população

A lei é ferramenta de luta.</td></tr>
</table>

Situação problema



Fonte: Autoria de IA.

Em um município pequeno, o hospital regional fica a 120 km de distância. Gestantes estão sem transporte para o parto. Pacientes crônicos faltam às consultas por falta de vaga.

Perguntas para reflexão do conselho:

A regionalização está funcionando?

A regulação está garantindo acesso?

O município pactuou corretamente com a região?

O estado está cumprindo sua responsabilidade?

A União está financiando adequadamente?

Qual princípio está sendo violado? Universalidade / Equidade / Integralidade

Qual diretriz precisa ser fortalecida? Descentralização / Regionalização/ Participação

Diálogo com você, conselheira e conselheiro

Você já participou de alguma reunião em que:

O gestor disse que não era responsabilidade dele

O serviço estava disponível, mas ninguém conseguia acesso

O hospital existia, mas não tinha vaga

O exame existia, mas não tinha regulação

Essas situações não são falhas individuais.

São falhas na aplicação dos princípios e diretrizes.

E é aí que o conselho entra.

Mensagem para você, conselheira e conselheiro de saúde

Ser conselheira ou conselheiro de saúde é assumir a defesa da vida.

É defender o SUS quando tentam enfraquecê-lo.

É cobrar quando os direitos não são respeitados.

É propor quando a política falha.

É construir quando o sistema precisa avançar.

O SUS não é obra pronta. É construção permanente. E o conselho é parte dessa obra.

BIBLIOGRAFIA

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil**: texto constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988, compilado até a Emenda Constitucional no 116/2022. Brasília, DF: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2022. 435 p. ISBN: 978-65-5676-185-5. Disponível em: https://www.gov.br/defesa/pt-br/acesso-a-informacao/governanca/governanca-do-setor-de-defesa/legislacao-basica-1/arquivos/2022/constituicao-da-republica-federativa-do-brasil.pdf/view. Acesso em: 15 jan. 2026.

BRASIL. Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, ano 128, n. 249, p. 25694 – 25695, 31 dez. 1990. Disponível em: https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=4&data=31/12/1990. Acesso em: 12 jan. 2026.

PAIM, Jairnilson Silva et al. **O Que É o SUS**: e-book interativo. Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz – Editora Fiocruz, 2015. ISBN: 978-85-7541-453-8. Disponível em: https://fiocruz.br/livro/que-e-o-sus-e-book-interativo-o. Acesso em: 1 fev. 2026.

RODRIGUES, Sergio. **SUS – Sistema Único de Saúde**: o que é e por que precisa existir. 1. ed. São Paulo: Editora Atheneu, 2019. 404 p.

TEXTO 4 - Redes de Atenção à Saúde no SUS

Entendendo para defender o direito à saúde

Ao final da leitura, você será capaz de:

- ✓ Compreender o que são as Redes de Atenção à Saúde
- ✓ Identificar o papel da Atenção Primária à Saúde nas Redes
- ✓ Reconhecer como as redes impactam o acesso e a qualidade do cuidado
- ✓ Atuar como conselheiro ou conselheira na defesa de redes que funcionem de forma integrada e justa

Para refletir!

Você já percebeu como, muitas vezes, uma pessoa vai da unidade básica ao hospital, depois para um especialista, e ninguém parece conversar entre si? Isso não deveria acontecer.

As Redes de Atenção à Saúde existem exatamente para evitar esse caminho confuso. Pense na rede como uma **teia de caminhos bem organizados**, onde cada serviço sabe o que fazer, quando fazer e com quem dialogar.

5 O QUE SÃO REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE – RAS?

As **Redes de Atenção à Saúde**, conhecidas como RAS, são a forma como o SUS organiza seus serviços para garantir cuidado contínuo às pessoas. Não são apenas prédios ou unidades em determinado território. São **relações, fluxos, comunicação e responsabilidade compartilhada**. A rede existe para garantir:

- ✓ Acesso para todas as pessoas (em sua região de saúde)
- ✓ Cuidado integral, e não fragmentado
- ✓ Equidade, considerando quem mais precisa

5.1 Por que falar de Redes de Atenção à Saúde no SUS?

Pense no SUS como uma cidade com muitas ruas. A pessoa precisa se deslocar por essas ruas para chegar ao cuidado certo. Se as ruas não se conectam, ela se perde, demora, repete

exames, piora e, às vezes, desiste. As Redes de Atenção à Saúde, existem para organizar essas conexões.

As RAS e, em especial, a Atenção Primária à Saúde (APS), são centrais para sistemas públicos universais. Elas ajudam a transformar os princípios do SUS em vida real: universalidade, equidade e integralidade. **Universalidade** significa que **todas as pessoas têm direito**. **Equidade** significa **tratar de modo diferente quem tem necessidades diferentes**, para reduzir injustiças. **Integralidade** significa olhar a pessoa e a comunidade por inteiro, com **ações articuladas.**

Constituir Redes integrais é uma resposta à complexidade do processo saúde-doença. As necessidades podem ser individuais, como uma dor no peito. Podem ser coletivas, como surtos, violência, acidentes, enchentes, falta de água. A **Rede precisa dar conta do cuidado e também das ações de saúde pública e vigilância.**

Quando você lê "políticas públicas de saúde como intervenções e respostas", pense assim: o SUS não é só atendimento. O SUS também protege a vida, organiza respostas para riscos e garante direitos em realidades diversas.

No Brasil, a ideia de Redes ganhou força no SUS, mas com desafios próprios de um país continental, federativo, diverso e desigual. Isso significa que a rede precisa funcionar em cidades muito grandes e em municípios pequenos. Precisa lidar com distâncias, diferenças de infraestrutura e desigualdade social.

Em suma, Rede é quando os serviços conversam entre si para cuidar melhor das pessoas. O SUS precisa funcionar em rede, porque saúde não é simples. As pessoas adoecem por muitos motivos:



Fonte: Autoral, com recursos do Canva, 2026.

Além disso:



Fonte: Autoral, com recursos do Canva, 2026.

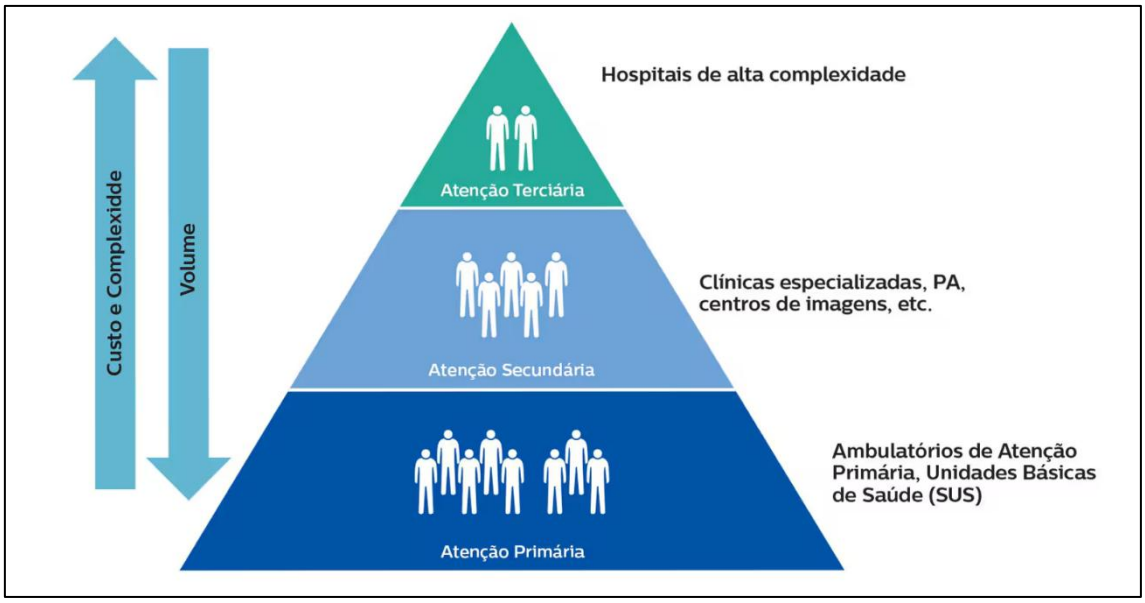
Nenhum serviço isolado dá conta disso sozinho. Um serviço de saúde sozinho é como tentar apagar um incêndio com um copo d'água. A Rede é o corpo de bombeiros inteiro, organizado e coordenado.

5.2 De onde vem essa ideia de redes?

A ideia de organizar a saúde em redes ganhou força no século XX, especialmente com o **Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido**, criado após a Segunda Guerra Mundial. Esse modelo defendia:

- ✓ Saúde como direito;
- ✓ Financiamento público;
- ✓ Integração entre prevenção e tratamento;
- ✓ Atenção primária como porta de entrada.

Esses princípios influenciaram muitos países e também a construção do SUS no Brasil. Muitos países passaram a discutir redes e integração do cuidado quando perceberam dois problemas principais.



Fonte: pim-staging.cpcompany.com

Primeiro problema: Fragmentação. Cada serviço faz a sua parte, mas a pessoa não consegue um caminho contínuo.

Segundo problema: Custo. Sistemas fragmentados tendem a gastar mais com repetição de exames, internações evitáveis e uso inadequado de urgência.

A principal referência histórica citada no texto é o sistema inglês, o *National Health Service* (NHS), criado em 1948 no pós-guerra, dentro das políticas do Estado de Bem-estar Social. O NHS foi influenciado por duas formulações.

5.3 Relatório Dawson, 1920

O Relatório Dawson foi publicado em 1920 para orientar a reorientação do sistema de proteção social em saúde do Reino Unido, que era um seguro social restrito. Ele não foi implementado na época, mas orientou a criação da rede do NHS, organizada com estatização dos hospitais.

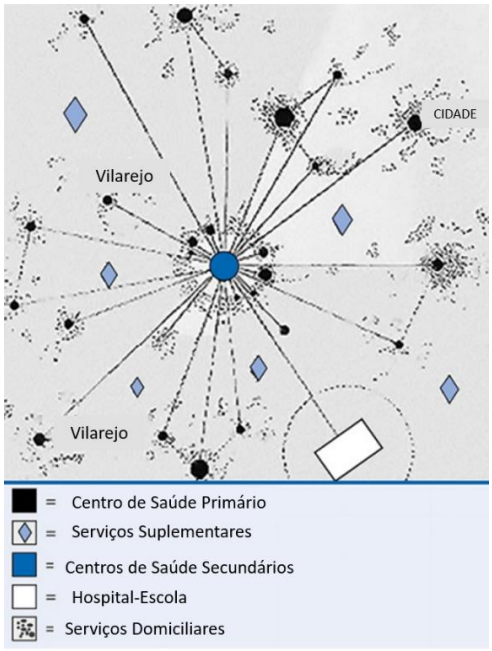
O ponto importante para nossa aula é o "desenho" que ele propõe, porque isso inspira a ideia de rede até hoje. O relatório destaca uma **rede regionalizada e hierarquizada (diretriz ou princípio - descentralização),** com serviços diferentes e complementares. Ele propõe integrar ações preventivas e curativas e coloca a atenção primária como porta de entrada e como retaguarda dos serviços secundários e terciários. Ele também menciona a autoridade sanitária por área e a centralidade de médicos generalistas.

Agora, leve isso para o SUS e para o controle social. Quando o texto fala em autoridade sanitária por área, pense em governança regional e responsabilidade sanitária. Para o conselho, isso se traduz em perguntas necessárias: quem coordena a rede na região? Como a região planeja? Como se pactua acesso?

5.4 Plano Beveridge, 1942

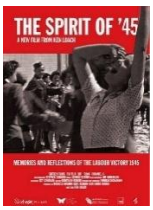
O Plano Beveridge recomenda um serviço nacional de saúde financiado publicamente por impostos, com gestão pública, organizado por universalidade, integralidade, equidade e gratuidade. Ele define acesso a serviços como direito à saúde. Aqui existe uma ponte direta com o SUS: direito, financiamento público e dever do Estado. O NHS manteve apoio político da população por décadas, resistindo parcialmente a reformas neoliberais nos anos 1990, embora tenha ocorrido alguma separação entre financiamento e provisão.

Figura 4 – Diagrama do Informe Dawson mostrando todos os serviços.



Fonte: Fiocruz.

Sugestão de material complementar



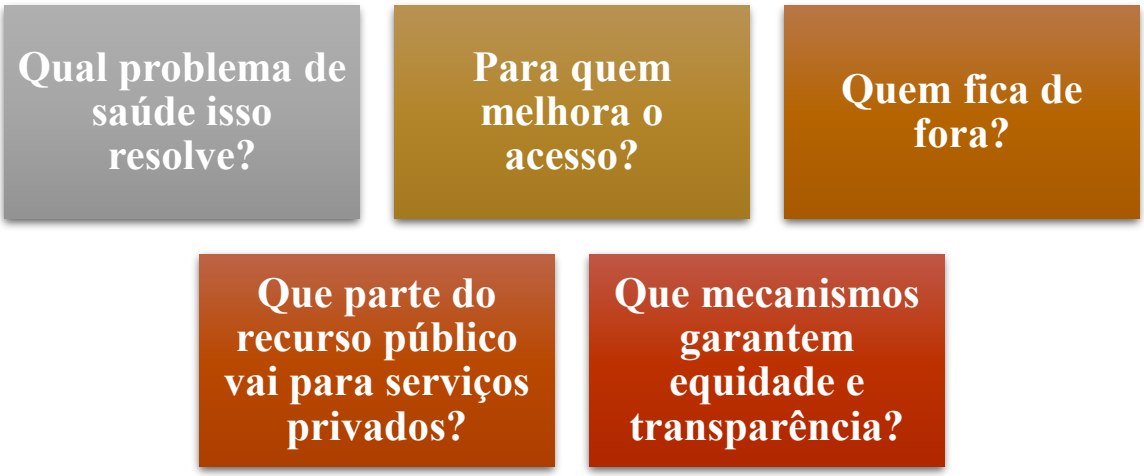
Documentário: *O Espírito de 45*, de Ken Loach: Mostra como a saúde pública se tornou um direito no Reino Unido.
Assista:
THE SPIRIT OF ’45 = O Espírito de 45. Direção: Ken Loach. Reino Unido, 2013. Filme cinematográfico. Disponível em: https://vimeo.com/124353555?fl=pl&fe=ti.

5.5 Redes, pessoas e interesses econômicos

Nas últimas décadas, organismos internacionais e também o setor privado passaram a falar de redes como “cuidados integrados”. Às vezes a motivação é sanitária, para melhorar a vida das pessoas. Às vezes é econômica, para racionalizar custos. Em muitos lugares, as duas coisas se misturam.

Por isso, o texto faz um alerta político. Ao discutir redes, você precisa observar a intencionalidade central. A rede está organizada para responder necessidades de pessoas e grupos sociais. Ou está organizada para ampliar lucro e mercado.

Na prática do conselho de saúde, esse alerta vira uma lente de fiscalização. Exemplo: quando aparece uma proposta de reorganização da rede, você pergunta:



5.6 Redes de Atenção à Saúde no Brasil

No Brasil, o Artigo 198 da Constituição Federal de 1988 define que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único. Em termos simples, isso significa que o SUS não foi pensado como ilhas. Ele foi pensado como rede, organizada por regiões e por níveis de atenção, com cooperação entre entes federados.

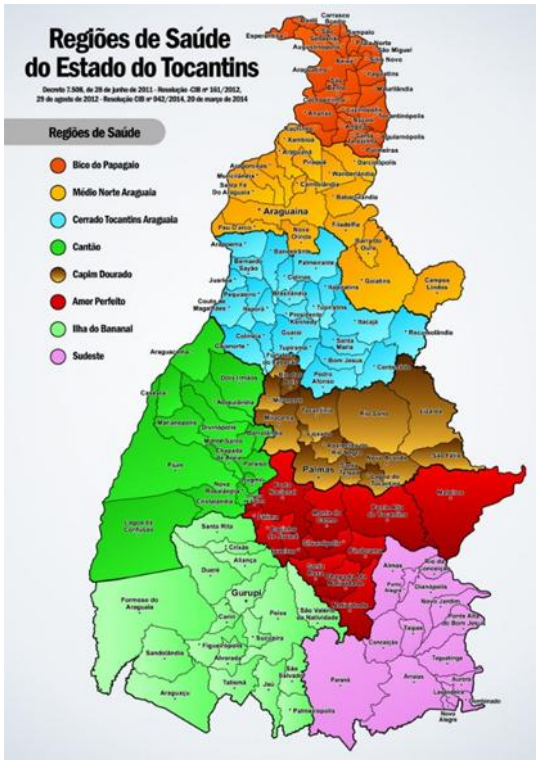
Nos anos 1990, a implantação do SUS avançou muito com a **descentralização,** principalmente por municipalização. Em menor grau, avançou pela regionalização. Nesse contexto, a Estratégia de Saúde da Família, ESF, tornou a APS estruturante para organizar o SUS no nível local e ampliar a capilaridade do sistema. Isso significa que:

Os serviços precisam estar organizados por regiões	Cada serviço tem uma função	A Atenção Primária é a principal porta de entrada

A criação do SUS apostou fortemente na:

- ✓ Descentralização
- ✓ Municipalização
- ✓ Estratégia Saúde da Família

Essas escolhas permitiram que o SUS chegasse perto das pessoas, inclusive em áreas remotas.



Fonte: Tocantins, 2013.

Atenção! Quando um município pequeno não tem como oferecer tudo, a regionalização é o caminho para garantir acesso com equidade. A pergunta central é: a região está garantindo o que o decreto 7.508/2011 exige como mínimo APS, vigilância, atenção especializada ambulatorial, atenção psicossocial, atenção hospitalar, urgência e emergência.

Diálogo



Fonte: Autoria de IA.

5.7 Por que redes importam para a integralidade?

O problema que a rede tenta resolver

O Brasil vive mudanças demográficas e epidemiológicas. Há envelhecimento populacional. Há tripla carga de doenças, com condições crônicas, acidentes e violências, e permanência e emergência de doenças infecciosas.

Nenhum serviço sozinho resolve isso. Uma pessoa com diabetes precisa de acompanhamento longitudinal na APS, exames, medicamentos, educação em saúde, cuidado multiprofissional, e às vezes atenção especializada. Uma gestante precisa de pré-natal, exames, maternidade de referência e atenção ao puerpério. Uma pessoa em sofrimento psíquico precisa de rede psicossocial articulada, sem abandono. A rede é a forma de organizar esses caminhos.

5.8 O que significa integralidade neste debate?

A Constituição fala em assistência integral, isso se relaciona a promoção da saúde, prevenção de doenças e cura, mas também a fatores mais amplos que interferem na saúde, como condições socioeconômicas.

Há diferentes leituras de integralidade, e todas são úteis para a compreensão e aplicabilidade no trabalho do conselho, porque ajudam a avaliar políticas e serviços.

Giovanella e colaboradores (2002) ligam integralidade à Reforma Sanitária e à articulação de políticas públicas para incidir sobre determinação social do processo saúde enfermidade. Para o conselho, isso reforça que rede não é só "assistência". Rede também é coordenação com outras políticas públicas, quando necessário.

Cecílio (2006) propõe olhar para necessidades de saúde socialmente construídas:



Fonte: Autoral, com recursos do Canva, 2026.

Para o conselho, isso se traduz em avaliar se a rede respeita diversidade, combate discriminação e garante acesso sem barreiras.

Miranda Jr (2014) formula a ideia de que redes de atenção são estratégia de efetivação da integralidade em cenários regionais. Para o conselho, isso reforça que a região de saúde precisa ser o espaço onde a integralidade se realiza.

5.9 O desafio brasileiro: rede integral em municípios pequenos

Como a maioria dos municípios é de pequeno porte, uma rede integral se completa na região de saúde, geralmente intermunicipal. Ela precisa disponibilizar a maioria dos tipos de serviços na região para responder desde necessidades comuns até necessidades menos

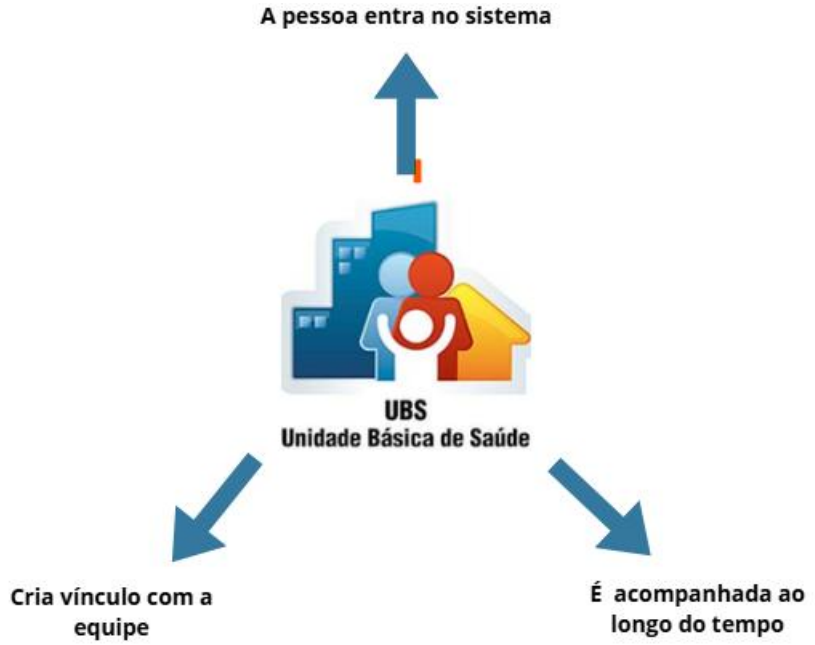
frequentes, que exigem serviços especializados. Em alguns casos, a referência pode ser outra região, outro estado ou nível nacional.

Mesmo assim, o texto reconhece que redes regionalizadas integrais ainda não são realidade em muitos lugares. Há constrangimentos estruturais, como subfinanciamento crônico, mix público privado e relações interfederativas complexas. Além disso, a rede depende do cotidiano: como profissionais interagem, como serviços se comunicam, como as três esferas governamentais se articulam.

Diálogo:

Atenção Primária à Saúde como base da rede

A **Atenção Primária à Saúde**, ou APS, é o coração da rede. É na unidade básica que:



Sem APS forte não existe rede funcionando bem. Se a unidade básica não consegue acompanhar as pessoas, quem coordena o cuidado quando elas precisam de exames, especialistas ou hospital?

5.10 Regulamentação das RAS

Em 2010, o Ministério da Saúde regulamentou as RAS no SUS e as conceituou como arranjos organizativos de ações e serviços de diferentes densidades tecnológicas, integrados por sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscando garantir integralidade do cuidado.

A Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010 estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Depois, o Decreto nº 7.508 de 2011 regulamentou a Lei 8.080 de 1990 e institucionalizou a organização das redes e regiões de saúde, com instâncias e dispositivos de gestão interfederativa. Esse decreto define que regiões devem conter, no mínimo, componentes como APS, vigilância, atenção especializada, psicossocial, hospitalar e urgência e emergência.

Ainda em 2011, o Ministério da Saúde passou a adotar o conceito de redes temáticas, com foco em problemas e campos de cuidado específicos. O texto cita:

- ✓ Rede de Atenção Obstétrica e Neonatal – Hoje denominada Rede Alyne
- ✓ Rede de Atenção Psicossocial
- ✓ Rede de Atenção às Condições Crônicas
- ✓ Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência
- ✓ Rede de Atenção às Urgências e Emergências.

Imagem: estrutura operacional das Redes de Atenção à Saúde



Imagem: Região de Saúde Capim Dourado no Tocantins



5.11 O que caracteriza uma rede bem organizada?

Uma rede de atenção precisa de alguns elementos essenciais.

5.11.1 População e território

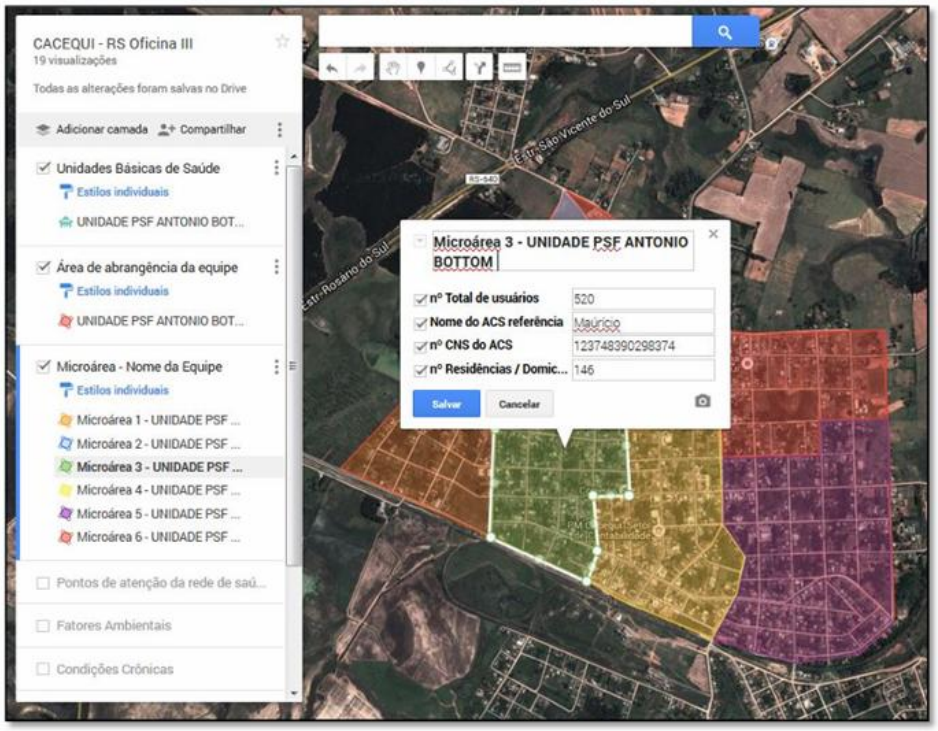
A rede precisa conhecer:



População e território são a base para identificar e dimensionar necessidades de saúde. Também são **referência socioespacial da rede** e campo de responsabilidade sanitária. Em termos práticos, isso significa que a rede precisa conhecer quem mora na região, onde mora, quais vulnerabilidades existem, e quais riscos coletivos aparecem, como áreas com violência, áreas com desassistência, áreas sem saneamento.

Para o conselho, isso aparece na análise de relatórios e planos. Quando você recebe um plano municipal ou regional, pergunte: O diagnóstico considera território e desigualdades? Há dados por bairro, comunidade, zona rural? Há metas para reduzir iniquidades?

Imagem: Mapa de território com áreas de abrangência da APS



5.11.2 Diferentes tipos de serviços

Cada serviço tem uma função:



Unidade Básica
Cuidado contínuo

UPA
Urgência e Emergência

Hospital
Situações mais complexas

Atenção! Nenhum substitui o outro.

Os serviços têm densidades tecnológicas e missões diferentes e complementares. **UBS e equipes de APS precisam estar distribuídas e acessíveis**. As **urgências e emergências** são guiadas por **risco de vida e tempo resposta**. **Hospitais** especializados tendem a ser **mais concentrados e acessados por indicação clínica**. Elas não são locais adequados para acompanhamento longitudinal. A continuidade precisa de vínculo com a mesma equipe de APS.

Atenção! UPA não é lugar de acompanhamento de doenças crônicas. Esse cuidado precisa voltar para a APS.

5.11.3 Sistemas de apoio

A rede precisa funcionar com o apoio de:



Transporte sanitário (ambulâncias e outros transportes)



Sistemas de Informação em Saúde



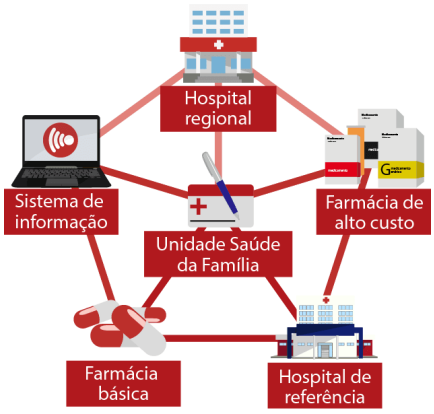
Exames e Diagnósticos

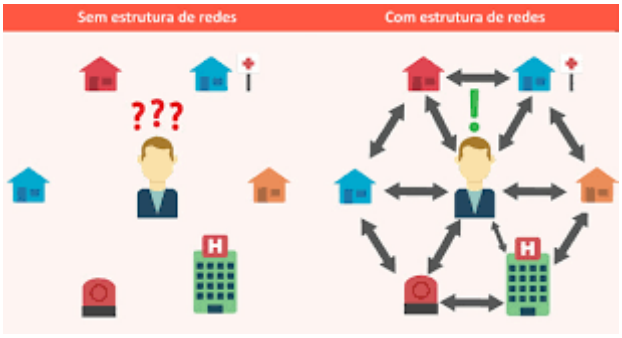
Sem isso, o cuidado trava. Aqui existe um ponto forte para controle social, pois muitas falhas de acesso não são "falta de médico". São falhas de apoio. Exemplo: falta de transporte para hemodiálise. Falta de internet para prontuário eletrônico. Falta de logística para exames.

5.11.4 Comunicação e fluxos

Rede não é só estrutura. É comunicação. Quando um serviço não informa o outro quem sofre é o usuário. Rede exige conexões estratégicas. Isso envolve comunicação entre profissionais, entre serviços e entre informações. Quando falha, a pessoa carrega papel, perde guia, repete história, repete exames e sofre.

Imagem: Fluxograma de encaminhamento na rede





5.11.5 Gestão e pactuação

As redes são organizadas por meio de pactos entre municípios, estados e União.

A **Comissão Intergestores Regional**, conhecida como CIR, é um espaço fundamental para isso, reunindo secretários municipais e representantes estaduais. A CIR deve planejar regionalmente a partir das necessidades da população. A rede precisa de atores, espaços e instâncias com responsabilidade por organização, decisão, planejamento, pactuação, implementação e acompanhamento.

Importante para o controle social - As decisões da CIR (Comissões Intergestores Regionais) e da CIB (Comissões Intergestores Bipartite) impactam diretamente no:

- ✓ Acesso a exames
- ✓ Filas
- ✓ Distribuição de serviços

5.11.6 Integração na rede: o coração do funcionamento

A continuidade e integração são essenciais para atender as necessidades dos usuários no SUS. Para entender, pense em duas situações comuns.

Situação Problema:

um usuário precisa ser encaminhado para exame ou especialista.

Situação Problema:

um usuário é cuidado em dois serviços ao mesmo tempo, por exemplo UBS e CAPS, ou UBS e ambulatório de especialidade.

Se a rede não coordena, ocorre descontinuidade. Na saúde, não basta cada um fazer a sua parte. É preciso gerir o tempo e a lógica do cuidado, para que a pessoa tenha um percurso articulado.

5.11.6.1 Instrumentos que ajudam a integrar a rede:

a) Linhas de cuidado:

Organizam o caminho da pessoa na rede:

Exemplos:



Gestante



Pessoa com diabetes



Saúde mental

b) Protocolos clínicos e de encaminhamentos:

Ajudam a definir:

Quando encaminhar?

Para onde?

Em que tempo?

Evita favorecimentos e peregrinação. São guias técnicos para decisões clínicas e critérios de encaminhamento. Podem evitar conflitos entre serviços e peregrinação de usuários, especialmente se construídos com participação de diferentes atores.

Para o conselho, existe uma pergunta simples: o protocolo está sendo usado para garantir equidade e transparência, ou está sendo ignorado por favores e atalhos.

5.11.6.2 Regulação do acesso

Serve para **organizar filas com justiça**. É a gestão do acesso a outros serviços, buscando acesso adequado, em tempo oportuno, com equidade e transparência. Exemplos: regulação de leitos, urgências e emergências, transplantes, geralmente por centrais reguladoras. Quando bem-feita, a **regulação organiza o tempo de acesso conforme necessidade e risco**, comparando situações entre pessoas que também precisam do cuidado. Ela evita favorecimentos injustos e informalidade excessiva.

Princípio ético: Quem tem maior risco deve ser atendido primeiro.

5.11.6.3 Matriciamento

Especialistas apoiam equipes da APS compartilhando saberes e evitando encaminhamentos desnecessários.

Exemplo: Antes de encaminhar para um psiquiatra, a equipe discute o caso com apoio especializado e isso, na maioria das vezes, resolve o problema sem necessidade de encaminhar.

O papel do conselheiro e da conselheira de saúde: Você, no controle social, pode

- ✓ Questionar falhas na rede
- ✓ Defender integração entre serviços
- ✓ Cobrar regulação justa
- ✓ Acompanhar pactuações regionais

Pergunta para reflexão: As pessoas do seu território conseguem caminhar pela rede sem se perder?

- ✓ O que, na sua região, dificulta o funcionamento da rede?
- ✓ O que o conselho pode fazer diante disso?

Para aprofundar: Material base produzido pela Fundação Oswaldo Cruz - Introdução ao SUS – (Clique aqui).

BIBLIOGRAFIA

CECÍLIO, L. C. O. As Necessidades de Saúde como Conceito Estruturante na Luta pela Integralidade e Equidade na Atuação em Saúde. In: PINHEIRO, R.; MATTOS, R. A. (Org.). **Os sentidos da integralidade na atenção e no cuidado à saúde.** 8. ed. Rio de Janeiro: UERJ, IMS, ABRASCO, 2009. p. 117 130. Disponível em: https://www.cepesc.org.br/wp-content/uploads/2013/08/Livro-completo.pdf

FIOCRUZ. **Introdução ao Sistema Único de Saúde: contextualização da emergência das Redes de Atenção à Saúde no plano internacional.** Disponível em: https://mooc.campusvirtual.fiocruz.br/rea/introducao-sus/modulo3/aula1.html.

GIOVANELLA, L. et al. Sistemas Municipais de saúde a diretriz da integralidade da atenção: critérios de avaliação. **Saúde em Debate,** v. 26, n. 60, p. 37 61, 2002. Disponível em: https://docs.bvsalud.org/biblioref/2023/05/676164/v26-n60-janabr-2002-37-61.pdf

GIOVANELLA, L.; MENDONÇA, M. H. M. Atenção Primária à Saúde. In: GIOVANELLA, L.; ESCOREL, S.; LOBATO, L. V. C. (Org.). **Políticas e Sistema de Saúde no Brasil.** 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2012. p. 493 545. Disponível em: http://www.escoladesaude.pr.gov.br/arquivos/File/ATENCAO_PRIMARIA_A_SAUDE_ESF_Giovanella_L_Mendonca_MH.pdf

KUSCHNIR, R.; CHORNY, A. H. Redes de atenção à saúde: contextualizando o debate. **Ciência Saúde Coletiva,** v. 15, n. 5, p. 2307 2316, 2010. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/csc/v15n5/v15n5a06.pdf

MAGALHÃES JUNIOR, H. M. Redes de Atenção à Saúde: rumo à integralidade. Divulgação em **Saúde para Debate**, n. 52, p. 15 37, 2014. Disponível em: http://cebes.org.)br/site/wp-content/uploads/2014/12/Divulgacao-52.pdf

MATTOS, R. Os sentidos da integralidade: algumas reflexões acerca de valores que merecem ser defendidos. In: PINHEIRO, R.; MATTOS, R. A. (Org.). **Os sentidos da integralidade na atenção e no cuidado à saúde.** 8. ed. Rio de Janeiro: Instituto de Medicina Social, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ABRASCO, 2009. p. 43 68. Disponível em: https://www.cepesc.org.)br/wp-content/uploads/2013/08/Livro-completo.pdf

MELO, E. A. et al. Mudanças na Política Nacional de Atenção Básica: entre retrocessos e desafios**. Saúde em Debate**, v. 42, n. especial 1, p. 38 51, 2018. Disponível em: https://www.scielo.br/j/sdeb/a/Vs4dLSn6T43b6nPBCFg8F3p/?format=pdf&lang=pt

MENDONÇA, M. H. M. et al. **Atenção Primária à Saúde no Brasil: conceitos, práticas e pesquisas.** Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2018. Disponível em: https://books.scielo.org/id/bjj6w/03

STARFIELD, B. Acessibilidade e primeiro contato: a porta. In: STARFIELD, B. Atenção **Primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e tecnologia.** Brasília: UNESCO, Ministério da Saúde, 2002. p. 207 246. Disponível em: https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/0253.pdf.

TEXTO 5 - A Educação Popular em Saúde para a atuação ético-política da conselheira e do conselheiro de saúde

Apresentação ao educando e à educanda

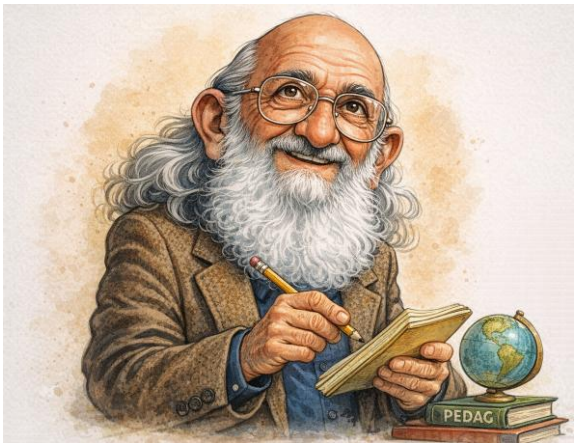
Conselheira e conselheiro de saúde, este texto foi construído para dialogar diretamente com sua prática cotidiana no território, no conselho de saúde, nas conferências, nas reuniões comunitárias, nos espaços de escuta da população e na defesa do direito à saúde. Aqui você vai compreender a **Educação Popular em Saúde não como uma metodologia isolada, mas como uma forma de pensar, agir, educar, cuidar e fazer política pública com as pessoas e para as pessoas.**



Fonte: Fiocruz, 2016.

A Educação Popular em Saúde não é apenas uma técnica educativa, pois é uma posição ética, política e pedagógica que reconhece o povo como sujeito de direitos, produtor de saberes e protagonista da construção do SUS. É uma educação que nasce da vida real, do território, das lutas sociais, das necessidades e da busca coletiva por dignidade, justiça social e bem viver.

Ao longo deste texto, você será convidado(a) a refletir sobre o seu papel como liderança social, como defensor(a) do SUS e como agente político comprometido(a) com a democracia, com os direitos humanos e com a participação social.



Fonte: Caricatura gerada por IA / CHATGPT

"As qualidades ou virtudes são construídas por nós no esforço que nos impomos para diminuir a distância entre o que dizemos e o que fazemos. Este esforço, o de diminuir a distância entre o discurso e a prática, é já uma dessas virtudes indispensáveis – a da coerência" (1996, p. 38).

Paulo Freire.

6 EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE COMO FUNDAMENTO ÉTICO-POLÍTICO DA ATUAÇÃO NO SUS

A Educação Popular em Saúde constitui uma perspectiva teórico-metodológica e ético-política que orienta experiências, políticas, ações e serviços do Sistema Único de Saúde. Sua importância está no fato de oferecer caminhos para processos de ensino e aprendizagem capazes de promover a saúde como parte da vida, como direito e como construção coletiva nos territórios.

A Educação Popular em Saúde parte do reconhecimento de que a saúde não é apenas ausência de doença, mas uma possibilidade de construir projetos de felicidade, horizontes de bem viver e ambientes saudáveis nos territórios. Ela compreende que a vida das pessoas é atravessada por desigualdades sociais, injustiças, vulnerabilidades, mas também por saberes, resistências, culturas e potências comunitárias.



Fonte: Universidade Estadual do Ceará (UECE), 2024.

 Fonte: Waleskasantiago12 / Wikipedia	*Vamos levantar!* *Vamos se erguer!* *Vamos dar as mãos!* *Vamos viver!* *Zé Maria do Tomé*

Desde os anos 1970, a Educação Popular em Saúde vem qualificando a politicidade da educação no setor saúde, denunciando práticas educativas autoritárias, normativas e bancárias que apenas transmitem informações, sem produzir reflexão, consciência crítica e autonomia. Em contraposição, a Educação Popular em Saúde **propõe processos educativos dialógicos, participativos, problematizadores e emancipadores**, nos quais ninguém educa ninguém sozinho, ninguém sabe tudo e ninguém ignora tudo.



Fonte: Freepik, 2026.



Fonte: Autoria de IA.



6.1 Educação popular em saúde no território, na atenção primária e nos serviços do SUS

A Educação Popular em Saúde tem se mostrado viva, vibrante e fundamental nos serviços de saúde, nos movimentos populares, nos conselhos de saúde, nas universidades e nos territórios, mesmo diante de crises sanitárias, políticas e sociais como a pandemia da Covid-19.

Durante a pandemia, em muitos municípios brasileiros, foram as práticas da Educação Popular em Saúde que permitiram organizar redes de solidariedade, ações comunitárias, vigilância popular em saúde, apoio às famílias vulneráveis, circulação de informações confiáveis e defesa da vida.

Nessas experiências, profissionais de saúde e população atuaram juntos, protagonizando processos de cuidado, organização comunitária e proteção social. Não se tratava apenas de atender doentes, mas de cuidar das condições de vida das pessoas.

A Estratégia Saúde da Família e a Atenção Primária à Saúde constituem cenários privilegiados para a prática da Educação Popular em Saúde, pois aproximam o serviço da comunidade, fortalecem o vínculo, ampliam a capacidade de organização social e potencializam a luta por direitos.



A Educação Popular em Saúde orienta uma prática que valoriza o território como espaço de vida, cultura, trabalho, afetos e conflitos. Valoriza as lideranças comunitárias, os saberes populares, as práticas tradicionais de cuidado e as experiências acumuladas pelas comunidades.

O trabalho em saúde deixa de ser apenas técnico e passa a ser social, político e cultural. A Unidade Básica de Saúde deixa de ser apenas um local de atendimento e passa a ser um centro de referência social, espaço de organização comunitária, de diálogo, de construção de projetos coletivos.

Para a conselheira e o conselheiro de saúde, isso significa atuar para que os serviços de saúde não sejam fechados em si mesmos, mas abertos à comunidade, às associações de moradores, às igrejas, às escolas, aos coletivos culturais, aos movimentos sociais.

Significa lutar para que a Unidade Básica de Saúde seja um **espaço de escuta, diálogo, acolhimento e construção coletiva**.

Situação-problema para análise no conselho.



Fonte: Autoria de IA.

6.2 Educação popular em saúde como mobilização da participação social e da democracia

A Educação Popular em Saúde entende que educação é encontro humano. Todo encontro é educativo. O modo como as pessoas se encontram, dialogam, escutam e se respeitam define que tipo de sociedade está sendo construída.

A Educação Popular em Saúde **propõe encontros humanos transformadores** nos serviços de saúde, nas comunidades, nos conselhos e nos espaços públicos. Encontros que **mobilizam pensamento, reflexão, crítica, autocrítica e ação coletiva**.

Nessa perspectiva, o educador e a educadora, assim como a conselheira e o conselheiro de saúde, têm como tarefa mobilizar o diálogo, provocar perguntas, estimular o pensamento e incentivar as pessoas a se posicionarem diante da realidade.



Fonte: https://ceara.fiocruz.br/participatorio/2022/08/17/comunidades-quilombolas-elaboram-plano-de-vigilancia-popular-em-defesa-do-pantanal/

Não se trata de decorar conteúdos, mas de **pensar criticamente** sobre os problemas do território, sobre as políticas públicas, sobre o funcionamento do SUS e sobre os determinantes sociais da saúde. A **participação social** é central na Educação Popular em Saúde. Participar não é favor, não é concessão, não é gentileza. **Participar é um direito constitucional e um dever ético-político**.

A Constituição Federal garante a participação da comunidade na gestão do SUS. Isso significa que os serviços de saúde devem ser organizados com a população e não apenas para a população. A Educação Popular em Saúde promove a formação de cidadãos críticos, protagonistas, corresponsáveis e comprometidos com a defesa do bem comum.

Para a conselheira e o conselheiro de saúde, isso significa compreender que sua atuação é profundamente política. Política no sentido mais nobre da palavra. Política como cuidado com as pessoas. Política como construção do bem comum. Política como defesa da vida.

Em um país marcado por desigualdades, racismo, pobreza, exclusão e violência, a Educação Popular em Saúde se afirmar como uma pedagogia da esperança, da amorosidade, da emancipação e da luta por direitos. A Educação popular fortalece a democracia, enfrenta projetos autoritários, combate a necropolítica e reafirma o valor da vida humana e do bem viver.

Para refletir na sua prática como conselheiro.



Fonte: Autoria de IA.

6.3 Educação popular em saúde como caminho para fortalecer o sus e a democracia

A Educação Popular em Saúde nos ensina que participar se aprende participando, que a democracia se constrói no cotidiano e que o direito à saúde se defende com organização, consciência e mobilização popular.

Ela nos ensina que não basta ter leis, normas e políticas se não houver sujeitos organizados para defendê-las. Ela nos ensina que o SUS só existe porque houve luta social e que continuará existindo apenas se houver luta permanente.

Para a conselheira e o conselheiro de saúde, a Educação Popular em Saúde é um instrumento político, pedagógico e ético que fortalece sua atuação, amplia sua capacidade de diálogo com a comunidade e qualifica sua intervenção nos espaços de controle social.



Fonte: Autoria de IA.

BIBLIOGRAFIA

ALMEIDA, Silvio Luiz de. Necropolítica e neoliberalismo. **Caderno Crh**, [S.L.], v. 34, p. 1, 29 nov. 2021. Universidade Federal da Bahia. http://dx.doi.org/10.9771/ccrh.v34i0.45397.

ARAÚJO, R. S. *et al*. Educação popular na atenção primária à saúde: sistematização de experiências com grupos comunitários de promoção da saúde. **Revista Conexão UEPG**, Ponta Grossa, v. 17, p. 1-22, 2021.

BORNSTEIN, V. J. Princípios pedagógicos do curso de aperfeiçoamento em educação popular em saúde. *In*: BORNSTEIN, V. J. *et al*. (org.). **Textos de apoio do curso de aperfeiçoamento em educação popular em saúde**. Rio de Janeiro: EPSJV, 2016. p. 15-20.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. **Política Nacional de Educação Popular em Saúde**: Comitê Nacional de Educação Popular em Saúde (CNEPS). Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2012.

BRUTSCHER, V. J.; CRUZ, P. J. S. C. Participação social na perspectiva da educação popular: suas especificidades e potencialidades na atenção primária à saúde. **Caderno CIMEAC**, [s. l.], v. 10, n. 1, p. 126-152, 2020.

CALADO, A. J. F. Educação popular como processo humanizador: quais protagonistas? *In*: CRUZ, P. J. S. C. *et al*. (org.). **Educação popular e nutrição social**: reflexões e vivências com base em uma experiência. João Pessoa: Editora UFPB, 2014. p. 355-375.

CRUZ, P. J. S. C. *et al*. Educação popular em saúde: princípios, desafios e perspectivas na reconstrução crítica do país. **Interface - Comunicação, Saúde, Educação**, Botucatu, v. 28, e230550, 2024. Disponível em: https://doi.org/10.1590/interface.230550. Acesso em: 1 mar. 2026.

FLEURY, S. Capitalismo, democracia, cidadania: contradições e insurgências. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 42, n. esp. 3, p. 108-124, 2018.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia**: saberes necessários à prática educativa. 25. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

FREIRE, P. **Pedagogia da esperança**: um reencontro com a Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.

HALLAL, P. C. SOS Brazil: democracy under attack. **The Lancet**, [s. l.], v. 400, n. 10349, p. 355, 2022.

HALLAL, P. C. SOS Brazil: science under attack. **The Lancet**, [s. l.], v. 397, n. 10272, p. 373-374, 2021.

MBEMBE, A. **Necropolítica**. São Paulo: n-1 edições, 2018.

MENEZES, P.; FLEURY, S. Pandemia nas favelas: entre carências e potências. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 44, n. esp. 4, p. 267-280, 2020.

MOREL, A. P. M. Negacionismo da Covid-19 e educação popular em saúde: para além da necropolítica. **Trabalho, Educação e Saúde**, Rio de Janeiro, v. 19, e00315147, 2021. Disponível em: doi.org. Acesso em: 27 jul. 2023.

VALLA, V. V. A crise de interpretação é nossa: procurando compreender a fala das classes populares. **Educação & Realidade**, Porto Alegre, v. 21, n. 2, p. 177-190, jul./dez. 1996.

MÓDULO II



Participa+SUS

QUALIFICAÇÃO DE CONSELHEIRAS E CONSELHEIROS DE SAÚDE PARA A PARTICIPAÇÃO POPULAR E CONTROLE SOCIAL NO SUS

TEXTO 6 - O Regimento Interno como Instrumento Político, Normativo e Pedagógico do Conselho de Saúde

O **Regimento Interno** é o documento que organiza a vida real do Conselho de Saúde. Ele transforma a ideia de **controle social** em rotinas organizadas, define quem decide, como decide, quando decide e como registra essas decisões, para que o Conselho seja reconhecido como **instância colegiada, deliberativa e permanente** do SUS e não como um espaço apenas consultivo ou simbólico. A **Resolução CNS nº 453, de 10 de maio de 2012**, reforça que o Plenário se reúne, no mínimo, mensalmente e que o funcionamento tem como base o próprio Regimento Interno, com pauta e materiais enviados com antecedência, reuniões abertas ao público e estrutura de secretaria executiva para garantir autonomia e suporte técnico administrativo.



Fonte: Autoria de IA.

Situação problema	
 Fonte: Autoria de IA.	Em uma reunião ordinária, a presidência coloca em votação um tema que não estava na pauta enviada previamente. Parte do plenário quer votar porque "é urgente", outra parte afirma que isso fere o Regimento e pode gerar questionamento posterior.
Quais artigos do Regimento você buscaria primeiro e como registraria em ata a decisão do plenário para proteger a legitimidade deliberativa?	

***

7 CONCEITO E FUNÇÃO DO REGIMENTO INTERNO, A REGRA QUE PROTEGE A DECISÃO COLETIVA

O **conceito de Regimento Interno** pode ser entendido como um acordo público escrito, aprovado pelo próprio Conselho, que define as **normas de funcionamento, organização e deliberação**. Na prática, ele estabelece composição por segmentos, mandato, periodicidade, quórum, formas de convocação, ordem dos trabalhos, registro em ata, processos de votação e instrumentos deliberativos, como **resoluções, recomendações e moções**, garantindo previsibilidade e segurança institucional. A Resolução 453/2012 explicita que as decisões do Conselho devem obedecer a **quórum mínimo de metade mais um** de seus integrantes, ressalvados casos regimentais que exijam quórum especial, e também define conceitos de **maioria simples, maioria absoluta e maioria qualificada**.

O Regimento não serve para “engessar”, ele serve para impedir que a força política do momento capture o Conselho e substitua o debate público por atalhos, já que a regra protege tanto quem concorda quanto quem diverge. Quando o Conselho precisa deliberar sobre Plano de Saúde, orçamento, prestação de contas ou serviços, o Regimento é o caminho para assegurar que a decisão seja transparente, registrada, justificável e comunicável para a comunidade, reduzindo espaço para manipulação de pauta, votação apressada e decisões sem lastro.

Diálogo com você conselheira e conselheiro



Fonte: Gemini / nano banana

Situação problema	
 Fonte: Autoria de IA.	O gestor solicita que uma resolução seja “apenas uma recomendação”, dizendo que assim “evita conflito”. Como você avaliaria, pelo Regimento, quando cabe resolução, quando cabe recomendação e como a escolha do instrumento muda a força política e administrativa da decisão?

7.1 Natureza normativa, política e organizativa, o regimento como arquitetura do poder no conselho

A **natureza normativa** do Regimento aparece quando ele define regras formais que vinculam o funcionamento do Conselho, como **quórum, votação aberta, prazos, comissões, registro em ata e ritos de alteração do próprio Regimento**. A Resolução 453/2012 determina que alterações na organização dos Conselhos preservem o que está garantido em lei e sejam propostas pelo próprio Conselho, votadas em plenária com **quórum qualificado**, para depois serem incorporadas ao Regimento e homologadas pelo gestor correspondente.

A **natureza política** se revela porque o Regimento define como a pluralidade social se transforma em **decisão pública**, evitando que o Conselho seja governado por relações pessoais, por pressões externas ou por interesses privados. Isso inclui **regras de fala, gestão de conflitos de interesse, transparência de votações e critérios de deliberação**.

A **natureza organizativa** se expressa na estrutura interna, como **Plenário, Mesa Diretora, Secretaria Executiva, comissões intersetoriais e grupos de trabalho**, incluindo a possibilidade de participação de integrantes não conselheiros nas comissões. A exemplo a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (CISTT), recomenda-se que em sua composição tenha órgãos ou entidades da abrangência dos Cerest.Ou seja, a CISTT é responsável por assessoramento aos conselhos e apoio das discussões de saúde na temática de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, bem como na formulação, acompanhamento e fiscalização da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (PNSTT) dentro dos conselhos de saúde e aos CEREST. Conheça a cartilha da CISTT.

Para apoiar a elaboração ou revisão do Regimento, há que se guiar pelos fundamentos legais, composição e representatividade, e reforça a **paridade** como eixo de legitimidade, com **usuários** representando 50%, além de trabalhadores da saúde 25%, governo e prestadores 25%, cada qual com responsabilidades específicas na defesa do direito à saúde e na fiscalização do atendimento.

Diálogo com você, conselheira e conselheiro



Fonte: Autoria de IA.

Situação problema	
 Fonte: Autoria de IA.	Uma entidade privada prestadora de serviços tenta influenciar a pauta para acelerar a aprovação de um contrato. Como o Regimento pode estabelecer barreiras institucionais, como declaração de conflito de interesse, impedimento de voto, rito de análise em comissão e transparência das justificativas?

7.2 Regimento como critério de legitimidade deliberativa, quando a decisão é válida e respeitável

A **legitimidade deliberativa** não depende apenas de boa intenção, ela depende de procedimento correto e publicamente verificável. Por isso, o Regimento precisa detalhar quórum, rito de votação, registro em ata, publicidade das deliberações e prazos de encaminhamento. A Resolução 453/2012 orienta que o Plenário deve se reunir mensalmente,

que reuniões são abertas ao público e devem ocorrer em horários e espaços que favoreçam participação, e que a pauta e material de apoio devem ser enviados com antecedência mínima.

Quando o Conselho se manifesta, o faz por **atos deliberativos, como resoluções, recomendações e moções**, e a Resolução 453/2012 define que **resoluções devem ser homologadas em prazo de 30 dias**, com publicidade oficial, e que, na ausência de homologação e justificativa, as entidades podem buscar validação na justiça e no Ministério Público. Essa regra reforça uma ideia simples, a **decisão do Conselho não é "opinião", é deliberação institucional** que precisa circular e produzir efeitos, desde que construída com o rito legítimo.

Diálogo com você



Fonte: Gemini / nano banana

Situação problema



Fonte: Gemini / nano banana

7.3 Do texto do regimento para a prática registrada em atas: o que o caso do CMS de Vitória-ES ensina

O caso do Conselho Municipal de Saúde de Vitória, capital do Espírito Santo, oferece um exemplo de como o Regimento Interno se materializa no cotidiano do controle social e de como as atas se transformam em documentos políticos, administrativos e jurídicos que registram a vida institucional do conselho. A análise de 24 atas, sendo 15 de reuniões ordinárias e 9 de reuniões extraordinárias, revela um conselho com intensa demanda de atividades e com uso frequente de reuniões extraordinárias para dar conta da complexidade e do volume das pautas discutidas em reuniões realizadas entre fevereiro de 2010 e abril de 2011.

Ao confrontar as atribuições previstas no Regimento Interno com as práticas efetivamente registradas nas atas, observa-se que o Conselho atuou necessita fortalecer a participação ativa dos conselheiros em temas estratégicos, como o Plano Municipal de Saúde, as Audiências Públicas, a Prestação de Serviços de Saúde e o acompanhamento das políticas estruturantes do SUS no território. Também aponta a importância de redefinir e qualificar as atividades relacionadas ao próprio foco de análise do Conselho, ampliando sua capacidade de incidir de forma mais efetiva sobre a gestão do sistema.

Um aspecto particularmente sensível para a atuação das conselheiras e dos conselheiros refere-se ao modo como a paridade foi registrada nas atas. Embora os documentos tragam os nomes dos conselheiros presentes e dos convidados, não há a identificação dos segmentos que cada um representa, nem um padrão consistente para o registro das justificativas de ausência. Essa fragilidade documental compromete a transparência institucional e enfraquece a capacidade de defesa do Conselho em situações de conflito, questionamento administrativo ou judicialização das deliberações.

O efeito prático dessa lacuna é significativo, pois a ata é um documento público que comprova como o Conselho funcionou, quem participou das decisões e sob quais condições elas foram tomadas. Quando a ata não permite verificar com clareza a composição, a paridade, o quórum e o rito deliberativo, ela fragiliza a legitimidade institucional do Conselho e abre margem para contestações sobre a validade de suas decisões.

O estudo também sistematiza as atividades registradas nas atas a partir de “focos de análise”, como Fundo Municipal de Saúde, Plano Municipal de Saúde, Relatório Anual de Gestão, Audiência Pública e Prestação de Serviços de Saúde. Nesse levantamento, observa-se o predomínio de ações de “acompanhar” em detrimento de ações de “fiscalizar” no foco

relacionado ao Fundo Municipal de Saúde, o que revela um importante desafio formativo para o Conselho: ampliar sua capacidade técnica e política para exercer plenamente a função fiscalizatória, e não apenas acompanhar relatórios, convênios e prestações de contas.

Esse conjunto de achados mostra que o Regimento Interno não é um texto meramente formal, mas um instrumento que precisa ser permanentemente traduzido em práticas institucionais qualificadas, registradas com rigor e utilizadas como base para o fortalecimento do controle social no SUS.

Diálogo com você, conselheira e conselheiro



Fonte: Gemini / nano banana

Situação problema	
 Fonte: Autoria de IA.	Após uma decisão polêmica, um grupo questiona a validade da deliberação alegando ausência de quórum e falta de identificação dos segmentos na ata. Como você reorganizaria o padrão de elaboração das atas e o rito de verificação de presença, paridade e quórum para evitar que esse tipo de fragilidade institucional se repita?

7.4 Como elaborar ou revisar o regimento, um roteiro prático para conselhos que querem maturidade institucional

Um Regimento sólido começa pela **fundamentação legal** e pela clareza da estrutura e do processo decisório. O modelo de apoio recomenda alinhamento com as leis do SUS e com resoluções do CNS, com destaque para a Resolução 453/2012, além de legislação municipal pertinente, e orienta detalhar composição por segmentos, responsabilidades e instâncias internas.

Na dimensão de funcionamento, é indispensável definir:

- Periodicidade das reuniões;
- Quórum – transparência e critérios;
- Votação- transparência e critérios distinguindo maioria simples, absoluta e qualificada;
- Prever publicidade de atas e decisões;

Para a conselheira e o conselheiro, o ponto decisivo é perceber que o Regimento também é um instrumento de **formação permanente**, porque obriga o Conselho a **aprender a planejar, acompanhar, avaliar e fiscalizar.** Há que se observar as atribuições ligadas à aprovação do Plano, fiscalização do Fundo, avaliação de convênios e estímulo à participação social, indicando que o Conselho atua como elo entre governo e população e precisa transformar problemas do território em pautas, encaminhamentos, deliberações e monitoramento.

A Resolução 453/2012 reforça ainda obrigações de prestação de contas quadrimestral, com dados sobre plano, recursos, auditorias e oferta de serviços, o que deve estar espelhado no Regimento como rotina do plenário.

A Resolução 453/2012 será objeto de estudo no próximo capítulo!

Quadro 1- Elementos institucionais que facilitam a legitimidade das deliberações do Conselho de Saúde.

Elemento	O que é	Pergunta orientadora para o Conselho	Onde deve estar no Regimento
Quórum	Número mínimo para deliberar	Há presença suficiente para votar validamente?	Regras de reunião e deliberação
Paridade	Composição equilibrada com usuários em 50%, trabalhadores 25% e gestores 25%	A ata permite verificar segmentos e equilíbrio?	Composição e registro em ata
Publicidade	Transparência de reuniões e decisões	A comunidade consegue acessar pauta, ata e resolução?	Comunicação, atas e divulgação
Ato deliberativo	Resolução, recomendação, moção	O instrumento escolhido tem força adequada?	Capítulo de deliberações
Controle de gestão	Rotina de acompanhamento, avaliação e fiscalização	O Conselho fiscaliza ou apenas acompanha?	Pautas obrigatórias, comissões, prestação de contas

Diálogo com você, conselheira e conselheiro



Fonte: Gemini / nano banana

Situação problema	
 Fonte: Autoria de IA.	Seu Conselho existe, mas o Regimento está desatualizado e não prevê regras claras para comissões, tramitação de resoluções e participação do público. Como você conduziria uma revisão com participação dos segmentos, garantindo quórum qualificado para mudança, transparência do processo e incorporação das rotinas essenciais de prestação de contas e publicidade?

BIBLIOGRAFIA

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisas de Saúde e dos Ambientes de Trabalho. **Conheça a CISTT: Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora**. 2022. 20p.

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. Resolução nº 453, de 10 de maio de 2012. Aprova diretrizes para instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde.

GAVI, Rosangela Simonelli; GOMES, Maria José; FURBINO, Regina Villefort; CORSINI, Leydiane Rubia Ferreira; SOUZA, Patrícia Pereira de. O Conselho Municipal de Saúde de Vitória e seu regimento interno: um relato de caso. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 36, n. 93, p. 251 a 261, abr. jun. 2012.

MÓDULO III



Participa+SUS

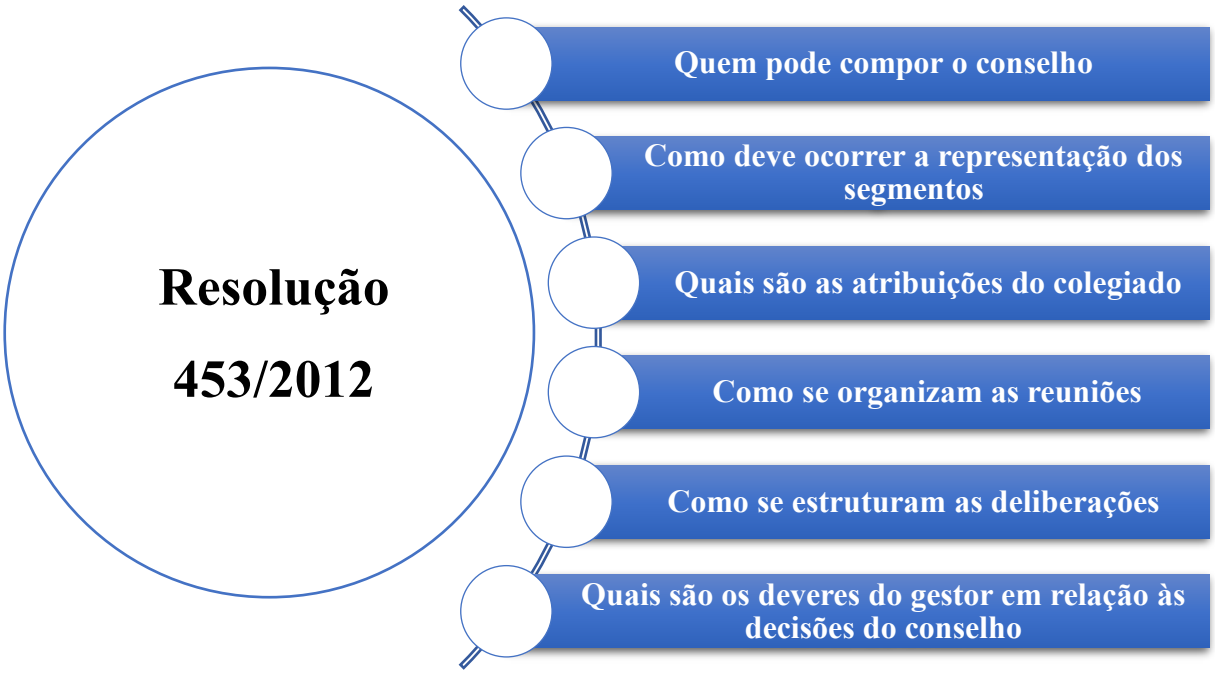
QUALIFICAÇÃO DE CONSELHEIRAS E CONSELHEIROS DE SAÚDE PARA A PARTICIPAÇÃO POPULAR E CONTROLE SOCIAL NO SUS

TEXTO 7 - Funcionamento e organização do Conselho de Saúde – Resolução 453

8 RESOLUÇÃO Nº 453/2012 - MARCO NORMATIVO QUE ORIENTA A INSTITUIÇÃO, A REFORMULAÇÃO, A ORGANIZAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE SAÚDE EM TODAS AS ESFERAS DE GOVERNO

A **Resolução nº 453, de 10 de maio de 2012**, do Conselho Nacional de Saúde, constitui o principal marco normativo que orienta a instituição, a reformulação, a organização e o funcionamento dos Conselhos de Saúde em todas as esferas de governo. A Resolução nº 453/2012 consolida o papel dos conselhos como instâncias colegiadas, deliberativas e permanentes do Sistema Único de Saúde (SUS), responsáveis por atuar na formulação de estratégias e no controle da execução das políticas públicas de saúde, inclusive em seus aspectos econômicos e financeiros.

Para a conselheira e o conselheiro de saúde, a Resolução nº 453/2012 representa uma ferramenta de atuação política e institucional, pois define:



A Resolução nº 453/2012 **materializa o princípio constitucional da participação da comunidade e expressa a concepção de que a democracia no SUS** se realiza por meio da atuação direta da sociedade organizada na formulação, no acompanhamento e na fiscalização das políticas de saúde.

Conhecer essa resolução, estudá-la e utilizá-la no cotidiano do conselho é uma condição para o exercício qualificado do controle social e para a defesa permanente do direito à saúde como direito de cidadania.

A seguir, leia integralmente a Resolução nº 453, de 10 de maio de 2012, do Conselho Nacional de Saúde.

8.1 Resolução Nº 453, de 10 de maio de 2012

Conselho Nacional de Saúde

O Plenário do Conselho Nacional de Saúde, em sua Ducentésima Trigésima Terceira Reunião Ordinária, realizada nos dias 9 e 10 de maio de 2012, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e pelo Decreto nº 5.839, de 11 de julho de 2006, e

Considerando os debates ocorridos nos Conselhos de Saúde, nas três esferas de Governo, na X Plenária Nacional de Conselhos de Saúde, nas Plenárias Regionais e Estaduais de Conselhos de Saúde, nas 9ª, 10ª e 11ª Conferências Nacionais de Saúde, e nas Conferências Estaduais, do Distrito Federal e Municipais de Saúde.

Considerando a experiência acumulada do Controle Social da Saúde e a necessidade de aprimoramento do Controle Social da Saúde no âmbito nacional e as reiteradas demandas dos Conselhos Estaduais e Municipais referentes às propostas de composição, organização e funcionamento, conforme o § 5º inciso II art. 1º da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

Considerando a ampla discussão da Resolução do CNS nº 333/03 realizada nos espaços de Controle Social, entre os quais se destacam as Plenárias de Conselhos de Saúde

Considerando os objetivos de consolidar, fortalecer, ampliar e acelerar o processo de Controle Social do SUS, por intermédio dos Conselhos Nacional, Estaduais, Municipais, das Conferências de Saúde e Plenárias de Conselhos de Saúde

Considerando que os Conselhos de Saúde, consagrados pela efetiva participação da sociedade civil organizada, representam polos de qualificação de cidadãos para o Controle Social nas esferas da ação do Estado

Considerando o que disciplina a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, e o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamentam a Lei Orgânica da Saúde

Resolve:

Aprovar as seguintes diretrizes para instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde

8.1.1 Da definição de conselho de saúde

Primeira Diretriz

O Conselho de Saúde é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera de Governo, integrante da estrutura organizacional do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com composição, organização e competência fixadas na Lei nº 8.142/90.

O processo bem-sucedido de descentralização da saúde promoveu o surgimento de **Conselhos Regionais, Conselhos Locais, Conselhos Distritais de Saúde, incluindo os Conselhos dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas,** sob a coordenação dos Conselhos de Saúde da esfera correspondente. Assim, os **Conselhos de Saúde são espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde.**

Parágrafo único. Como Subsistema da Seguridade Social, o Conselho de Saúde atua na formulação e proposição de estratégias e no controle da execução das Políticas de Saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros.

Diálogo com você, conselheira ou conselheiro



Fonte: Gemni / Nano Banana.

Situação problema	
 Fonte: Autoria de IA.	Em uma reunião ordinária, a presidência anuncia que a pauta será apenas "informes", porque "os assuntos técnicos já foram resolvidos na secretaria" e porque "o Conselho não pode travar a gestão".
Um grupo de conselheiros usuários reage, afirma que há fila reprimida de exames e que o município vai contratar um serviço privado sem debate público. **Como você sustenta, com base na definição de Conselho de Saúde, que o colegiado deve deliberar sobre prioridades e acompanhar execução, inclusive com impacto financeiro?** **Que encaminhamento você propõe para transformar "informes" em pauta deliberativa, sem perder o rito e sem personalizar o conflito?**	

***

8.1.2 Da instituição e reformulação dos conselhos de saúde

Segunda Diretriz

A instituição dos Conselhos de Saúde é estabelecida por lei federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, obedecida a Lei nº 8.142/90.

Parágrafo único. Na instituição e reformulação dos Conselhos de Saúde o Poder Executivo, respeitando os princípios da democracia, deverá acolher as demandas da população aprovadas nas Conferências de Saúde, e em consonância com a legislação.

Diálogo com você, conselheira ou conselheiro



Fonte: Gemni / Nano Banana.

<table>
<tr><th colspan="2">Situação problema</th></tr>
<tr><td> 

Fonte: Autoria de IA.</td><td>O mandato de várias entidades está vencido, mas elas continuam votando “para não parar o Conselho”.

Ao mesmo tempo, um movimento comunitário tenta entrar como entidade usuária e recebe a resposta de que “não há vaga”.

Em paralelo, a gestão pressiona por aprovação rápida do Plano Municipal de Saúde porque “o prazo está acabando”.</td></tr>
<tr><td colspan="2">1) Como você organiza uma estratégia de reformulação que preserve o funcionamento, mas recupere legitimidade, garantindo transição transparente, recadastramento, cronograma e critérios públicos?

2) Como você evita que a urgência do Plano seja usada para legitimar um Conselho com representação fragilizada?</td></tr>
</table>

***

8.1.3 DA Organização dos Conselhos de Saúde

Terceira Diretriz

A participação da sociedade organizada, garantida na legislação, torna os Conselhos de Saúde uma instância privilegiada na **proposição, discussão, acompanhamento, deliberação, avaliação e fiscalização da implementação da Política de Saúde**, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros.

A legislação estabelece, ainda, a composição paritária de usuários em relação ao conjunto dos demais segmentos representados. O Conselho de Saúde será composto por representantes de entidades, instituições e movimentos representativos de usuários, de entidades representativas de trabalhadores da área da saúde, do governo e de entidades representativas de prestadores de serviços de saúde, sendo o seu presidente eleito entre os membros do Conselho, em reunião plenária.

Nos Municípios onde não existem entidades, instituições e movimentos organizados em número suficiente para compor o Conselho, a eleição da representação será realizada em plenária no Município, promovida pelo Conselho Municipal de maneira ampla e democrática.

I – O número de conselheiros será definido pelos Conselhos de Saúde e constituído em lei.

II – Mantendo o que propôs as Resoluções nº 33/92 e nº 333/03 do CNS e consoante com as Recomendações da 10ª e 11ª Conferências Nacionais de Saúde, as vagas deverão ser distribuídas da seguinte forma:

a) 50% de entidades e movimentos representativos de usuários
b) 25% de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde
c) 25% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados ou sem fins lucrativos

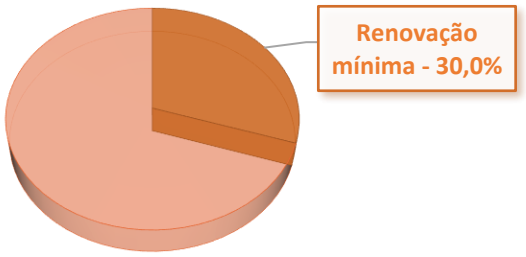


Fonte: Adaptado de Centro de Educação e Assessoramento Popular (2020), LM Notebook.

III – A participação de órgãos, entidades e movimentos sociais terá como critério a representatividade, a abrangência e a complementaridade do conjunto da sociedade, no âmbito de atuação do Conselho de Saúde.

IV – As entidades, movimentos e instituições eleitas no Conselho de Saúde terão os conselheiros indicados, por escrito, conforme processos estabelecidos pelas respectivas entidades, movimentos e instituições.

V – **Recomenda-se que, a cada eleição, os segmentos promovam a renovação mínima de 30% de suas entidades representativas.**



VI – A representação nos segmentos deve ser distinta e autônoma em relação aos demais segmentos.

VII – A ocupação de funções que interfiram na autonomia representativa deve ser avaliada como possível impedimento.

VIII – **A participação de membros do Poder Legislativo, Judiciário e Ministério Público como conselheiros não é permitida.**

IX – Quando não houver Conselho constituído, caberá ao Conselho Estadual ou Nacional assumir a convocação da Conferência.

X – **As funções não serão remuneradas.**

XI – **O conselheiro responde por seus atos conforme legislação vigente.**

Diálogo com você, conselheira ou conselheiro

Situação problema	
 Fonte: Autoria de IA.	O Conselho precisa deliberar sobre credenciamento de um serviço contratado. Um conselheiro que representa prestador participa da discussão como se fosse usuário e defende o contrato de forma agressiva. Enquanto a presidência tenta "acelerar a votação" sem debate. Depois, a comunidade denuncia conflito de interesse e pede anulação da deliberação.

1) Que regras organizativas você acionaria para garantir integridade, incluindo identificação de segmento em ata, declaração de impedimento quando couber, rito de discussão e registro do voto?

2) Como você conduz o enfrentamento sem moralismo e sem personalização, mas com proteção institucional do Conselho?



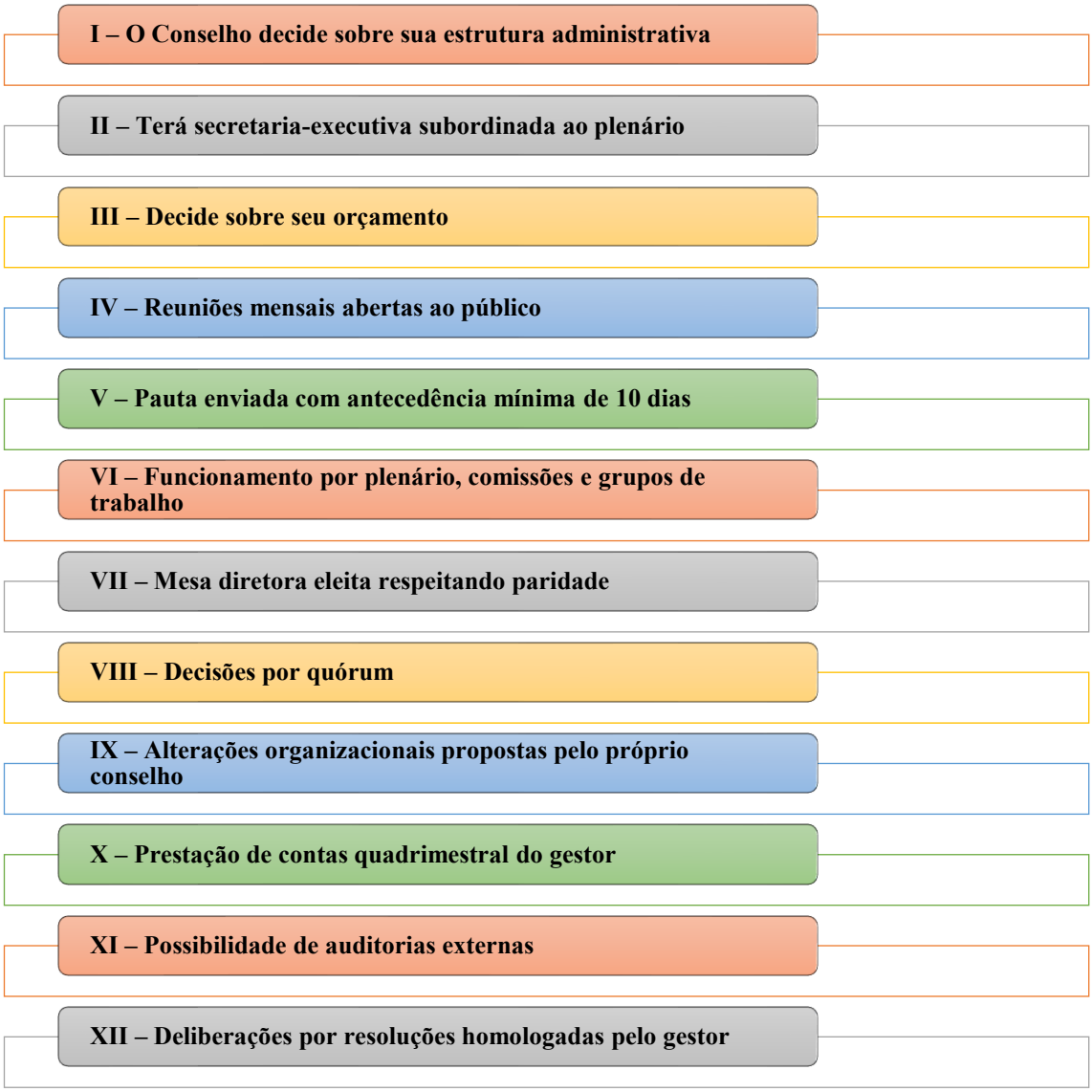
Fonte: Gemni / Nano Banana.

***

8.1.4 Estrutura e funcionamento dos Conselhos de Saúde

Quarta Diretriz

As três esferas de Governo garantirão autonomia administrativa, dotação orçamentária, autonomia financeira e organização da secretaria-executiva.



Para garantir a funcionalidade do Conselho de Saúde, evitar relações de poder entre os conselheiros e que se instaurem rotinas burocráticas há a **sugestão de estrutura organizacional** com **Plenário, Presidência, Mesa Diretora, Secretaria Executiva**, e **assessorias ao plenário** por meio das **Comissões e dos Grupos de Trabalho**, definidos de acordo com a necessidade. capazes de prejudicar as atividades de trabalho. A estrutura organizacional e de funcionamento e as principais atribuições são descritas na Resolução nº 333, de 2003, do Conselho Nacional de Saúde.

Plenário	- Fórum de deliberação do Conselho; - Reúne-se, no mínimo, a cada mês ou quando necessário; - Funciona de acordo com o regimento interno; - Reuniões são abertas ao público.
Presidência	- Ocupada por um dos conselheiros titulares; - Conduz a reunião do Plenário; - Representa o Conselho de Saúde.
Mesa Diretora	- Composta por conselheiros titulares, eleitos pelo Plenário, inclusive o presidente; - Conduz os processos administrativos e políticos a serem deliberados pelo Plenário; - Promove articulações políticas internas e externas; - Garante a intersetorialidade do controle social.
Secretaira Executiva	- Fornece o suporte técnico administrativo ao Conselho de Saúde; - Subordinada ao Plenário.
Comissões	- Prestam assessoria ao Plenário; - Intersetoriais; - Podem possuir caráter temporário ou permanente.
Grupos de Trabalho	- Constituídos pelo Plenário para assessorar o Conselho ou as Comissões; - Executam um trabalho com objetivos e prazos definidos.

Diálogo com você, conselheira ou conselheiro



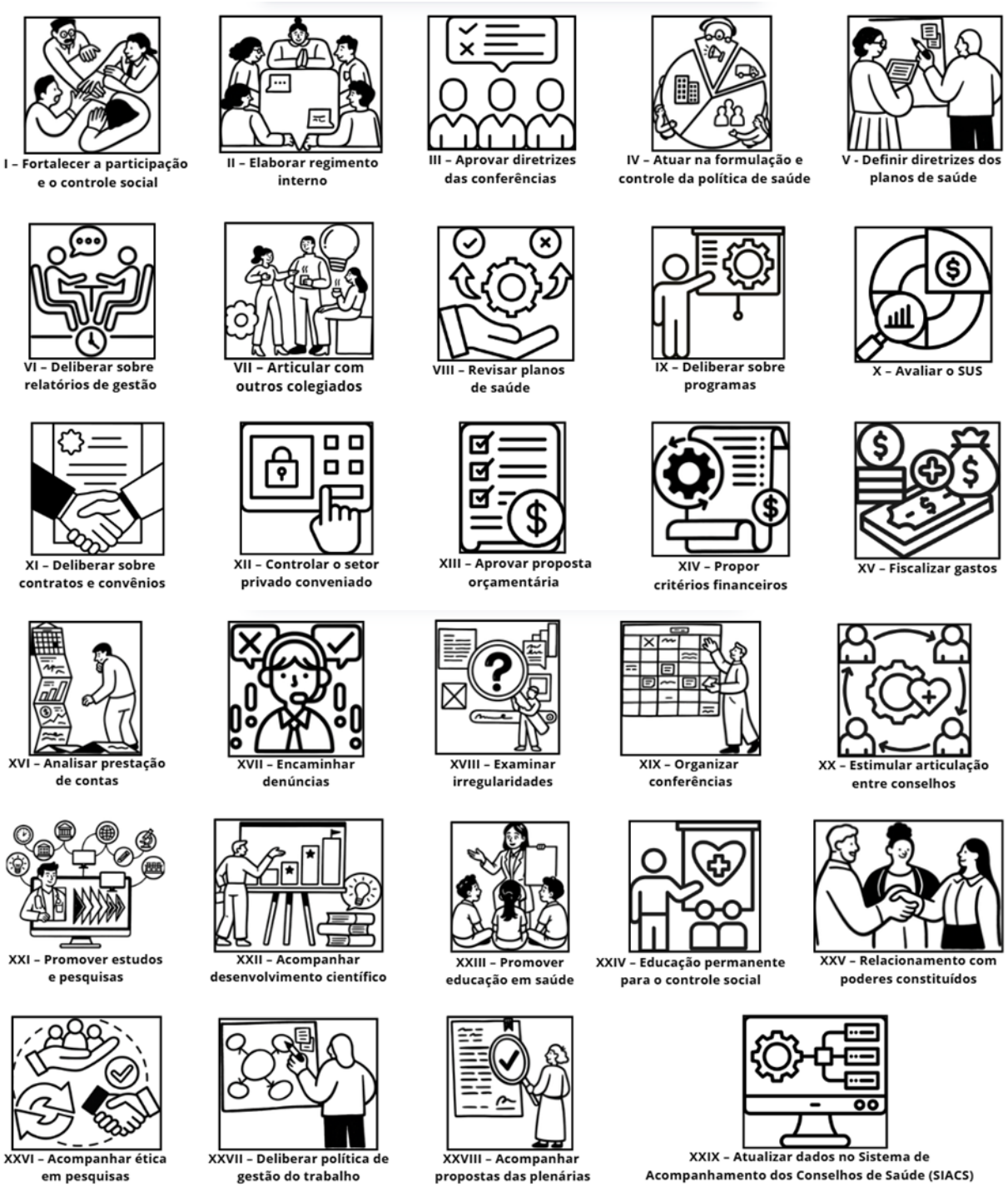
Fonte: Gemni / Nano Banana.

Situação problema	
 Fonte: Autoria de IA.	Durante uma crise na rede de saúde, a presidência do conselho convoca uma reunião extraordinária com pauta ampla e sem documentos anexos, e propõe deliberar sobre remanejamento de recursos do Fundo Municipal de Saúde em 1 hora.
Metade do plenário chega atrasada por falta de transporte e a lista de presença não identifica segmentos. Depois, a gestão executa a decisão e, quando a comunidade questiona, a ata está incompleta. **1) Como você redesenha o rito de funcionamento para impedir que urgências virem atalhos antidemocráticos, garantindo convocação com justificativa, pauta com documentos, verificação de quórum, identificação por segmento, registro de debate e publicidade ativa?**	

***

8.1.5 Competências dos Conselhos de Saúde

Quinta Diretriz - Compete aos Conselhos de Saúde:



Fonte: Autoria própria, com recursos do Canva, 2026.

[1]Sistema de Acompanhamento dos Conselhos de Saúde (SIACS): Sistema de informação de dados de cadastro dos Conselhos de Saúde contendo informações relevantes para mapear o controle social de saúde como composição e cumprimento de paridade (Brasil, 2013).

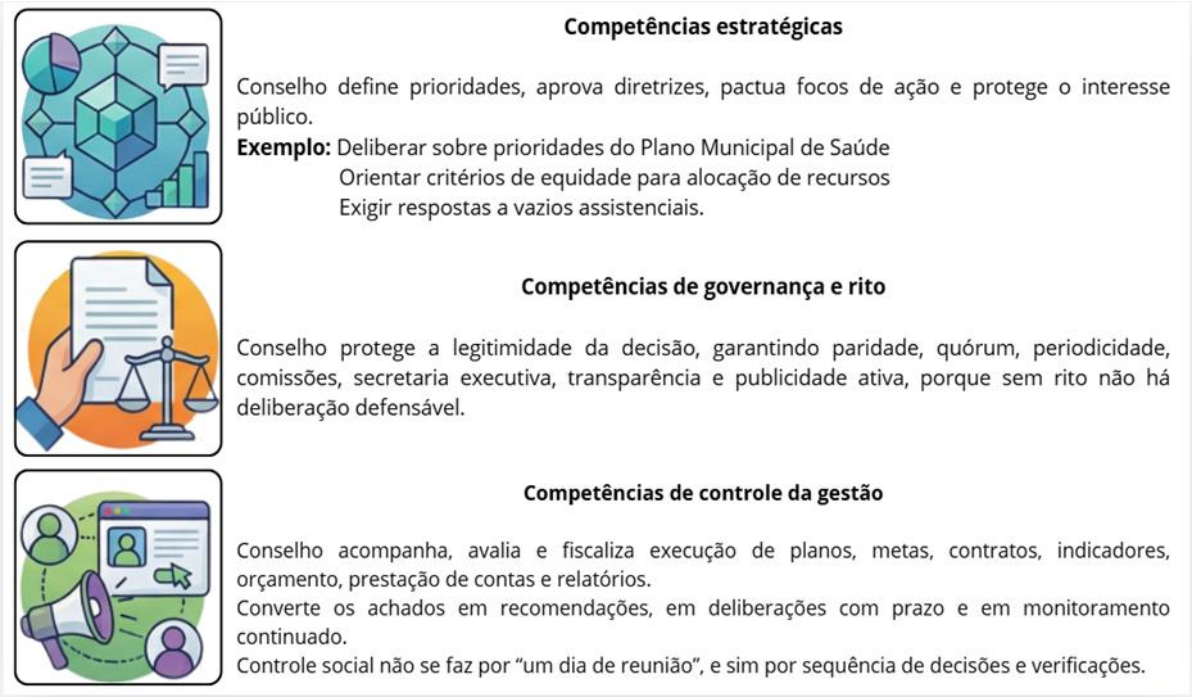
As competências do conselho de saúde é o "coração" da Resolução, onde o conselheiro mais precisa de método, coragem e evidência

Competências são os poderes responsabilidades do Conselho para formular, deliberar, acompanhar, fiscalizar e avaliar a política de saúde, inclusive nos aspectos financeiros.

Aqui costuma surgir um erro comum e perigoso, o Conselho pode ficar preso na atividade de "acompanhar" relatórios e apresentações da gestão, sem conseguir transformar informação em fiscalização e deliberação, e as evidências mostram que a efetividade da participação social depende de condições, como acesso prévio a informações, qualificação para leitura de instrumentos de gestão, autonomia organizativa, e capacidade de construir sujeitos políticos com base social, caso contrário o Conselho vira formalidade e perde sua função democrática.

Para tornar as competências praticáveis, um caminho pedagógico é **organizar a atuação do Conselho em três blocos de competência**, sempre lembrando que **esses blocos se misturam na prática** e exigem registro em ata e desdobramento em resolução, recomendação ou moção, conforme a força do ato necessário.

Figura 1 – Blocos de competência de organização da atuação do Conselho de Saúde.



Fonte: Autoria própria, com recursos do Canva, 2026.

Diálogo com você, conselheira ou conselheiro



Fonte: Gemni / Nano Banana.

Situação problema	
 Fonte: Autoria de IA.	O Conselho recebe o Relatório Anual de Gestão com centenas de páginas, sem resumo executivo, e a gestão pede aprovação imediata "para não perder prazo". Ao mesmo tempo, a comunidade denuncia falta de medicamentos, aumento de óbitos evitáveis e fechamento de serviços na periferia ou na zona rural, enquanto o relatório destaca "expansão de cobertura" sem mostrar desigualdade por território.
1) Como você exerce as competências do Conselho, organizando um plano de ação em etapas, que inclua pedido formal de informações complementares, audiências com áreas técnicas, construção de perguntas orientadoras por eixo, definição de indicadores simples de acompanhamento e deliberação com condicionantes, tudo isso sem paralisar o município, mas também sem legitimar uma aprovação vazia?	

***

8.1.6 Desafios acerca da aplicação da Resolução nº 453/2012

Para quem atua no cotidiano dos Conselhos Municipais de Saúde, é fundamental compreender que a força da Resolução nº 453/2012 não está apenas no que ela afirma explicitamente, mas também nos pontos em que a norma deixa margens para interpretações, disputas e conflitos que podem fragilizar o controle social se não forem enfrentados de forma crítica.

a) **Não estar explícito o alcance da autonomia política dos Conselhos frente ao Poder Executivo:**

A Resolução nº 453 reconhece **o Conselho de Saúde como espaço de deliberação política** e não apenas como instância consultiva ou administrativa. Porém, não deixa explícito sua autonomia política,

Na prática, essa ausência de detalhamento abre espaço para que **gestões municipais concentrem poder sobre a definição de pautas, a condução das reuniões e até a forma como as decisões são registradas em atas.** Quando isso ocorre, o conselho corre o risco de se tornar um espaço de validação de decisões já tomadas, **enfraquecendo sua função constitucional de controle social e comprometendo a participação efetiva da comunidade**.

b) **Composição e paridade no Conselho de Saúde:**

Outro ponto que exige atenção crítica do conselheiro e da conselheira de saúde diz respeito à composição e à paridade. A resolução estabelece que **os usuários devem ocupar 50% das cadeiras do conselho**, enquanto os **outros 50% são divididos entre trabalhadores da saúde e gestores ou prestadores de serviços**.

Embora essa regra busque equilibrar interesses, a junção de gestores públicos e prestadores privados em um mesmo bloco pode gerar conflitos silenciosos, pois esses segmentos não possuem os mesmos objetivos. Enquanto o **gestor é responsável pela política pública e pela garantia do direito à saúde**, o **prestador pode estar vinculado a interesses econômicos**.

Sem uma leitura crítica dessa composição, o conselho pode perder sua capacidade de defender o interesse público de forma clara e transparente.

A resolução também apresenta uma **lista exemplificativa de entidades** e **movimentos sociais aptos a compor os conselhos**. Embora a intenção seja ampliar a representatividade, essa forma de apresentação **pode gerar interpretações equivocadas, como se apenas os grupos mencionados tivessem legitimidade para participar**.

Para o controle social, isso é um risco, pois pode excluir movimentos, coletivos e organizações que atuam no território, mas que não aparecem nominalmente na norma. Cabe ao conselho compreender que a representatividade deve ser construída a partir da realidade local, respeitando a diversidade social, cultural e territorial, sem hierarquizar ou privilegiar determinados segmentos em detrimento de outros.

c) **Recomendação de renovação periódica dos conselheiros:**

A Resolução nº 453 aponta a **necessidade de renovação mínima de entidades representadas, com o objetivo de evitar a cristalização de lideranças e ampliar a participação**. No entanto, quando essa renovação não vem acompanhada de processos contínuos de formação, ela pode fragilizar o conselho, provocando perda de memória institucional e dificuldade de acompanhamento de temas complexos, como financiamento, planejamento e avaliação da gestão.

Para a conselheira e conselheiro, é essencial compreender que renovação e formação precisam caminhar juntas para fortalecer, e não enfraquecer, o controle social.

d) **Condições materiais de funcionamento dos Conselhos de Saúde:**

As condições materiais de funcionamento dos conselhos constituem um dos **maiores desafios para a efetivação da autonomia prevista na resolução.**

Muitos Conselhos Municipais de Saúde funcionam dentro das Secretarias de Saúde, sem sede própria, equipe técnica, orçamento específico ou apoio administrativo adequado.

Essa **dependência estrutural compromete a independência do conselho e limita sua capacidade de fiscalizar, analisar documentos, acompanhar indicadores e produzir deliberações qualificadas**. A resolução reconhece a necessidade de apoio, mas, quando esse apoio se transforma em controle, o conselho perde sua força política e institucional.

Para a prática cotidiana da conselheira e do conselheiro de saúde, a principal lição é que conhecer a **Resolução nº 453 não significa apenas saber o que está escrito, mas compreender como ela se materializa no cotidiano do conselho**:

- Atas incompletas;
- Ausência de registro de paridade;
- Quórum mal definido;
- Votações pouco claras;
- Falta de divulgação das decisões.

Não são detalhes burocráticos, são **sinais de fragilidade do controle social e de ameaça à democracia no SUS**. Cada reunião, cada ata e cada deliberação são atos políticos que precisam estar alinhados com os princípios constitucionais da participação social, da transparência e da defesa do interesse público.

Assim, a Resolução nº 453 deve ser lida como um instrumento vivo, que orienta, mas também desafia a atuação dos Conselhos de Saúde. Ela oferece uma base normativa importante, mas a garantia do controle social amplo, autônomo e efetivo depende da postura crítica, do compromisso ético e da capacidade política das conselheiras e dos conselheiros de saúde em transformar a norma em prática cotidiana a serviço do direito à saúde.

BIBLIOGRAFIA

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 333, de 4 de novembro de 2003. Aprova as diretrizes para criação, reformulação, estruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde. **Diário Oficial da União***:* seção 1, Brasília, DF, ano 140, n. 236, p. 57, 4 dez. 2003. ISSN 1677-7042. Disponível em: https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/atos-normativos/resolucoes/2003/resolucao-no-333.pdf. Acesso em: 16 mar. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 453, de 10 de maio de 2012. Aprova as diretrizes para instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde. **Diário Oficial da União***:* seção 1, Brasília, DF, ano 149, n. 109, p. 138, 6 jun. 2012. Disponível em: https://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso453.pdf. Acesso em: 29 jan. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. **Conselhos de saúde***:* a responsabilidade do controle social democrático do SUS. 2. ed. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2013. 28 p. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/conselhos_saude_responsabilidade_controle_2edicao.pdf. Acesso em: 16 mar. 2026.

CENTRO DE EDUCAÇÃO E ASSESSORAMENTO POPULAR. **O SUS e a efetivação do direito humano à saúde**. 2. ed. Passo Fundo: Editora Passografic Libri, 2020. 117 p. Disponível em: https://ceap-rs.org.br/wp-content/uploads/2023/12/ceap.pdf. Acesso em: 16 mar. 2026.

LIMA, Dartel Ferrari de; LIMA, Lohran Anguera. O controle social no Sistema Único de Saúde: um olhar crítico à Resolução nº 453/2012. **Saúde em Debate***,* Rio de Janeiro, v. 41, n. 115, p. 1168-1176, out./dez. 2017. DOI: https://doi.org/10.1590/0103-1104201711514.

TEXTO 8 – Os instrumentos de gestão na pauta do Conselho de Saúde

A **Resolução CNS nº 453/2012** afirma que o Conselho de Saúde é uma instância **deliberativa, permanente e colegiada**, com competência para atuar na **formulação, acompanhamento, avaliação e controle da política de saúde**, inclusive em seus aspectos econômicos e financeiros.

Os **instrumentos de gestão** organizam o **ciclo decisório do SUS** e materializam escolhas políticas sobre prioridades, alocação de recursos, metas, estratégias e compromissos públicos. Quando esses instrumentos são analisados de forma tardia, fragmentada ou apenas para homologação, o Conselho perde sua capacidade deliberativa. Quando, ao contrário, são discutidos no tempo adequado, com informação compreensível e espaço real para divergência, o Conselho cumpre sua função constitucional.

Compete ao Conselho de Saúde **atuar na formulação e no controle da execução da política de saúde**, o que exige domínio e uso crítico dos principais instrumentos de gestão, entre eles o **Plano de Saúde**, a **Programação Anual de Saúde**, o **Relatório Anual de Gestão**, o **Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior**. Esses documentos definem o que será feito, com quais recursos, em que prazo e com quais resultados esperados.

9 OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DA SAÚDE E DO ORÇAMENTO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL NO SUS

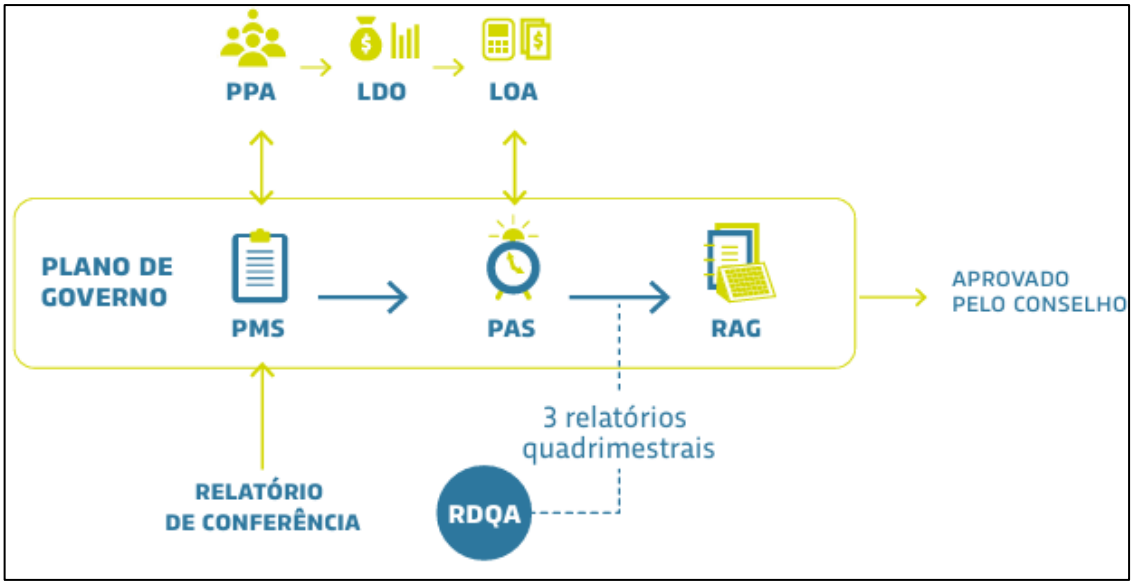
O planejamento no SUS não pode ser compreendido como um procedimento meramente administrativo ou como um conjunto de documentos formais exigidos pela legislação. Trata-se de um **processo político, técnico e social**, no qual se expressam disputas de projetos, prioridades públicas e concepções de Estado e de saúde.

No SUS, o planejamento constitui uma mediação estruturante entre as diretrizes políticas pactuadas democraticamente e a ação dos serviços de saúde no território. É nesse espaço que o controle social encontra seu campo mais potente de atuação, pois é por meio dos instrumentos de planejamento que as necessidades de saúde da população são traduzidas em compromissos institucionais, metas, alocação de recursos e prestação de contas.

O planejamento se organiza como um **processo cíclico, integrado e sistêmico**, composto por instrumentos interdependentes que se retroalimentam. No campo da saúde, esse ciclo é

estruturado fundamentalmente pelo **Plano de Saúde**, pelas **Programações Anuais de Saúde (PAS)** e pelos **Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA)** e **Relatório Anual de Gestão (RAG)**. Esses instrumentos se articulam, de forma obrigatória, com os instrumentos gerais do planejamento e do orçamento governamental: o **Plano Plurianual (PPA)**, a **Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)** e a **Lei Orçamentária Anual (LOA)**. Essa articulação é condição legal e política para a efetivação do direito à saúde, pois sem correspondência orçamentária o planejamento em saúde se reduz a um exercício retórico.

Figura 1 - Integração dos instrumentos de Planejamento e Gestão do SUS e Legislação Vigente.



Nota: LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias; LOA – Lei Orçamentária Anual; PMS – Plano Municipal de Saúde; PAS – Programação Anual de Saúde; PPA – Plano Plurianual; RAG – Relatório Anual de Gestão; RDQA – Relatório Detalhado do Quadriênio Anterior.
Fonte: COSEMS-RJ, LAPPIS/IMS/UERJ, 2019.

Do ponto de vista do controle social, compreender essa engrenagem é indispensável, pois o **Conselho de Saúde** não atua apenas avaliando documentos ao final do processo, mas **acompanhando criticamente todo o ciclo do planejamento**, desde a definição das prioridades até a análise da execução financeira e dos resultados alcançados**.** O **planejamento**, portanto, **é o território onde se materializa a democracia sanitária.**

9.1 Quem elabora o Plano Plurianual – PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA e como esses instrumentos se articulam ao planejamento em saúde e ao controle social no SUS

No Estado brasileiro, o planejamento governamental e o planejamento em saúde estão estruturados em um **arranjo integrado de instrumentos legais**, no qual o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) constituem o principal eixo do ciclo orçamentário, ao qual o Sistema Único de Saúde deve, obrigatoriamente, se vincular. O planejamento em saúde é parte constitutiva do planejamento governamental geral, devendo respeitar seus tempos, regras e instrumentos, ao mesmo tempo em que incorpora as especificidades do setor saúde e a participação social institucionalizada.

Figura 2 - Cronograma dos instrumentos de planejamento e orçamento.



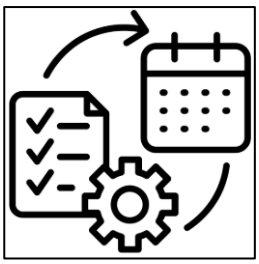
Nota: LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias; LOA – Lei Orçamentária Anual; PMS – Plano Municipal de Saúde; PAS – Programação Anual de Saúde; PPA – Plano Plurianual; RAG – Relatório Anual de Gestão; RDQA – Relatório Detalhado do Quadriênio Anterior.
Fonte: COSEMS-RJ, LAPPIS/IMS/UERJ, 2019.

A **responsabilidade formal pela elaboração do PPA, da LDO e da LOA é do Poder Executivo**, em cada esfera de governo e cabe ao chefe do Executivo e às áreas técnicas de planejamento e orçamento coordenar a formulação desses instrumentos e encaminhá-los ao Poder Legislativo para apreciação, discussão e aprovação, dentro dos prazos constitucionais. Essa atribuição decorre do desenho federativo estabelecido pela Constituição Federal de 1988 e é reafirmada ao situar o planejamento como uma função gestora obrigatória, contínua e estruturante da ação do Estado.

Quadro 1 – Características dos instrumentos de Planejamento e Orçamento de Saúde.

Instrumentos	Informações importantes	Periodicidade	Normativas
Plano Plurianual (PPA)	Diretrizes, objetivos e metas da administração pública para despesas de capital e outras delas decorrentes para as relativas aos programas de duração continuada, de forma regionalizada	Quadrienal	Constituição Federal de 1988
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)	Metas e prioridades da administração pública, diretrizes da política fiscal e respectivas metas	Anual	Constituição Federal de 1988
Lei Orçamentária Anual (LOA)	I – Previsão de receita e fixação de despesas nos programas temáticos om meta quantitativa definida; II – Orçamentos: fiscal, de investimentos e de seguridade social.	Anual	Constituição Federal de 1988

Fonte: Cruz et al., 2023



O **Plano Plurianual (PPA)** é o instrumento de **planejamento governamental de médio prazo**, com vigência de **quatro anos**, sendo apresentado no primeiro ano do mandato do Poder Legislativo e iniciado no segundo ano, e com término no primeiro ano do mandato seguinte.

O Poder Executivo define diretrizes, objetivos e metas que orientam os programas governamentais e as despesas de capital e continuadas. No SUS, o PPA deve dialogar diretamente com o **Plano de Saúde**, também quadrienal, ainda que se trate de instrumentos distintos.



O Plano de Saúde **organiza-se a partir da análise da situação de saúde, das necessidades da população e das pactuações interfederativas**, enquanto o **PPA expressa as escolhas estratégicas do governo no conjunto das políticas públicas**.

Para o controle social, essa articulação é primordial, pois **permite verificar se as prioridades sanitárias** deliberadas no âmbito do **SUS estão efetivamente incorporadas aos programas e ações** previstos no planejamento governamental.



A **Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)** é elaborada **anualmente** pelo Poder Executivo e tem a função de **orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual**, estabelecendo metas, prioridades e parâmetros fiscais para o exercício seguinte.

No planejamento em saúde, a **Programação Anual de Saúde deve ser compatibilizada com a LDO**, pois é nesse momento que as diretrizes do Plano de Saúde são traduzidas em prioridades anuais factíveis do ponto de vista orçamentário.

Embora o conselho de saúde não elabore a LDO, cabe-lhe avaliar a Programação Anual de Saúde antes do envio da LDO ao Legislativo, exercendo uma função estratégica de controle social preventivo, ao verificar se as ações e metas propostas para a saúde encontram respaldo nas diretrizes orçamentárias do governo.



A **Lei Orçamentária Anual (LOA)**, também de iniciativa do Poder Executivo, detalha, **para cada exercício financeiro**, a **previsão de receitas e a fixação das despesas públicas**, autorizando a execução do orçamento.

No âmbito do SUS, a LOA é o instrumento que materializa financeiramente o planejamento, pois nela se explicitam os recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde.

A **LOA** deve guardar **coerência com o Plano de Saúde**, **com a Programação Anual de Saúde e com as diretrizes da LDO**, sendo sua execução objeto de acompanhamento sistemático por meio dos relatórios de gestão e dos relatórios quadrimestrais, que subsidiam o exercício do controle social.

Do ponto de vista do **controle social no SUS**, há uma distinção entre **elaborar** e **deliberar, acompanhar e controlar** e os conselhos de saúde não são responsáveis pela elaboração do PPA, da LDO ou da LOA, mas exercem papel decisivo ao formular estratégias, controlar a execução da política de saúde, analisar e deliberar sobre os instrumentos de planejamento do SUS e acompanhar a execução orçamentária e financeira.

Essa atuação permite que o planejamento orçamentário não se restrinja a um exercício técnico-administrativo, mas se converta em um processo político orientado pelas necessidades de saúde da população e pelos princípios do SUS.

<table>
<tr><th colspan="2">Situação problema</th></tr>
<tr><td> 

Fonte: Autoria de IA.</td><td>O Conselho de Saúde aprova um Plano de Saúde com forte ênfase na Atenção Primária e na redução de iniquidades, mas identifica que o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual concentram recursos em ações hospitalares de alta complexidade.</td></tr>
<tr><td colspan="2">1) Onde se rompeu o ciclo do planejamento?
2) Quais instrumentos o controle social deve mobilizar para recompor essa coerência?</td></tr>
</table>

***

9.2 O Plano de Saúde para o controle social

O **Plano de Saúde** é o principal instrumento de planejamento do SUS e representa, de forma estruturada, **o projeto político sanitário de uma gestão para um período de quatro anos**. Não se trata de um documento meramente burocrático, nem de um relatório técnico produzido exclusivamente por equipes de gestão, pois o Plano de Saúde **expressa escolhas, prioridades, disputas e compromissos do Estado com a saúde da população de um território** e por essa razão, ele ocupa lugar estratégico no exercício do controle social e na atuação do Conselho de Saúde.

Do ponto de vista normativo, o Plano de Saúde está previsto na **Lei nº 8.080 de 1990**, na **Lei Complementar nº 141 de 2012**, no **Decreto nº 7.508 de 2011** e em normativas do Conselho Nacional de Saúde.

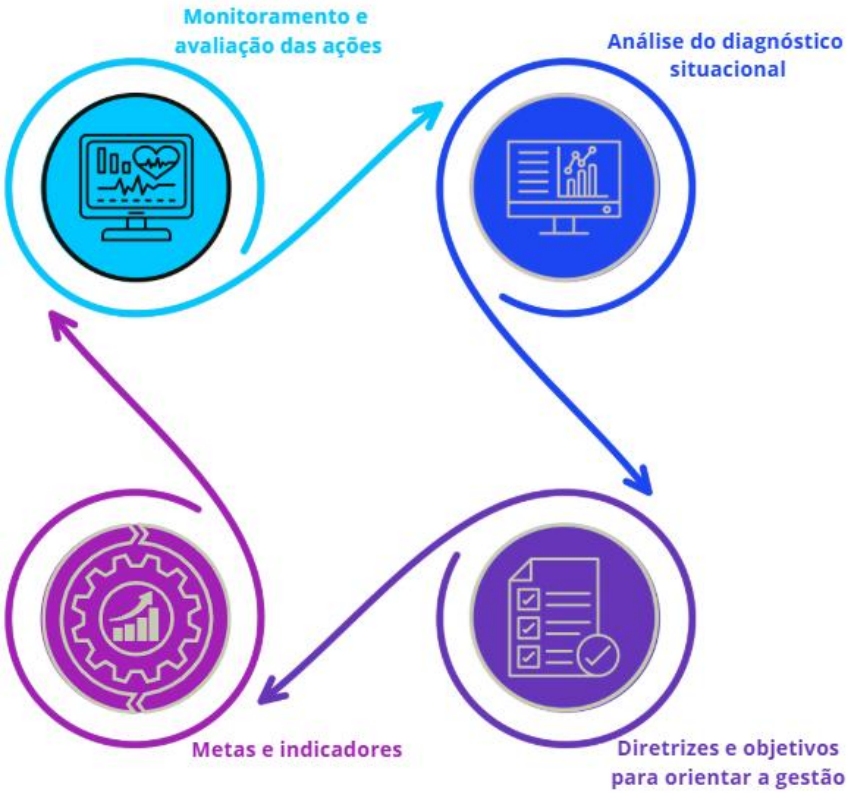
Do ponto de vista conceitual, a literatura o reconhece como um **instrumento estratégico de mediação entre necessidades sociais de saúde, decisões políticas e organização dos serviços**. Planejar, no SUS, é transformar problemas de saúde vividos pela população em diretrizes, objetivos, metas e ações financiadas e monitoráveis.

Para a conselheira e o conselheiro de saúde, compreender o Plano de Saúde é compreender **onde o SUS pretende chegar**, **por quais caminhos**, **com quais recursos** e **com quais critérios de avaliação** e sem esse domínio, o controle social perde potência e tende a se restringir à aprovação formal de documentos.

9.2.1 O que é o Plano de Saúde e qual sua função no SUS

O Plano de Saúde é um **instrumento quadrienal**, elaborado no primeiro ano de gestão, que orienta todas as ações e serviços de saúde de uma esfera de governo. Ele organiza a política de saúde a partir de uma **análise da situação de saúde da população**, define **diretrizes**, explicita **objetivos estratégicos**, estabelece **metas mensuráveis** e indica **indicadores para monitoramento e avaliação**.

Figura 3 – Organização do Plano de Saúde



Fonte Autoria própria, com recursos do Canva, 2026.

Sua função é múltipla:

- Orientar a gestão do SUS no médio prazo;
- Garantir coerência entre necessidades de saúde e ações planejadas;
- Subsidiar a Programação Anual de Saúde e o orçamento público;
- Permitir o acompanhamento sistemático pelo Conselho de Saúde;
- Servir de referência para a avaliação da gestão e a prestação de contas.

Na prática, o Plano de Saúde funciona como **a espinha dorsal do planejamento da saúde** e nenhuma ação importante deveria existir fora dele, salvo situações excepcionais como emergências sanitárias.

9.2.2 O Plano de Saúde como pacto público entre Estado e sociedade

Um aspecto primordial, muitas vezes pouco compreendido, é que o Plano de Saúde não é apenas um instrumento da gestão, mas um **pacto público entre Estado e sociedade**. Ele deve incorporar:

- Diretrizes nacionais do SUS;
- Diretrizes estaduais ou municipais pactuadas;
- Deliberações das Conferências de Saúde;
- Prioridades definidas pelo Conselho de Saúde.

Por isso, a legislação assegura **participação popular** e **realização de audiências públicas** durante o processo de elaboração e discussão do Plano. O Conselho de Saúde não atua ao final, apenas homologando um texto pronto e deve participar da construção política do Plano, tensionando prioridades, problematizando escolhas e defendendo os interesses da população.

Para a conselheira e o conselheiro, isso significa compreender que **aprovar um Plano de Saúde é assumir corresponsabilidade sobre o rumo da política de saúde** naquele território.

9.2.3 Etapas para a elaboração do Plano de Saúde

A elaboração do Plano de Saúde segue um encadeamento lógico e técnico que precisa ser compreendido pelo controle social. O Manual de Planejamento do SUS explicita esse percurso de forma clara.

Quadro 2 – Percurso de elaboração do Plano de Saúde

Etapa	Sentido no planejamento	Papel do Conselho
Análise da situação de saúde	Identificar problemas, necessidades e desigualdades	Questionar prioridades, invisibilidades e dados omitidos
Definição de diretrizes	Expressar escolhas políticas	Avaliar coerência com princípios do SUS
Formulação de objetivos	Indicar mudanças desejadas	Verificar relevância e viabilidade
Estabelecimento de metas	Tornar compromissos mensuráveis	Exigir metas claras e monitoráveis
Definição de indicadores	Permitir acompanhamento e avaliação	Avaliar adequação dos indicadores
Monitoramento e avaliação	Aprender com a execução	Acompanhar continuamente

Fonte: Brasil, 2016.

9.2.4 A análise da situação de saúde como base do Plano de Saúde

A **análise de situação de saúde**, construída com base no **Mapa da Saúde**, é o ponto de partida desse processo, essa análise permite **identificar problemas, necessidades, desigualdades territoriais e gargalos de acesso**, traduzindo a realidade sanitária em informações organizadas.

Quando essa análise é consistente, ela **orienta a definição de diretrizes, objetivos e metas do Plano de Saúde** e, posteriormente, **sustenta a Programação Anual de Saúde e a prestação de contas**. Quando é frágil ou meramente formal, todo o ciclo seguinte se enfraquece, e o Conselho passa a discutir documentos sem lastro na realidade do território.

A análise da situação de saúde é o ponto de partida do Plano de Saúde. Ela não se limita a indicadores epidemiológicos tradicionais, como mortalidade e morbidade. A abordagem adotada pelo SUS incorpora múltiplas dimensões:

- Condições de vida da população;
- Acesso e qualidade dos serviços de saúde;
- Organização das redes de atenção;
- Distribuição territorial de recursos;
- Determinantes sociais da saúde;
- Situação de grupos em maior vulnerabilidade.

O **Mapa da Saúde**, instituído pelo **Decreto nº 7.508 de 2011**, **organiza essas informações e orienta a análise situacional**. Para o controle social, essa etapa é estratégica, pois é nela que se **define quais problemas entram na agenda pública e quais permanecem invisíveis**. Uma análise de situação frágil compromete todo o Plano. Se os problemas não são bem identificados, as diretrizes serão genéricas, as metas pouco relevantes e o orçamento mal direcionado.

As informações do **Mapa da Saúde** devem permitir ao gestor do SUS entender questões estratégicas do planejamento, incluindo, entre outros, o georreferenciamento de informações relacionadas a temas como:

Figura 4 – Conteúdos que integram o Mapa de Saúde.



Fonte: Brasil, 2014.

a) **Estrutura do sistema de saúde**, com capacidade instalada pública (própria e privada complementar) e privada, evidenciando estabelecimentos, serviços, equipamentos e profissionais, e com oferta e cobertura de ações e serviços por indicadores baseados em parâmetros reconhecidos e na produção de serviços;

b) **Redes de atenção à saúde**, com indicadores que evidenciem a atenção básica como ordenadora da rede e indicadores relacionados à implementação de redes prioritárias; e o texto segue detalhando outros temas na continuidade do material.

c) **Condições socio sanitárias,** com indicadores de nascimento, mortalidade, morbidade, dados socioeconômicos e demográficos. Analisa situação de saúde de grupos populacionais de maior vulnerabilidade e os determinantes sociais de saúde**;**

d) **Fluxos de acesso** evidencia o fluxo assistencial identificando o caminho e a distância percorridos pelos usuários**;**

e) **Recursos financeiros** identifica os investimentos e o custeio para o financiamento do sistema**;**

f) **Gestão,** contém indicadores quanto aos processos de regionalização, planejamento, regulação, participação e controle social, e de pesquisas de satisfação dos usuários do SUS**;**

g) **Gestão do trabalho e da educação na saúde,** identifica a quantidade de trabalhadores nos serviços e redes temáticas; condições de trabalho, formação e qualificação profissional e características dos centros formadores**;**

h) **Ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde e gestão**, apresenta a distribuição das instituições e suas capacidades e especialidades técnicas, públicas e privadas, de pesquisa, produção e inovação em saúde.

O Mapa de Saúde contém dois produtos que auxiliam na análise dos Mapas. O **Geo Saúde,** sistema de georreferenciamento de dados; e a **Análise em Saúde,** que realiza a combinação e análise de informações a partir da combinação de variáveis com o Geo Saúde. Produz informações para a tomada de decisões.

Figura 5 – Ferramentas do Mapa de Saúde.



Fonte: Brasil, 2014.

Diálogo com a conselheira e o conselheiro de saúde



Fonte: Gemni / Nano Banana.

Uma segunda pergunta, mais direta, ajuda a testar o uso real do planejamento: o seu Conselho discute o Mapa da Saúde como base para diretrizes e metas ou o tema aparece apenas como formalidade, sem produzir mudança de pauta, de prioridade e de cobrança de resultado?

Para apoiar a atuação do Conselho nesse ponto, o quadro a seguir organiza um **roteiro de leitura crítica**, conectando cada etapa do planejamento às perguntas que ajudam a transformar análise técnica em ação política qualificada.

Quadro 3 – Roteiro didático para leitura da análise de situação de saúde e do Mapa da Saúde pelo Conselho.

Pergunta orientadora do Conselho	Onde isso deve aparecer nos instrumentos	Evidência que o Conselho deve exigir	Erro frequente a ser identificado
Quais são os principais problemas de saúde do território?	Análise de situação de saúde e Mapa da Saúde	Dados epidemiológicos, demográficos e sociais territorializados	Lista genérica de problemas sem base em dados
Onde esses problemas se concentram?	Representação geográfica no Mapa da Saúde	Mapas, tabelas ou descrições por região, bairro ou população específica	Análise homogênea que ignora desigualdades territoriais

Continuação do Quadro 3 – Roteiro didático para leitura da análise de situação de saúde e do Mapa da Saúde pelo Conselho.

Pergunta orientadora do Conselho	Onde isso deve aparecer nos instrumentos	Evidência que o Conselho deve exigir	Erro frequente a ser identificado
Que serviços e recursos existem hoje?	Estrutura do sistema de saúde no Mapa da Saúde	Capacidade instalada, equipes, serviços e cobertura	Diagnóstico sem relação com a oferta real de serviços
Onde há lacunas, excessos ou desorganização?	Análise comparativa entre necessidades e estrutura	Identificação explícita de vazios assistenciais ou sobrecarga	Planejamento que repete a estrutura existente sem questionar
Que diretrizes derivam dessa análise?	Plano de Saúde	Diretrizes claramente vinculadas aos problemas identificados	Diretrizes abstratas, sem vínculo com a situação real
Como isso será monitorado?	Indicadores definidos no Plano e na PAS	Indicadores com fonte, linha de base e periodicidade	Indicadores genéricos, sem possibilidade de acompanhamento

Fonte: Autoria própria

Observação: Este quadro não substitui os instrumentos oficiais do planejamento, mas funciona como ferramenta pedagógica de apoio ao controle social, ajudando o Conselho a manter o foco na coerência entre realidade, decisão e execução.

Situação problema	
 Fonte: Autoria de IA.	Durante a apreciação do Plano de Saúde, a gestão apresenta como prioridade a ampliação de um serviço especializado de ambulatório de cardiologia. Ao analisar o Mapa da Saúde, algumas conselheiras observam que os dados mostram baixa cobertura de Atenção Primária em determinados territórios e altas taxas de internações por condições sensíveis à atenção básica. A gestão argumenta que o serviço especializado é "mais visível" e responde a demandas políticas imediatas.
Diante dessa situação, discuta:	

1) Que elementos da análise de situação de saúde e do Mapa da Saúde o Conselho pode usar para questionar essa prioridade.

2) Como o Conselho pode argumentar tecnicamente que o planejamento deve responder às necessidades identificadas no território.

3) Que tipo de deliberação o Conselho pode produzir para exigir que as diretrizes do Plano estejam coerentes com a análise situacional apresentada.

***

9.2.5 Diretrizes, objetivos, metas e indicadores: núcleo estratégico do Plano de Saúde

No **Plano de Saúde**, as **diretrizes** expressam os grandes eixos de orientação da política de saúde e essas diretrizes dialogam com os princípios do SUS e com os compromissos assumidos nas **Conferências de Saúde**. As **diretrizes** não são ações, mas **orientações políticas amplas**, como: fortalecer a Atenção Primária, reduzir desigualdades regionais ou ampliar o cuidado integral.

Os **objetivos** traduzem essas diretrizes em **resultados desejados e indicam o que se pretende mudar** na realidade ao longo dos quatro anos.

As **metas** quantificam esses objetivos, permitindo **verificar se houve avanço, estagnação ou retrocesso**.

Por último, os **indicadores** são os **instrumentos que permitem medir e acompanhar esse processo**.

Figura 6 – Relação entre diretrizes, objetivos, metas e indicadores.



Fonte: Autoria própria

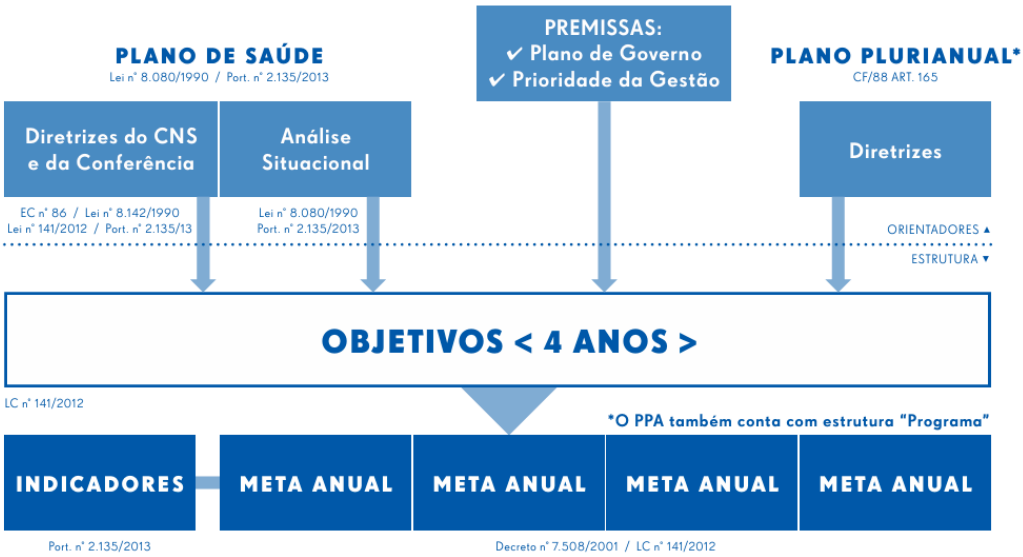
Para o controle social, esse núcleo é decisivo. Metas mal formuladas, indicadores inadequados ou diretrizes vagas enfraquecem a capacidade de cobrança e avaliação da gestão.

9.2.6 O Plano de Saúde e sua relação com o orçamento público

O Plano de Saúde não é documento associado ao orçamento e deve dialogar diretamente com o **PPA**, a **LDO** e a **LOA**. A legislação veda a transferência de recursos para ações não previstas no Plano de Saúde, salvo situações excepcionais e isso significa que o Plano de Saúde é também um **instrumento de defesa do financiamento do SUS**.

Quando o Conselho aprova um Plano consistente, ele fortalece sua capacidade de questionar cortes orçamentários, remanejamentos indevidos e prioridades incompatíveis com as necessidades da população.

Figura 7 – Planejamento governamental: relação entre o Plano de Saúde e o Plano Plurianual



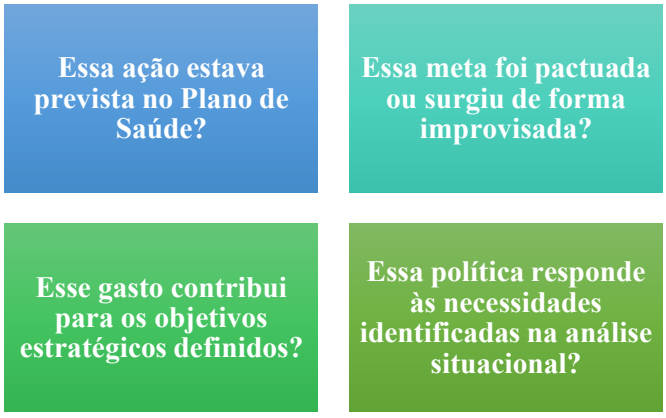
Fonte: Brasil, 2016.

9.2.7 O Plano de Saúde na prática do controle social

Na prática, o Plano de Saúde deve estar presente nas reuniões do Conselho como **referência permanente**, pois:

- Orienta a análise da Programação Anual de Saúde
- Subsidia a leitura do Relatório de Gestão;
- Fundamenta posicionamentos políticos do Conselho.

Para a conselheira e o conselheiro de saúde, o Plano responde a perguntas centrais da prática do controle social:



Dominar o Plano de Saúde é, portanto, condição para um controle social qualificado, autônomo e comprometido com a defesa do SUS.

Situação problema	
 Fonte: Autoria de IA.	Durante a análise do Relatório de Gestão, o Conselho identifica que diversas ações executadas e financiadas ao longo do ano não constavam no Plano de Saúde aprovado.
1) Como essa situação deve ser interpretada à luz da legislação do SUS? **2) Quais medidas o Conselho pode adotar para reafirmar o Plano de Saúde como instrumento central da política pública e evitar a fragmentação do planejamento?**	

***

9.3 Programação Anual de Saúde (PAS) no SUS para o controle social

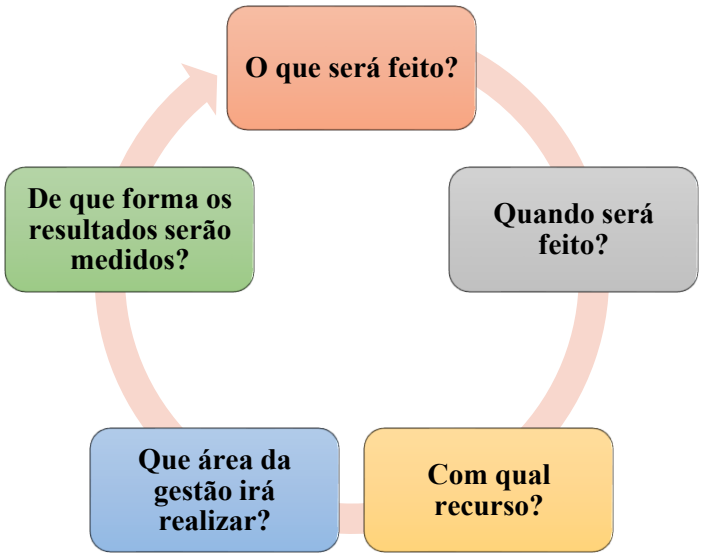
A **Programação Anual de Saúde (PAS)** é o instrumento que **materializa o Plano de Saúde** no cotidiano da gestão e do cuidado e é por meio dela que as intenções políticas e técnicas expressas no Plano de Saúde são transformadas em **ações e serviços, com metas anuais definidas, indicadores de acompanhamento e previsão de recursos para o ano seguinte**.

A PAS cumpre a função de operacionalizar o Plano de Saúde, anualizar metas e antecipar a alocação orçamentária que será executada, articulando planejamento e orçamento em um mesmo movimento racional e político.

Para a conselheira e o conselheiro de saúde, a PAS tem um significado muito objetivo, considerando que o Plano de Saúde representa o compromisso público para um ciclo de quatro

anos, a **PAS** é o **compromisso do próximo ano** (Figura 2), **aquele que pode ser cobrado, acompanhado e avaliado com mais precisão**.

Com uma PAS consistente, o **controle social faz uma análise com coerência, prioridade e execução**. Com base técnica consegue perguntar:



Uma analogia ajuda a compreender esse papel, pois o a Plano de Saúde funciona como o mapa de uma viagem de longo percurso, enquanto a **PAS é o roteiro detalhado do próximo trecho, com paradas definidas, prazos claros e orçamento estimado**. Quando o roteiro não conversa com o mapa, a viagem até acontece, mas se torna improvisada, cara e pouco transparente, fragilizando a governança do sistema.

9.3.1 Funções técnicas da Programação Anual de Saúde, o que ela precisa conter para permitir controle e fiscalização

A **PAS reúne o conjunto de ações que contribuem para o alcance dos objetivos e o cumprimento das metas do Plano de Saúde**, pois é na PAS que estão as metas anuais por ação, indicadores para monitoramento e avaliação e explicita os recursos orçamentários necessários para sua execução. Esse desenho cria as condições mínimas para que o Conselho de Saúde consiga comparar promessa e entrega, planejamento e execução.

Um aspecto importante é que a **PAS deve manter correlação direta com o Plano Plurianual e com as ações orçamentárias previstas na LOA** e essa exigência é um mecanismo de proteção do direito à saúde. É ela que reduz a ruptura clássica entre o que o

Conselho aprova como prioridade e aquilo que efetivamente recebe financiamento no orçamento do ano seguinte.

Quando a PAS não conversa com a LOA, o controle social perde capacidade de incidência e passa a atuar apenas no campo da denúncia tardia.

Outro ponto relevante é que a **PAS detalha ações e serviços conforme a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES) e a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME)**, associando essas ofertas às metas anuais, aos indicadores e à previsão de recursos e esse vínculo é fundamental para evitar que a programação se transforme em um documento genérico, sem correspondência com aquilo que o SUS pode ofertar de fato no território.

Do ponto de vista normativo**, a PAS se ancora nas diretrizes do planejamento do SUS** definidas pela Portaria nº 2.135, de 2013, e se **articula com os mecanismos de transparência e prestação de contas** previstos na Lei Complementar nº 141, de 2012. Para o Conselho, conhecer essas bases legais é parte do exercício qualificado do controle social.

9.3.2 Como a Programação Anual de Saúde funciona no ciclo de planejamento e gestão

Há dois aspectos operacionais que frequentemente geram confusão nos Conselhos. O primeiro é temporal, pois **a PAS é elaborada no ano em curso para ser executada no ano seguinte**, coincide com o exercício orçamentário e **subsidia diretamente a elaboração da Lei Orçamentária Anual**, isso significa que a PAS tem "hora certa" para chegar ao Conselho, pois precisa ser anterior à aprovação do orçamento, permitindo que o controle social influencie na programação e exija coerência entre o que se planeja e o que se financia.

Quando a PAS chega atrasada ou mal estruturada, o orçamento tende a ser definido sem ela, enfraquecendo a capacidade deliberativa do controle social.

A **PAS se articula com o Relatório de Gestão, que apresenta os resultados alcançados na execução da programação e orienta ajustes no Plano de Saúde e nas programações seguintes**. Para o Conselho, esse encadeamento é estratégico, pois organiza o momento certo de cada pergunta. No início do ciclo, cobra-se coerência e viabilidade da PAS

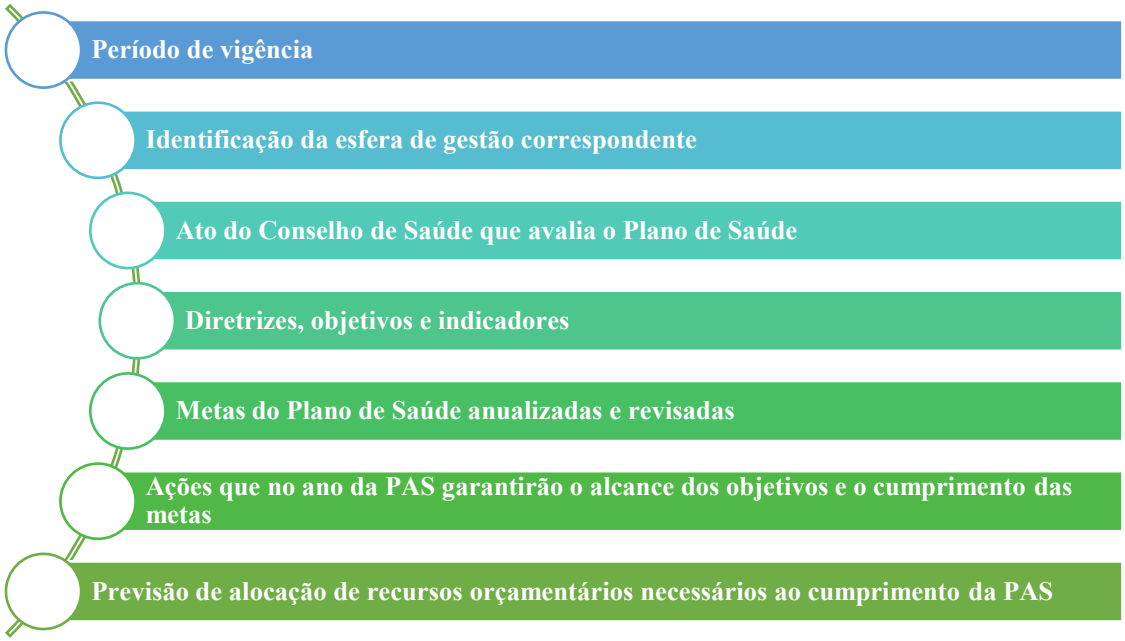
e durante o ano, monitora-se a execução. Ao final, cobra-se resultado, justificativa de desvios e redirecionamento de rumos.

Situação problema	
 Fonte: Autoria de IA.	Você recebe a PAS com metas e ações bem escritas, mas sem qualquer previsão de alocação de recursos e sem vínculo com o que aparece no orçamento enviado à Câmara. A gestão afirma que "orçamento é outra coisa" e que a PAS "é só planejamento".
1) Como você sustenta tecnicamente que PAS e LOA são instrumentos que precisam conversar e em qual parte do texto você apoia essa exigência?	

***

9.3.3 Estrutura mínima da PAS, o esqueleto que o Conselho precisa exigir

Para estados e municípios, há uma estrutura básica que a PAS deve conter. Essa estrutura não garante qualidade por si só, mas sua ausência impede qualquer análise consistente. Entre os elementos indispensáveis estão:



Para o Conselho, esse esqueleto **funciona como um *checklist* político e técnico**. Ele permite verificar se a programação está ancorada em deliberações legítimas, se respeita prioridades pactuadas e se apresenta condições reais de execução.

Quando um desses elementos falha, a PAS perde força como instrumento de gestão democrática.

Na prática do Conselho, isso significa que:

- **Diretrizes** precisam identificar que situação se pretende mudar e qual parte dessa mudança será enfrentada no próximo ano;
- **Metas anuais** precisam ser mensuráveis e acompanháveis;
- **Indicadores** devem ser factíveis e baseados em fontes acessíveis;
- **Ações** precisam ter desenho claro, indicando o que será feito, em qual território, para qual população e por qual equipe;
- **Orçamento** deve aparecer de forma explícita e compatível com a entrega prometida.

A seguir apresenta-se um exemplo, apenas sugestivo, de estrutura básica de PAS para estados e municípios, onde contém campos como diretriz, objetivo, metas do Plano e meta

anual, indicador, ações anuais, e um ponto crucial para o orçamento: vinculação a projeto ou atividade no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) e previsão de alocação.

Figura 8 – Exemplo de Programação Anual de Saúde para Estados e Municípios.

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE				
Vigência do Plano de Saúde: / / a / /				
Identificação/Esfera de Gestão:				
Ato do Conselho de Saúde de avaliação do Plano de Saúde: *(especificar documento com número e data)*				
Diretriz:				
Objetivo:	Meta do Plano de Saúde:		Meta Anual:	
Indicador:				
Ações Anuais	Projeto/ Atividade (PLOA)	Orçamento *(previsão de alocação)*	Entrega/ Produto/ Iniciativa	Prazos

Nota: As linhas Diretriz, Objetivo, Indicador, Meta, Ação podem ser replicadas quantas vezes sejam necessárias.

Fonte: Brasil, 2016.

Erros recorrentes em PAS incluem:

- **Simples reprodução das metas do Plano sem desdobramento anual;**
- **Descrição de ações vagas, como "fortalecer a atenção básica", sem especificar que componente será fortalecido, com que estratégia e com quais recursos.**

Esses problemas produzem documentos politicamente frágeis e tecnicamente pouco úteis para o controle social.

Diálogo com você, conselheira e o conselheiro



Fonte: Gemni / Nano Banana.

Outro passo é a **checagem da coerência com o orçamento**, pois a **PAS deve dialogar diretamente com a LOA**. Se as ações previstas não encontram correspondência orçamentária, **o Conselho precisa registrar essa inconsistência, solicitar ajustes e exigir justificativas técnicas**.

No SUS, os conflitos mais frequentes não decorrem da ausência de normas, mas da distância entre o que se planeja, o que se financia e o que se executa.

Por fim, é importante lembrar que a **PAS prepara o terreno para a prestação de contas e um Relatório de Gestão consistente** depende de uma PAS bem formulada e quando a programação é vaga, o relatório tende a ser narrativo e defensivo.

Quando a programação é precisa, o relatório se torna um instrumento efetivo de avaliação.

Situação problema



Fonte: Autoria de IA

O Conselho recebeu a PAS do município ao final do ano, sendo constatado que:

- Documento apresenta diretrizes e objetivos alinhados ao Plano de Saúde;
- Metas anuais são genéricas e não trazem indicadores claros;
- Ações aparecem descritas de forma ampla, sem vínculo explícito com projetos ou atividades orçamentárias;
- A previsão de recursos está concentrada em poucos blocos, sem detalhamento por ação;
- Algumas ações não dialogam claramente com a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (Renases) ou com a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename);
- Não há definição de como o acompanhamento será feito ao longo do ano.

Diante desse cenário, o Conselho precisa se perguntar:

1) Quais trechos da PAS não permitem fiscalização efetiva?
2) Que ajustes devem ser exigidos para restabelecer o encadeamento entre diretriz, meta anual, indicador, ação e orçamento?
3) Que evidências mínimas são necessárias para comprovar a coerência com a LOA?

4) Como organizar o monitoramento ao longo do ano para que a discussão não fique restrita ao momento do Relatório de Gestão?



Fonte: Gemni / Nano Banana.

A PAS não nasce do nada, ela nasce do Plano de Saúde, e o Plano, por sua vez, nasce de uma leitura da situação de saúde e de necessidades da população.

Na prática, a **equipe gestora** precisa pegar **cada diretriz e objetivo** do Plano, **identificar quais entregas anuais** são necessárias para caminhar na **direção da meta quadrienal**, **definir quais ações e serviços** serão feitos naquele **ano**, **escolher indicadores** que permitam **monitorar processo e resultado**, **estabelecer metas anuais factíveis** e, ao mesmo tempo, ambiciosas, e colocar isso em linguagem orçamentária, isto é, com **previsão de recursos e com vínculo a projetos e atividades do orçamento**.

Para o Conselho: **"Entender a elaboração" não significa virar área técnica da secretaria, significa conhecer a lógica do encadeamento e usar essa lógica para perguntar bem.**

Uma pergunta bem colocada tem mais valor do que dez páginas de discussão genérica.

Exemplos:

Se a PAS diz "reduzir mortalidade infantil", o Conselho precisa perguntar:

- Qual ação anual será feita?
- Qual indicador será acompanhado?
- Qual linha de base?

- Qual meta anual?
- Qual território prioritário?
- Qual serviço será reforçado?
- Quanto de recurso será alocado?

Se a PAS diz "qualificar vigilância", o Conselho precisa perguntar:

- Quais ações anuais? (exemplo: *capacitar profissionais da atenção básica para diagnóstico da hanseníase, aumentar a notificação de hanseníase, qualificar trabalhadores da atenção básica para busca ativa de tuberculose*)
- Como isso aparece no orçamento?
- Detalhar as ações, metas, indicadores e alocação de recursos.

***

9.4 Relatório anual gestão no sus, para que ele existe e por que ele muda a prática do controle social

O **Relatório Anual de Gestão (RAG) é o documento em que a gestão do SUS transforma execução em prestação de contas rastreável** (Figura 2), porque ele organiza, em linguagem pública, o que foi prometido, o que foi programado para acontecer no ano e o que de fato aconteceu, com resultados, justificativas e recomendações de correção de rumo.

O **RAG fecha um ciclo que começa no Plano de Saúde, passa pela PAS e se materializa na execução, por isso o RAG** (Figura 2) tem uma função dupla ao passo que mostra os resultados alcançados com a execução da PAS e, ao mesmo tempo, orienta redirecionamentos para o próprio Plano e para as programações seguintes, o que dá a ele um caráter avaliativo e decisório, não apenas descritivo.

Esse desenho está alinhado às recomendações de Planejamento no SUS e é descrito como **planejamento cíclico, sequencial e interligado**, no qual cada instrumento depende do anterior para produzir governabilidade e avaliação.

Para a conselheira e o conselheiro de saúde:

O RAG é o **momento em que o controle social** deixa de atuar por "impressão de funcionamento" e passa a **atuar por evidência documentada**. Se a PAS é o contrato anual do que será feito, o **RAG é o balanço anual do que foi feito**, confrontando:

- Metas previstas *versus* Metas executadas;
- Indicadores pactuados *versus* Indicadores observados;
- Comportamento do orçamento ao longo do ano.

Relatório Anual de Gestão CONSISTENTE	**Relatório Anual de Gestão FRÁGIL**
Fortalece a autonomia deliberativa do Conselho	Abre margem para disputa de interpretação
Reduz espaço para versões concorrentes e conflitos de narrativa	Falta o encadeamento mínimo entre objetivo, meta, indicador, entrega e gasto

Diálogo com você, conselheira e conselheiro



Fonte: Gemni / Nano Banana.

Situação problema	
 Fonte: Autoria de IA.	O Conselho aprova o RAG com ressalvas genéricas e, meses depois, surge denúncia de "maquiagem" de metas. A gestão argumenta que "o Conselho aprovou".
1) Como você reorganiza a análise do próximo RAG para que o parecer conclusivo deixe explícito os pontos verificáveis, os pontos não verificáveis e as exigências objetivas de correção, de modo a proteger a instituição Conselho e a própria política pública?	

***

9.4.1 O que o Relatório Anual de Gestão precisa ter para análise do Conselho de Saúde

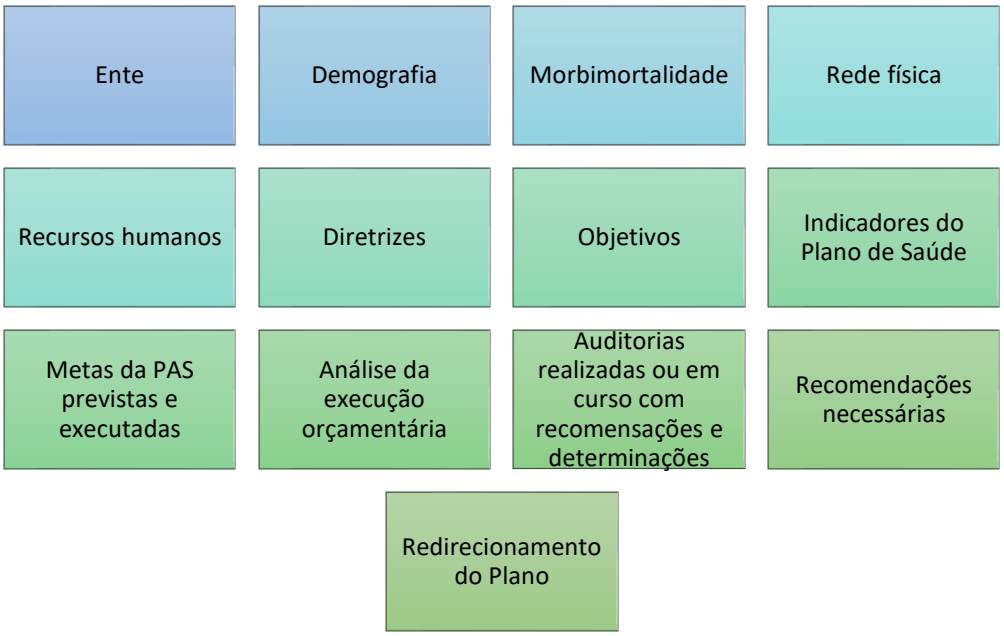
O conteúdo do RAG precisa permitir que o Conselho responda a **três perguntas:**

1 - O que mudou na situação de saúde ou na oferta de serviços?

2 - O que a gestão entregou em relação ao que havia programado?

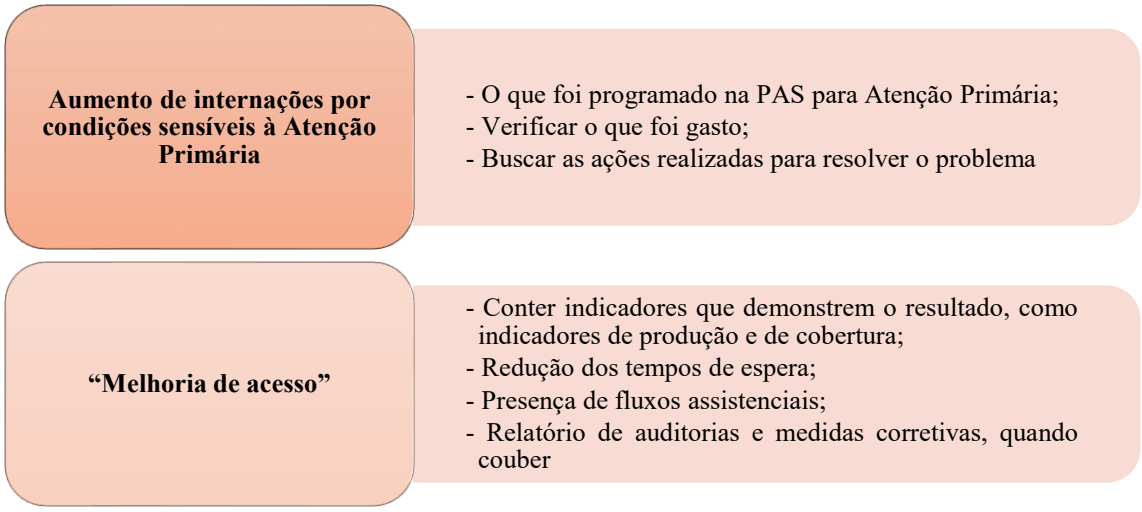
3 - Como o dinheiro público se comportou diante dessas entregas?

O RAG contempla identificação:



Esse desenho é um **roteiro de responsabilização pública** em que **cada bloco responde a uma dimensão do pacto social do SUS, necessidade, capacidade instalada, força de trabalho, prioridades, execução e controle**.

Na leitura do Conselho, esses blocos precisam conversar entre si, por exemplo:



Essa coerência interna é o que permite ao Conselho deliberar com segurança, porque o RAG vira um documento de prova institucional, útil inclusive quando há judicialização, controle externo e disputa política.

Quadro 4 - Leitura crítica do Relatório Anual de Gestão com exemplos aplicados ao SUS.

Bloco do RAG (o que deve aparecer)	O que o Conselho precisa conseguir verificar	Exemplo de pergunta aplicada à gestão	Sinal de alerta frequente
Metas PAS previstas e executadas	Relação direta entre meta anual e execução	A meta anual de ampliar cobertura de equipe foi executada onde, quando, com que indicador e com que evidência	Meta "executada" sem fonte, sem território e sem indicador
Diretrizes, objetivos e indicadores do Plano	Encadeamento Plano → PAS → Resultado	O objetivo quadrienal teve qual avanço mensurável no ano, e qual parte ficou pendente	Objetivo aparece como texto, sem traduzir avanço anual
Execução orçamentária	Coerência entre gasto e entrega	O gasto cresceu onde a PAS priorizou ou cresceu onde a rotina histórica manda	Aumento de gasto sem correspondência com prioridades
Auditorias e recomendações	Ação corretiva e responsabilização	Houve auditoria relevante e quais recomendações foram cumpridas	Auditoria citada sem encaminhamento e sem prazo
Rede física e Recursos humanos	Capacidade instalada e suficiência operacional	A expansão de serviço teve equipe e estrutura compatíveis	Mudança de serviço sem RH e sem custeio sustentado

Fonte: Autoria própria

Diálogo com você, conselheira e conselheiro



Fonte: Gemni / Nano Banana.

<table>
<tr><th colspan="2">Situação problema</th></tr>
<tr><td> 

Fonte: Autoria de IA.</td><td>O RAG traz uma tabela de metas “cumpridas”, mas sem fonte e sem método.
O texto usa expressões como “ampliou”, “qualificou”, “fortaleceu” sem números.</td></tr>
<tr><td colspan="2">1) Como você exige a reconstrução do RAG para que cada meta tenha indicador, fonte, linha de base e evidência documental, sem transformar o Conselho em executor da gestão?</td></tr>
</table>

***

9.4.2 Fluxo, prazos, sistemas e transparência do Relatório Anual de Gestão

O **RAG é elaborado pela gestão e enviado ao Conselho para análise** em prazo definido, com disponibilização pública por sistema oficial para análise do respectivo Conselho **até 30 de março do ano seguinte à execução orçamentária**, pelo Sistema de Apoio à Construção do Relatório de Gestão (SargsUS), no qual o Conselho emite parecer conclusivo e, quando finalizado, o documento fica acessível ao público.

A **lógica legal do financiamento** e da transparência aparece com força quando você conecta o RAG a outros instrumentos de monitoramento e prestação de contas. A própria **Lei Complementar nº 141 de 2012 organiza obrigações e mecanismos de transparência no financiamento do SUS** e opera, na prática, junto com sistemas oficiais como o **Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)**, que é referência para comprovação de aplicação mínima e para acompanhamento do gasto em saúde.

Isso importa para o Conselho porque, ao analisar **execução orçamentária no RAG**, você precisa saber **“de onde sai”** a informação, **“onde se confere”** e **“como se confronta”** com os registros oficiais de orçamento e despesa, reduzindo o risco de divergência entre narrativa do relatório e dados oficiais.

Diálogo com você, conselheira e conselheiro



Fonte: Gemni / Nano Banana.

Situação problema	
 Fonte: Autoria de IA.	A gestão entrega o RAG fora do prazo, sem anexos, e diz que "o sistema está instável". O Conselho precisa decidir se analisa assim mesmo.
1) Que decisão preserva a transparência e a responsabilidade pública, e quais exigências documentais mínimas você coloca como condição para iniciar a análise?	

***

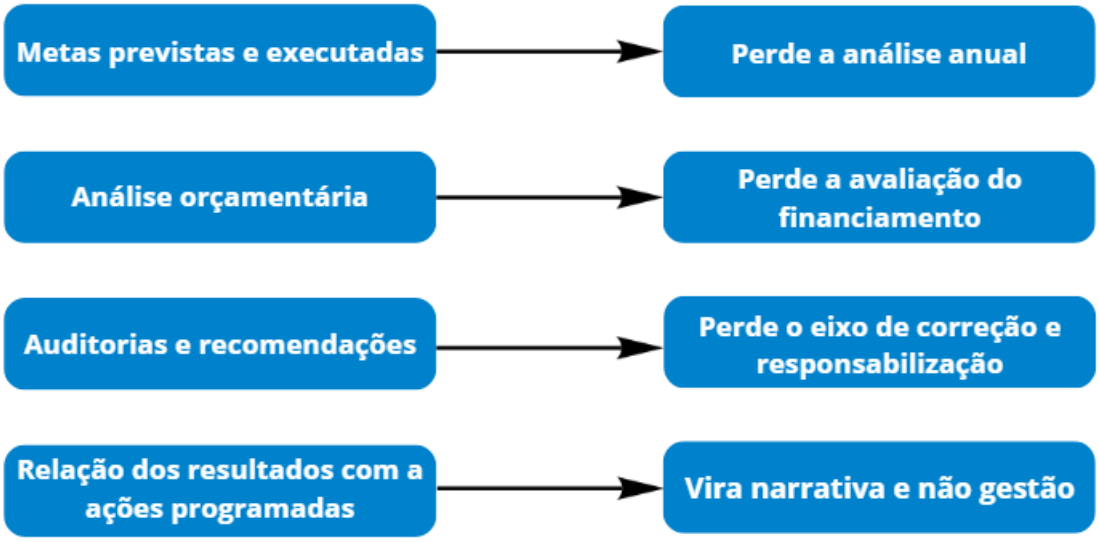
9.4.3 A análise do Relatório Anual de Gestão pelo Conselho

O parecer conclusivo não é um despacho formal, ele é um ato político e normativo do Conselho, porque delimita o que foi verificado, o que não foi verificado, quais inconformidades existem e quais providências são exigidas para restabelecer coerência do ciclo de planejamento. Um bom parecer conclusivo reduz conflito futuro, porque transforma divergência em registro institucional, com rastreabilidade.

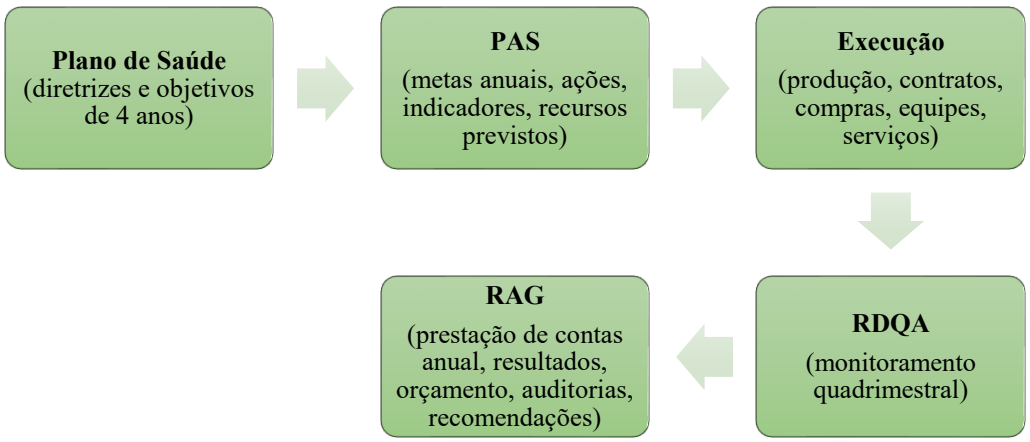
O Conselho deve emitir o parecer no próprio ambiente do sistema, vinculando a análise ao documento, o que aumenta transparência e reduz risco de "parecer solto" que não conversa com o conteúdo.

Na prática, a **análise do RAG** ganha qualidade quando o Conselho trabalha com critérios estáveis e repetíveis. Um **critério técnico simples**, mas potente, é **a matriz de coerência, Plano de Saúde, PAS, execução, resultado e gasto**.

Você não precisa dominar toda a contabilidade para fazer isso, você precisa dominar a lógica de encadeamento. Se o RAG não mostra:



Esquema da ordem execução dos instrumentos de gestão



Diálogo com você, conselheira e conselheiro



Fonte: Gemni / Nano Banana.

Situação problema	
 Fonte: Autoria de IA.	O RAG aponta baixa execução de metas, mas a gestão atribui tudo à "falta de recursos". Ao olhar a execução orçamentária, você identifica saldo não empenhado em ações priorizadas. Como o Conselho transforma essa contradição em recomendações objetivas, com prazos e exigência de reprogramação.

***

9.5 O Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior – RDQA

É fundamental que conselheiras e conselheiros compreendam claramente a **diferença entre o RAG e o RDQA**, pois ambos integram o ciclo de planejamento, mas cumprem funções distintas.

O **RDQA** é um **instrumento de monitoramento periódico da execução da PAS**, apresentado **três vezes ao ano, ao final de cada quadrimestre,** em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente federado. Ele deve ser apresentado até o **final dos meses de maio, setembro e fevereiro**, conforme estabelece a legislação.

Seu objetivo é **permitir o acompanhamento contínuo da execução das ações e da aplicação dos recursos**, evitando que problemas só sejam identificados ao final do exercício.

O conteúdo do **RDQA** é mais sintético e **focado no acompanhamento**: identificação da esfera de gestão, montante e fonte dos recursos aplicados no período, auditorias realizadas ou em andamento, oferta e produção de serviços de saúde e análise geral da execução e funciona como um "termômetro" da política em curso.

Quanto ao **RAG** tem caráter **consolidado e avaliativo**. Ele é elaborado após o **encerramento do exercício financeiro** e analisa o conjunto do que foi **executado ao longo do ano**, sempre em referência direta ao Plano de Saúde e à PAS. Enquanto o RDQA responde à pergunta "como está indo", o RAG responde à pergunta "o que foi efetivamente realizado, com que resultados e que ajustes são necessários".

Para o controle social, essa distinção é estratégica, pois o RDQA permite intervenção em tempo oportuno e o RAG sustenta o julgamento global da gestão e fundamenta deliberações mais estruturantes, inclusive sobre redirecionamentos do planejamento.

Quadro 5 – Diferenças das características entre o Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior e o Relatório Anual de Gestão.

Características	Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior	Relatório Anual de Gestão
Instrumento	Monitoramento	Prestação de contas
Tipo de Análise	Acompanha a execução de ações e o recurso aplicado	Avalia o que foi executado e era previsto no Plano de Saúde e na PAS
Caráter	Periódico Acompanhamento	Consolidado Avaliação global da gestão
Estratégia	Propõe ajustes das ações em tempo oportuno	Fundamenta deliberações Redireciona planejamentos
Temporalidade	Quadrimestral	Anual
Prazos de entrega	Maio e setembro do ano vigente e fevereiro do ano seguinte	30 de março do ano seguinte

Fonte: Autoria própria

Diálogo com você, conselheira e o conselheiro de saúde



Fonte: Gemni / Nano Banana.

Situação problema	
 Fonte: Autoria de IA.	O Conselho de Saúde analisa o RAG e identifica que diversas metas da PAS não foram alcançadas. A gestão informa que houve dificuldades orçamentárias, mas o RAG apresenta execução financeira elevada em ações que não estavam entre as prioridades definidas no Plano de Saúde. Nos RDQA apresentados ao longo do ano, essas alterações não haviam sido claramente explicitadas.
Diante dessa situação, como o Conselho pode utilizar o RAG para questionar: **1) Houve coerência entre planejamento, execução e financiamento?** **2) De que forma o histórico dos RDQA fortalece a análise crítica do RAG?** **3) Que tipo de parecer conclusivo contribui para evitar a repetição desse padrão no próximo ciclo de planejamento?**	

***

9.6 Indicadores de saúde para monitoramento do conselho de saúde

Indicadores e metas não são apenas números, mas **expressões objetivas das escolhas políticas da gestão.** Quando um indicador não melhora, o papel do Conselho de Saúde não é apenas registrar o problema, mas questionar causas, analisar prioridades orçamentárias, exigir reprogramações e induzir mudanças na gestão. Metas mal definidas, metas não monitoradas ou metas sistematicamente descumpridas fragilizam o planejamento e comprometem o direito à saúde.

O conhecimento desses **indicadores** permite ao conselho **qualificar o debate, superar análises genéricas e exercer um controle social técnico, político e efetivo, articulando situação de saúde, planejamento, financiamento e resultados do SUS no território**.

Quadro 6 – Exemplos de alguns indicadores e metas de saúde para atuação do Conselho de Saúde.

Eixo da política de saúde	Indicador de saúde	O que o indicador mede	Exemplo de meta	Como o conselho deve analisar e agir
Situação de saúde da população	Taxa de mortalidade infantil	Óbitos de menores de 1 ano por mil nascidos vivos. Expressa condições de vida, acesso e qualidade da atenção materno-infantil	Reduzir para abaixo de 10 óbitos por mil nascidos vivos	Verificar se a redução ocorre de forma equitativa entre territórios, se há cobertura adequada de pré-natal e se os serviços de atenção básica e hospitalar estão articulados
	Razão de mortalidade materna	Óbitos maternos por 100 mil nascidos vivos. Indica qualidade do cuidado pré-natal, parto e puerpério	Redução progressiva anual conforme pactuação regional	Analisar causas evitáveis, fluxos de acesso ao parto, disponibilidade de serviços de referência e se há subnotificação
Atenção Primária à Saúde (APS)	Cobertura populacional da APS	Percentual da população coberta por equipes de saúde da família ou equivalentes	Manter cobertura acima de 75%	Avaliar distribuição territorial das equipes, vazios assistenciais e impacto da cobertura nos indicadores de saúde
	Proporção de internações por condições sensíveis à APS	Internações evitáveis com cuidado oportuno na APS	Redução gradual ao longo dos anos	Questionar falhas no acesso, na longitudinalidade do cuidado e na resolutividade da APS

Fonte: Autoria própria.

Continuação do Quadro 6 – Exemplos de alguns indicadores e metas de saúde para atuação do Conselho de Saúde.

Eixo da política de saúde	Indicador de saúde	O que o indicador mede	Exemplo de meta	Como o conselho deve analisar e agir
Vigilância em saúde	Incidência de doenças de notificação compulsória prioritárias	Número de casos novos por população em risco	Redução conforme perfil epidemiológico local	Avaliar oportunidade da notificação, ações de vigilância ativa e integração APS e vigilância
	Proporção de encerramento oportuno de notificações	Percentual de casos encerrados dentro do prazo	Alcançar ou manter acima de 80%	Verificar capacidade técnica da vigilância e apoio da gestão para investigação dos casos
Rede de atenção à saúde	Taxa de ocupação de leitos hospitalares	Uso da capacidade instalada hospitalar	Manter entre parâmetros técnicos recomendados	Analisar se há superlotação, subutilização ou falhas na regulação do acesso
Acesso e regulação	Tempo médio de espera para procedimentos especializados	Acesso oportuno a consultas e exames	Redução progressiva do tempo de espera	Questionar gargalos na regulação, contratos com prestadores e oferta regionalizada
Financiamento do SUS	Percentual de aplicação mínima em saúde	Cumprimento dos percentuais constitucionais	Cumprir ou superar o mínimo legal	Conferir dados no SIOPS e relacionar gasto com resultados alcançados
	Proporção do gasto em atenção básica	Prioridade orçamentária dada à APS	Manutenção ou ampliação do percentual	Avaliar coerência entre discurso da gestão e alocação real de recursos
Gestão e planejamento	Grau de cumprimento das metas da PAS	Execução do que foi planejado no ano	Alcançar a maior parte das metas pactuadas	Exigir justificativas técnicas para metas não cumpridas e reprogramações quando necessário
Equidade	Indicadores desagregados por território, raça, sexo ou população específica	Desigualdades no acesso e nos resultados em saúde	Redução das iniquidades identificadas	Cobrar estratégias específicas para populações vulnerabilizadas e territórios críticos

Nota: APS – Atenção Primária em Saúde; PAS – Programação Anual de Saúde; SIOPS – Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde.
Fonte: Autoria própria.

9.7 Agenda dos gestores

A **agenda do gestor do SUS**, na esfera municipal, estadual ou federal, **segue o ciclo do planejamento no setor saúde**, embora nem todas as tarefas coincidam com o período de gestão governamental, daí a importância de conhecer melhor sua lógica.

O planejamento e a execução de ações e serviços de saúde envolvem a utilização de instrumentos e ferramentas definidos legalmente, cujo cumprimento dos prazos é exigido, justamente por conformar um ciclo de atividades interdependentes e por garantir a transparência do processo.

Essas atividades tratam da situação de saúde, do que se pretende em determinado período para minimizar os problemas e avançar na oferta de promoção, proteção e recuperação da saúde dos cidadãos, bem como da prestação de contas sistematizada em instrumentos setoriais, que se relacionam entre si e com os instrumentos de planejamento do governo. O Quadro 6 apresenta uma síntese dos compromissos dos gestores em todo o ciclo de planejamento no SUS.

Quadro 7 – Agenda do gestor segundo o ciclo de planejamento no SUS.

PRAZO	INSTRUMENTO	PROVIDÊNCIAS	MARCO LEGAL
A cada 4 anos ou em período inferior extraordinariamente	Conferência de Saúde	Convocação pelo Poder Executivo local ou, extraordinariamente, pelo Conselho de Saúde.	§ 1º art. 1º Lei nº 8.142, de 1990
1º ano de gestão	Plano de Saúde	Elaboração do Plano de Saúde com base nas Diretrizes dispostas pelo Conselho de Saúde.	§ 8º art. 15 Lei nº 8.080, de 1990
Antes da entrega da LDO do exercício correspondente	Programação Anual de Saúde (PAS)	Encaminhamento da PAS do Plano de Saúde ao respectivo Conselho de Saúde, para Aprovação.	§ 2º art. 36 LC nº 141, de 2012
Até 15 de abril	Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)	Entrega do Projeto de LDO na Casa Legislativa.	Art. 165 CF 1988
30 de janeiro	Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)	Preenchimento do Sistema referente ao exercício (ano) anterior.	Art. 39 LC nº 141, de 2012; Cap. I Dec. nº 7.827, de 2012; Port. nº 53, de 2013

Fonte: Brasil, 2016.

Continuação do Quadro 7 – Agenda do gestor segundo o ciclo de planejamento no SUS.

PRAZO	INSTRUMENTO	PROVIDÊNCIAS	MARCO LEGAL
30 de janeiro	Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)	Preenchimento do Sistema referente ao 6º bimestre do exercício anterior.	Art. 39 LC nº 141, de 2012; Cap. I Dec. nº 7.827, de 2012; Port. nº 53, de 2013
Fevereiro	Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA)	Apresentação do RDQA no Conselho de Saúde e na Casa Legislativa da esfera correspondente, referente ao Quadrimestre anterior.	§ 5º art. 36 LC nº 141, de 2012
30 de março	Relatório Anual de Gestão (RAG)	Envio do Relatório de Gestão ao Conselho de Saúde.	Art. 36 LC nº 141, de 2012
30 de março	Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)	Preenchimento do Sistema referente ao bimestre anterior.	Art. 39 LC nº 141, de 2012; Cap. I Dec. nº 7.827, de 2012; Port. nº 53, de 2013
Maio	Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA)	Apresentação do RDQA no Conselho de Saúde e na Casa Legislativa da esfera correspondente referente ao Quadrimestre anterior.	§ 5º art. 36 LC nº 141, de 2012
30 de maio	Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)	Preenchimento do Sistema referente ao bimestre anterior.	Art. 39 LC nº 141, de 2012; Cap. I Dec. nº 7.827, de 2012; Port. nº 53, de 2013
Junho	Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)	Encerramento do período da Sessão Legislativa. Sanção do Chefe do Poder Executivo da LDO.	§ 2º art. 35; art. 165 CF 1988
30 de julho	Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)	Preenchimento do Sistema referente ao bimestre anterior.	Art. 39 LC nº 141, de 2012; Cap. I Dec. nº 7.827, de 2012;

			Port. nº 53, de 2013
30 de agosto do ano de gestão	Plano Plurianual (PPA)	Entrega do Projeto de Lei do PPA na Casa Legislativa correspondente.	Art. 165 CF 1988

Fonte: Brasil, 2016.

Continuação do Quadro 7 – Agenda do gestor segundo o ciclo de planejamento no SUS.

PRAZO	INSTRUMENTO	PROVIDÊNCIAS	MARCO LEGAL
30 de agosto	Lei Orçamentária Anual (LOA)	Entrega do Projeto de LOA na Casa Legislativa.	Art. 165 CF 1988
Setembro	Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA)	Apresentação do RDQA no Conselho de Saúde e na Casa Legislativa da esfera correspondente referente ao Quadrimestre anterior.	§ 5º art. 36 LC nº 141, de 2012
30 de setembro	Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)	Preenchimento do Sistema referente ao bimestre anterior.	Art. 39 LC nº 141, de 2012; Cap. I Dec. nº 7.827, de 2012; Port. nº 53, de 2013
30 de novembro	Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)	Preenchimento do Sistema referente ao bimestre anterior.	Art. 39 LC nº 141, de 2012; Cap. I Dec. nº 7.827, de 2012; Port. nº 53, de 2013
Dezembro do ano de gestão	Plano Plurianual (PPA)	Encerramento da Sessão Legislativa. Sanção do Chefe do Poder Executivo do PPA.	§ 2º art. 35; art. 165 CF 1988
Dezembro	Lei Orçamentária Anual (LOA)	Encerramento da Sessão Legislativa. Sanção do Chefe do Poder Executivo da LOA.	§ 2º art. 35; art. 165 CF 1988
Permanente	Educação Permanente	Oferecer qualificação, na forma de educação permanente, para atuar na formulação de estratégias e assegurar o efetivo controle social da execução da política de saúde, especialmente os	Art. 44 Lei nº 141, de 2012

		representantes de usuários e trabalhadores de saúde.	
Anual	Metodologia	Cabe ao Ministério da Saúde definir e publicar, utilizando metodologia pactuada, os montantes a serem transferidos a cada Estado, ao Distrito Federal e a cada Município, para custeio das ações e serviços públicos de saúde.	§ 1º art. 17 LC nº 141, de 2012

Fonte: Brasil, 2016.

No âmbito do SUS, o planejamento organiza-se como um ciclo contínuo, normatizado juridicamente e articulado às instâncias de controle social e ao processo orçamentário do Estado, iniciando-se, de modo geral, no primeiro ano de cada gestão governamental, com a elaboração do Plano de Saúde, instrumento estratégico quadrienal que expressa as prioridades, diretrizes e compromissos do gestor, construído a partir das orientações definidas pelo respectivo Conselho de Saúde, conforme previsto na Lei nº 8.080 de 1990, reafirmando o caráter participativo e deliberativo do planejamento em saúde.

A execução do Plano de Saúde materializa-se por meio da Programação Anual de Saúde, que detalha, ano a ano, as ações, metas e recursos necessários à implementação das diretrizes pactuadas para o período de quatro anos de gestão, devendo ser submetida à apreciação e aprovação do Conselho de Saúde antes do envio do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias ao Poder Legislativo, uma vez que as informações da saúde integram a LDO, cujo prazo constitucional de encaminhamento é até quinze de abril, conforme estabelece a Constituição Federal de 1988 e a Lei Complementar nº 141 de 2012.

Paralelamente aos marcos formais do calendário orçamentário, há atribuições do gestor que não se concentram em datas específicas, mas que atravessam todo o exercício anual e são estruturantes para a qualidade do planejamento, como a promoção de processos de educação permanente voltados especialmente a conselheiros de saúde, trabalhadores e representantes de usuários, com o objetivo de qualificar a participação social, fortalecer a formulação de estratégias e assegurar o efetivo controle social sobre a execução da política de saúde, conforme

disposto na legislação vigente, assim como a responsabilidade do Poder Executivo em convocar, a cada quatro anos, as Conferências de Saúde, em todas as esferas de governo, seguindo uma lógica ascendente que parte do nível local e culmina na etapa nacional.

No que se refere às ferramentas operacionais do planejamento, destaca-se o registro anual, no sistema eletrônico de pactuação interfederativa, das diretrizes, objetivos, metas e indicadores acordados entre os gestores, bem como a obrigatoriedade de alimentação periódica do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde, no qual, até o final de janeiro, devem ser inseridos os dados orçamentários referentes ao exercício financeiro anterior e as informações necessárias à composição do Relatório Resumido da Execução Orçamentária do bimestre imediatamente anterior, em conformidade com a Lei Complementar nº 141, o Decreto nº 7.827 de 2011 e normativas ministeriais específicas.

Ao longo do ano, o acompanhamento da execução das ações e do uso dos recursos é formalizado por meio da apresentação quadrimestral do Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior ao Conselho de Saúde e ao Poder Legislativo, quando convocado, instrumento que explicita as ações realizadas, os resultados alcançados e a execução financeira no período, sendo complementado, no primeiro trimestre do ano subsequente, pelo envio do Relatório de Gestão ao Conselho de Saúde para emissão de parecer, consolidando a avaliação do desempenho da gestão no exercício encerrado.

Esse fluxo se articula, ainda, com os momentos decisórios do ciclo orçamentário, como a sanção da Lei de Diretrizes Orçamentárias até o encerramento do primeiro semestre legislativo, o envio e a apreciação do Plano Plurianual e da Lei Orçamentária Anual no segundo semestre, bem como a contínua atualização dos sistemas de informação financeira e de monitoramento, de modo que, ao final do ano, embora se encerre o exercício fiscal e a sessão legislativa, o ciclo do planejamento em saúde não se interrompe, uma vez que se renova com a elaboração de novas programações, relatórios e pactuações, mantendo-se como um processo permanente, cumulativo e interdependente, orientado pela transparência, pela participação social e pela responsabilidade na gestão pública da saúde.

O controle social no SUS constitui um eixo estruturante da política pública de saúde e se materializa nas práticas de participação social voltadas à formulação, ao acompanhamento e ao controle da gestão do SUS, sendo os conselhos de saúde e as conferências de saúde as instâncias institucionalizadas, deliberativas e paritárias que expressam, de forma organizada, a presença da sociedade civil no processo decisório, reunindo usuários, trabalhadores da saúde, gestores e

prestadores de serviços em um espaço permanente de diálogo, tensão produtiva e corresponsabilização pela política de saúde.

Conselheira e conselheiro, ao ocuparem esse espaço, não atuam como espectadores do planejamento e da gestão, mas como sujeitos políticos que mediam a relação entre o Estado e a sociedade, participando desde a definição das diretrizes que orientam o Plano de Saúde até a análise, fiscalização e aprovação dos instrumentos de planejamento, programação e prestação de contas, como a Programação Anual de Saúde, os Relatórios Detalhados Quadrimestrais e o Relatório de Gestão, o que exige não apenas presença formal nas reuniões, mas compreensão do ciclo de planejamento, domínio mínimo dos instrumentos e capacidade de leitura crítica da realidade sanitária e orçamentária do território.

Historicamente, os conselhos, inclusive os de saúde, foram criados ainda na década de 1930, no governo de Getúlio Vargas, e atravessaram diferentes conformações ao longo de períodos autoritários e democráticos, sendo incorporados de forma definitiva à institucionalidade do País com a Constituição Federal de 1988, que os reconhece como conselhos gestores, posteriormente regulamentados pela Lei nº 8.142 de 1990, a qual ampliou sua autonomia ao atribuir aos próprios conselheiros a responsabilidade pela elaboração de seus regimentos internos, reforçando o princípio da autogestão colegiada e da autonomia política dessas instâncias.

A paridade entre os segmentos que compõem os conselhos, ainda que não detalhada explicitamente na Lei nº 8.142, foi normatizada por resoluções do Conselho Nacional de Saúde, estabelecendo que metade das vagas seja ocupada por representantes dos usuários, enquanto a outra metade se distribui entre trabalhadores da saúde e gestores ou prestadores de serviços, configuração que foi reiterada ao longo das conferências nacionais de saúde, reafirmando a centralidade do usuário como sujeito do controle social e da defesa do direito à saúde.

Cada esfera de governo é obrigada a manter um conselho de saúde ativo, podendo estruturar conselhos descentralizados, como conselhos regionais, locais, distritais ou aqueles vinculados aos Distritos Sanitários Especiais Indígenas, todos articulados e coordenados pelo conselho da respectiva esfera, o que amplia a capilaridade do controle social e aproxima o debate das realidades dos territórios, onde os problemas de acesso, qualidade da atenção e alocação de recursos se manifestam de forma mais evidente.

Situação problema

<table>
<tr>
<td> 

Fonte: Autoria de IA</td>
<td>No dia da apresentação, pelo gestor, de um RDQA, foi apresentado a execução financeira regular, mas revelou metas assistenciais não alcançadas e fragilidades persistentes na atenção básica</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1) Como deve o conselho atuar para que sua deliberação não se restrinja à homologação formal do documento, mas se traduza em recomendações, exigência de reprogramações e indução de mudanças na gestão, respeitando o fluxo decisório definido na legislação?</td>
</tr>
</table>

***

9.8 Agenda dos conselhos

O **controle social no SUS** corresponde às práticas de **participação da sociedade na formulação, no acompanhamento e no controle da política de saúde**, sendo exercido de forma institucionalizada por meio dos **conselhos de saúde e das conferências de saúde**, instâncias deliberativas e paritárias que articulam usuários, trabalhadores e gestores no processo decisório do SUS.

Os conselhos de saúde têm origem histórica na década de 1930 e foram incorporados definitivamente à institucionalidade brasileira com a Constituição Federal de 1988, que os reconheceu como conselhos gestores, sendo regulamentados, no campo da saúde, pela Lei nº 8.142 de 1990, a qual ampliou sua autonomia ao atribuir aos próprios conselheiros a elaboração de seus regimentos internos e ao consolidar seu papel na mediação entre o Estado e a sociedade.

Os **conselhos participam da definição de diretrizes, acompanham e fiscalizam a execução das políticas e aprovam os instrumentos de planejamento do SUS**, atuando de forma articulada com as **conferências de saúde**.

As **conferências de saúde** são **realizadas a cada quatro anos**, responsáveis por **avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação das políticas** nos diferentes níveis de governo.

O fluxo decisório do controle social estabelece que as conferências propõem diretrizes, os conselhos formulam estratégias e controlam a execução das políticas, e as instâncias executivas implementam e homologam as deliberações, cabendo às conselheiras e aos conselheiros exercer um papel técnico e político ativo para que o controle social ultrapasse o cumprimento formal de normas e contribua efetivamente para a garantia do direito à saúde.

Quadro 8 - Agenda do conselho de saúde com foco no ciclo de planejamento.

PROVIDÊNCIAS	PRAZO LEGAL	MARCO LEGAL
Acompanhar e fiscalizar a movimentação financeira dos recursos depositados pelo Fundo Nacional de Saúde em conta especial	Permanente	§ 3º art. 77 CF 1988; art. 33 Lei nº 8.080, de 1990; § 3º inciso III Art. 7º CF EC 29, de 2000
Formular estratégias, controlar a execução da política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, na instância correspondente	Permanente	§ 2º art. 1ºLei nº 8.142, de 1990
Convocar, extraordinariamente, conferência de saúde	A cada 4 anos ou extraordinariamente em período inferior	§ 1º art. 1ºLei nº 8.142, de 1990
Estabelecer deliberar definir diretrizes que deverão ser observadas nos planos de saúde	1º ano da gestão do Executivo	Art. 37 Lei nº 8.080, de 1990; § 4º art. 30 LC nº 141, de 2012; § 3º art. 3º Decreto nº 7.508, de 2011; § 7º art. 3º PRT nº 2.135, de 2013
Avaliar e emitir parecer conclusivo sobre o Plano de Saúde	1º ano da gestão do Executivo	§ 7º art. 3ºPRT nº 2.135, de 2013
Emitir parecer conclusivo sobre a gestão do SUS por meio da análise do RAG da respectiva esfera	Anualmente	Inciso III Art. 31 LC nº 141, de 2012; § 3º Art. 5º PRT nº 2.135, de 2013
Avaliar, a cada quadrimestre, o relatório consolidado do resultado da execução	Maio, setembro e fevereiro	Art. 41LC nº 141, de 2012

orçamentária e financeira no âmbito da saúde e o relatório do gestor da saúde (…) e encaminhar ao Chefe do Poder Executivo do respectivo ente da Federação as indicações para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias		

Nota: LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias; PAS – Programação Anual de Saúde; RAG – Relatório Anual de Gestão; SUS – Sistema Único de Saúde. Fonte: Brasil, 2016.

Continuação do Quadro 8 – Agenda do conselho de saúde com foco no ciclo de planejamento.

PROVIDÊNCIAS	PRAZO LEGAL	MARCO LEGAL
Avaliar e emitir parecer conclusivo sobre a PAS	Antes da data de encaminhamento da LDO do exercício correspondente	§ 2º art. 36 LC nº 141, de 2012; Inciso I art. 5ºPRT nº 2.135, de 2013

Nota: LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias; PAS – Programação Anual de Saúde; RAG – Relatório Anual de Gestão; SUS – Sistema Único de Saúde. Fonte: Brasil, 2016.

9.9 Ferramentas de apoio ao planejamento no sus e seu uso estratégico no trabalho da conselheira e do conselheiro de saúde

As ferramentas de apoio ao planejamento no Sistema Único de Saúde constituem instrumentos técnicos essenciais para qualificar a análise da situação de saúde, o acompanhamento da execução das políticas e o exercício do controle social. Essas ações buscam qualificar o planejamento do SUS e fortalecer o processo de regionalização, além de aprimorar a organização da atenção e o rateio dos recursos.

Estão disponibilizadas principalmente no portal do Ministério da Saúde e contam com instrutivos, bases de dados, relatórios, mapas e tabelas que orientam a produção, o envio, a análise e o monitoramento das informações em saúde, sendo fundamentais para subsidiar decisões baseadas em evidências e garantir transparência na gestão pública.

Para a conselheira e o conselheiro de saúde, o uso dessas ferramentas integra diretamente suas atribuições deliberativas e fiscalizatórias, pois possibilita avaliar se o planejamento apresentado pela gestão dialoga com a realidade sanitária do território, se as metas pactuadas são coerentes com as necessidades da população e se os recursos públicos estão sendo aplicados de acordo com a legislação vigente.

O **Mapa da Saúde** é uma **ferramenta de inteligência sanitária georreferenciada** voltada ao apoio ao **planejamento no SUS** e ao **desenvolvimento das regiões de saúde**. Reúne informações sobre **recursos humanos, serviços de saúde, ações programáticas, capacidade instalada, investimentos e resultados observados, abrangendo tanto o setor público quanto o privado**.

Para o controle social, o Mapa da Saúde é estratégico porque subsidia a análise situacional que fundamenta o Plano de Saúde, a Programação Anual de Saúde e a definição de metas, permitindo ao conselho verificar se as prioridades propostas pela gestão estão sustentadas nas condições reais do território, nas desigualdades existentes e nos fluxos de acesso da população aos serviços de saúde.

Figura 8 – Informações do Mapa de Saúde dos municípios do Tocantins, segundo os Relatórios Anuais de Gestão aprovados



Evolução do número de municípios por situação do RAG em cada ano - Detalhes

Situação	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aprovado	135	135	132	135	137	133	117	50	-
Aprovado com Ressalvas	4	4	6	4	2	4	4	1	-
Não Aprovado	-	-	1	-	-	-	1	-	-
Em Análise no Conselho de Saúde	-	-	-	-	-	2	14	42	-
Retornado para Ajustes	-	-	-	-	-	-	2	1	-
	139	139	139	139	139	139	139	139	139

Percentual de municípios por situação do RAG nos últimos anos - Detalhes

Situação	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aprovado	94,96%	97,12%	98,56%	95,68%	84,17%	35,97%
Aprovado com Ressalvas	4,32%	2,88%	1,44%	2,88%	2,88%	0,72%
Não Aprovado	0,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,72%	0,00%
Em Análise no Conselho de Saúde	0,00%	0,00%	0,00%	1,44%	10,07%	30,22%
Retornado para Ajustes	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,44%	0,72%
Em Elaboração	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,07%
Não Iniciado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,72%	22,30%
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Fonte: Adaptado do Novo Sage, 2026.

O **Tabnet**, desenvolvido pelo Datasus, é um tabulador de domínio público que **permite acessar, organizar e analisar dados provenientes das principais bases nacionais do SUS**.

Por meio dos indicadores de saúde, o Tabnet possibilita à conselheira e ao conselheiro:

- Analisar séries históricas;
- Comparar territórios;
- Avaliar tendências;

- Confrontar os resultados alcançados pela gestão com as metas pactuadas anualmente.

Trata-se de um instrumento central para transformar dados em informação qualificada, permitindo que o **controle social** se apoie em **evidências sobre mortalidade, morbidade, acesso aos serviços, qualidade da atenção e condições de vida da população**.

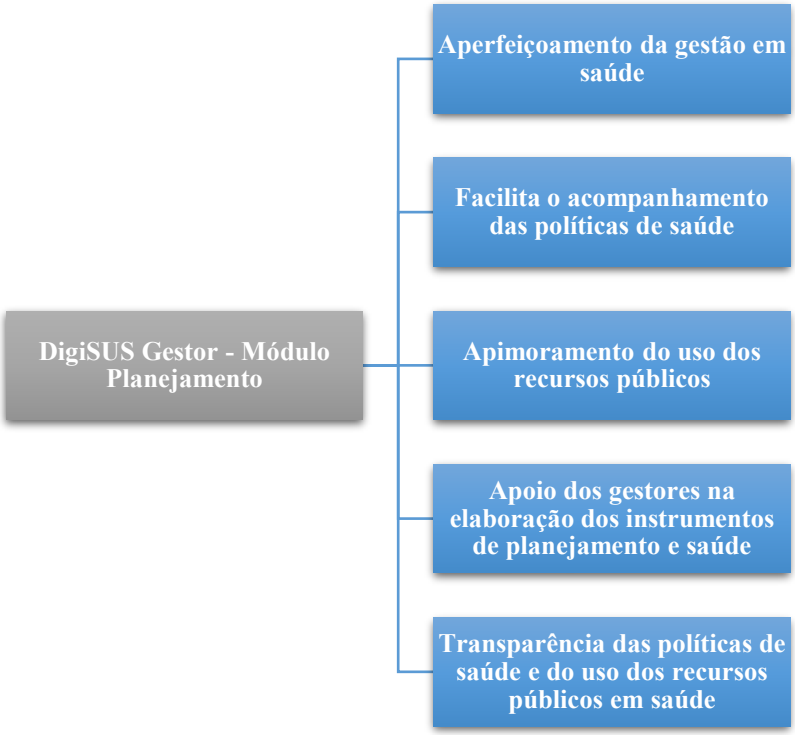
O **Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)** é a principal ferramenta de **acompanhamento do financiamento do SUS**.

De caráter autodeclaratório e obrigatório para todas as esferas de gestão, reúne **informações sobre receitas e despesas em saúde**, permitindo:



Para a conselheira e o conselheiro de saúde, o SIOPS é instrumento central para a **fiscalização financeira**, pois subsidia a análise dos relatórios quadrimestrais, do Relatório de Gestão e da execução orçamentária, possibilitando **identificar inconformidades, subfinanciamento ou desvios de prioridade na aplicação dos recursos** públicos.

O **DigiSUS Gestor – Módulo Planejamento (DGMP)** é uma plataforma digital onde ocorre o registro das informações contidas nos instrumentos de planejamento como Plano de Saúde e PAS, e ocorre a elaboração e envio do RDQA e do RAG para que o conselho de saúde aprecie. Este vem como substitutos do Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão (SargSUS) e ao Sistema de Pactuação de Indicadores do Pacto pela Saúde (Sispacto), passando a ser utilizado a partir de 2018. O DGMP tem os objetivos de:



A Conselheira e o Conselheiro de Saúde atuam no **DGMP na apreciação da RAG e avaliação da RDQA** que a gestão elabora e insere no sistema, podendo emitir o parecer registrando aprovação ou devolver para a gestão realizar ajustes. **O Plano de saúde e a PAS não são encaminhados ao conselho pelo DGMP**, esses são encaminhados por meio físico, e após a deliberação do Conselho o gestor acrescenta a informação do *status* no sistema, anexando a resolução da aprovação assinada.

Figura 9 – Papel dos conselhos no DigiSUS Gestor – Módulo Planejamento.



Fonte: Brasil, 2023.

Portanto, Gestor estadual e municipal, Técnico estadual e municipal e Conselhos de saúde possuem perfil de acesso ao sistema diferente.

Quadro 9 – Perfis de acesso para alimentação do DigiSUS Gestor -Módulo Planejamento.

Perfil	Descrição
Gestor Estadual/Municipal	**- Gestor ou representante por ele indicado.** **- Visualizar, preencher todos os campos de entrada no sistema.** **- Anexar arquivos nos instrumentos: Plano de Saúde, Programação Anual de Saúde, RDQA e RAG.** **- Único perfil com permissão para envio de RDQA e RAG e da Pactuação Interfederativa de Indicadores para apreciação do conselho de saúde.** **- Perfil Gestor Estadual permite homologar a Pactuação Interfederativa dos Indicadores dos municípios.**
Técnico Estadual/Municipal	**- Técnicos que alimentam o sistema.** **- Visualizar, preencher todos os campos de entrada no sistema.** **- Anexar arquivos nos instrumentos: Plano de Saúde, PAS, RDQA e RAG.** **- Perfil Técnico Estadual permite homologar as pactuações dos municípios.**
Conselho Estadual/Municipal	**- Representantes do conselho de saúde.** **- Visualizar as informações inseridas e finalizadas pelo perfil Gestor ou Técnico como Plano de Saúde, PAS, EDQA, RAG e Pactuações.** **- Retorna para ajustes, emite parecer, registra considerações e anexa arquivos relativos às decisões do conselho na Pactuação, no RDQA e no RAG.**

Fonte: Adaptado de Brasil, 2023.

O **DigiSUS**, para o conselho de saúde é uma ferramenta que amplia as condições de acompanhamento, fiscalização e elaboração de políticas públicas fortalecendo o planejamento e o controle social, isso se deve pelo sistema tornar a informação mais acessível, e com possibilidade de comparação entre os diferentes anos; formaliza a decisão do conselho com seus pareceres e considerações quanto ao RDQA e RAG registrados no sistema; fortalece a transparência e a prestação de contas.

Em síntese, o uso articulado do **Mapa da Saúde, do Tabnet, do SIOPS e o DigiSUS fortalece o planejamento, o monitoramento e a avaliação das políticas de saúde**. Para conselheiras e conselheiros de saúde, dominar essas ferramentas amplia a capacidade de análise crítica, qualifica as deliberações do conselho e assegura que o controle social seja exercido de forma técnica, fundamentada e comprometida com a efetivação do direito à saúde no SUS.

BIBLIOGRAFIA

BRASIL. **Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**. Estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Brasília, DF, 1964. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm. Acesso em: 29 set. 2015.

BRASIL. **Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996**. Dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, n. 180, p. 1, 16 set. 1996.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Senado Federal, 1998.

BRASIL. **Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990**. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, n. 182, p. 18055-18059, 20 set. 1990.

BRASIL. **Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990**. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, e dá outras providências. Brasília, DF, 1990. Disponível em: https://conselho.saude.gov.br/legislacao/lei8142_281290.htm. Acesso em: 29 set. 2015.

BRASIL. **Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000**. Altera dispositivos da Constituição Federal e acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para assegurar recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, n. 178, p. 98, 14 set. 2000.

BRASIL. **Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000**. Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, n. 86-E, p. 1, 5 maio 2000.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria nº 699, de 30 de março de 2006**. Regulamenta as Diretrizes Operacionais dos Pactos pela Vida e de Gestão. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, n. 64, p. 49, 3 abr. 2006.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010**. Estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, n. 251, p. 88-93, 31 dez. 2010.

BRASIL. **Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011**. Regula o acesso a informações previsto na Constituição Federal, altera legislação correlata e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, edição extra, p. 1, 18 nov. 2011.

BRASIL. **Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011**. Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, n. 123, p. 1, 29 jun. 2011.

BRASIL. **Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012**. Regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal, dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados em ações e serviços públicos de saúde, estabelece critérios de rateio, normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, n. 11, p. 1, 16 jan. 2012.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria nº 53, de 16 de janeiro de 2013**. Estabelece diretrizes para o funcionamento do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde e fixa prazos para registro e homologação de informações. Brasília, DF, 2013. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt0053_16_01_2013.html. Acesso em: 29 set. 2015.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria nº 2.135, de 25 de setembro de 2013**. Estabelece diretrizes para o processo de planejamento no âmbito do Sistema Único de Saúde. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, n. 187, p. 60, 26 set. 2013.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Departamento de Articulação Interfederativa. **Caderno de diretrizes, objetivos, metas e indicadores** 2013-2015. 3. ed. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2014. (Série Articulação Interfederativa; v. 1).

BRASIL. **Emenda Constitucional nº 86, de 17 de março de 2015**. Altera dispositivos da Constituição Federal para tornar obrigatória a execução da programação orçamentária. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, n. 52, p. 1, 18 mar. 2015.

BRASIL. Ministério da Saúde; FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. **Manual de planejamento no SUS**. 1. ed. rev. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2016. 138 p. (Série Articulação Interfederativa; v. 4).

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria nº 750, de 29 de abril de 2019**. Altera a Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para instituir o Sistema DigiSUS Gestor/Módulo de Planejamento - DGMP, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Brasília, DF, 2019. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2019/prt0750_06_05_2019.html. Acesso em: 19 abr. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Departamento de Gestão Interfederativa e Participativa. **Manual do usuário para conselheiros de saúde**: DigiSUS Gestor - Módulo Planejamento. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2023. 61 p. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_usuarios_conselheiros_digisus_gestor.pdf. Acesso em: 19 abr. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Departamento de Gestão Interfederativa e Participativa. **DigiSUS gestor**: módulo planejamento: manual do usuário. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2025. 90 p. Disponível

em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/digisus_gestor_manual_usuario.pdf. Acesso em: 19 abr. 2026.

COSEMS-RJ; LAPPIS/IMS/UERJ. **Manual do(a) gestor(a) municipal do SUS**: “Diálogos no cotidiano”. 2. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: CEPESC, 2019. 424 p. Disponível em: https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2019/07/manual_do_gestor_F02_tela.pdf. Acesso em: 27 mar. 2026.

Texto 9 - Financiamento do SUS: História, marcos legais, desafios e a luta do controle social

10 HISTÓRIA DO FINANCIAMENTO DO SUS

O financiamento do SUS nasce marcado por uma contradição estrutural, pois, embora a Constituição Federal de 1988 tenha afirmado a saúde como direito de todos e dever do Estado, incorporando-a ao campo da Seguridade Social, não instituiu, de forma concomitante, um modelo de financiamento robusto, progressivo e suficiente para sustentar um sistema universal em um país marcado por profundas desigualdades sociais, regionais e econômicas.

Desde sua **criação, o SUS passou a operar em um contexto de restrições fiscais** permanentes, herdeiro de um modelo econômico orientado pela contenção do gasto público, pela priorização do pagamento da dívida e pela fragilização das políticas sociais, o que resultou em uma **trajetória histórica de subfinanciamento crônico**, caracterizada pela insuficiência de recursos para garantir, de maneira plena, a universalidade, a integralidade e a equidade da atenção à saúde.

Ao longo das **décadas de 1990 e 2000**, esse **subfinanciamento foi parcialmente mascarado pela ampliação da participação de estados e**, sobretudo, **municípios no custeio do SUS**, deslocando progressivamente o peso do financiamento para os entes subnacionais, sem que houvesse, por parte da União, um compromisso proporcional com o aumento real e sustentado dos recursos federais.

Esse movimento gerou uma **dependência crescente das transferências intergovernamentais**, **aprofundou desigualdades territoriais e tensionou a capacidade de planejamento e gestão local**, tornando o financiamento do SUS uma questão central não apenas técnica, mas eminentemente política.

Diálogo com a conselheira e o conselheiro



Fonte: Gemni / Nano Banana.

Situação problema	
 Fonte: Autoria de IA	No Durante a análise do RAG, o gestor afirma que a dificuldade de ampliar serviços decorre apenas da “alta demanda da população”.
Como conselheira ou conselheiro, como você demonstra, com base histórica e orçamentária, que a limitação não é apenas demanda crescente, mas um padrão histórico de subfinanciamento estrutural do SUS?	

***

10.1 As Emendas Constitucionais nº 86/2015 e nº 95/2016 e o processo de subfinanciamento do SUS – a chamada “PEC da morte”

A **Emenda Constitucional nº 86, de 2015**, alterou significativamente o modelo de vinculação do gasto federal em saúde ao **estabelecer um percentual da Receita Corrente Líquida como referência mínima de aplicação**, ao mesmo tempo em que **institucionalizou o orçamento impositivo**, o que, embora tenha introduzido maior previsibilidade formal para determinadas despesas, não enfrentou o núcleo estrutural do subfinanciamento do SUS, **mantendo a insuficiência do aporte federal** frente às necessidades sanitárias da população e **fragmentando a lógica do planejamento sistêmico** por meio da pulverização de **recursos vinculados a emendas parlamentares**.

Esse quadro se agravou de forma profunda com a **Emenda Constitucional nº 95, de 2016**, amplamente conhecida como **PEC do teto de gastos ou PEC da morte**, que instituiu um **regime fiscal de austeridade ao congelar, por vinte anos, o crescimento real das despesas primárias da União**, desvinculando o financiamento das políticas sociais da dinâmica demográfica, epidemiológica e tecnológica. No campo da saúde, essa emenda produziu um **desfinanciamento progressivo e cumulativo do SUS**, reduzindo a participação da União no gasto total, comprimindo a capacidade de resposta do sistema e transferindo ainda mais responsabilidades financeiras para estados e municípios, com impactos diretos sobre a oferta de serviços, a força de trabalho em saúde e a sustentabilidade da atenção básica e das redes de atenção.

Diálogo com a conselheira e o conselheiro



Fonte: Gemni / Nano Banana.

Situação problema	
 Fonte: Autoria de IA	No debate do PPA, o gestor afirma que "o orçamento da saúde está crescendo todo ano".
Como você demonstra que o crescimento nominal não significa fortalecimento do SUS quando o teto de gastos impede aumento real do financiamento?	

***

10.2 Legislação sobre o financiamento do Sistema Único de Saúde: da Constituição Federal às normas infraconstitucionais

A legislação sobre o financiamento do SUS estrutura-se como um arcabouço jurídico complexo e historicamente tensionado, que reflete tanto os avanços democráticos inscritos na Constituição Federal de 1988 quanto as disputas políticas e econômicas em torno do papel do Estado na garantia do direito à saúde.

A **Constituição de 1988** inaugura um marco civilizatório ao **reconhecer a saúde como direito social fundamental e dever do Estado**, ao instituir o SUS e ao vinculá-lo ao orçamento da Seguridade Social, estabelecendo que seu financiamento deve ser compartilhado entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, com **recursos provenientes dos orçamentos públicos e das contribuições sociais**.

No entanto, apesar desse desenho constitucional avançado, a Carta Magna **não definiu**, de forma suficientemente precisa, **os mecanismos operacionais, os percentuais mínimos e os critérios de cálculo necessários para assegurar um financiamento estável**, progressivo e

compatível com a universalidade do sistema, o que abriu espaço para ambiguidades, disputas interpretativas e práticas restritivas ao longo dos anos seguintes.

Nesse contexto, as Leis nº 8.080 e nº 8.142, ambas promulgadas em 1990, assumem papel central na regulamentação infraconstitucional do SUS e de seu financiamento.

A **Lei nº 8.080 organiza o sistema**, define suas atribuições, explicita a responsabilidade dos entes federados e **reafirma que as ações e serviços públicos de saúde devem ser financiados com recursos do orçamento da Seguridade Social e de outras fontes**.

Enquanto a **Lei nº 8.142** introduz um elemento político-institucional decisivo ao **vincular o financiamento à participação social, ao instituir os conselhos de saúde como instâncias deliberativas e ao condicionar a transferência regular e automática de recursos à existência de fundo de saúde, plano de saúde, relatório de gestão, contrapartida financeira e funcionamento do conselho de saúde**. Essa vinculação transforma o financiamento em um campo privilegiado de atuação do controle social, pois subordina o fluxo de recursos públicos à observância de regras de planejamento, transparência e participação democrática.

Ao longo da **década de 1990 e início dos anos 2000**, contudo, a **ausência de critérios claros sobre o que poderia ser contabilizado como gasto em saúde e a inexistência de percentuais mínimos definidos** para todas as esferas de governo permitiram práticas que fragilizaram o financiamento do SUS, como a inclusão de despesas alheias às ações e serviços públicos de saúde e a utilização de expedientes fiscais que reduziram a participação efetiva da União no custeio do sistema.

A **Emenda Constitucional nº 29, de 2000**, surge nesse cenário como uma resposta parcial às pressões sociais e institucionais por maior segurança jurídica, ao **estabelecer percentuais mínimos de aplicação para estados e municípios e um critério de correção para o gasto federal**, ainda que mantenha **lacunas** relevantes, especialmente **quanto à definição do conceito de ações e serviços públicos de saúde** e quanto à **garantia de crescimento real do financiamento federal**.

É nesse ponto que se insere a **Lei Complementar nº 141, de 2012**, como um dos marcos mais importantes da legislação infraconstitucional sobre o financiamento do SUS, ao regulamentar de forma detalhada o § 3º do art. 198 da Constituição Federal.

Essa lei **define com precisão o que pode e o que não pode ser considerado gasto em ações e serviços públicos de saúde, estabelece regras claras para a apuração dos percentuais mínimos**, disciplina a **movimentação dos recursos** exclusivamente **por meio dos fundos de saúde** e **institui mecanismos robustos de transparência, fiscalização, avaliação**

e controle, vinculando a execução financeira **aos instrumentos de planejamento e aos sistemas oficiais de informação**.

Ao fazê-lo, a Lei Complementar nº 141 **fortalece** juridicamente **o papel dos conselhos de saúde**, pois fornece **parâmetros objetivos para a análise do orçamento, da execução financeira e dos relatórios de gestão**, reduzindo a margem para manipulações contábeis e ampliando a capacidade de incidência do controle social.

Entretanto, a consolidação desse arcabouço legal não elimina as contradições estruturais do financiamento do SUS, uma vez que a legislação infraconstitucional regula a aplicação, o controle e a transparência de recursos que permanecem insuficientes frente às necessidades de saúde da população, especialmente em um contexto de envelhecimento demográfico, transição epidemiológica e incorporação crescente de tecnologias.

Assim, a legislação sobre o financiamento do SUS deve ser compreendida pelas conselheiras e conselheiros de saúde não apenas como um conjunto de normas a serem verificadas formalmente, mas como um campo de disputa política permanente, no qual o domínio técnico da Constituição, das leis orgânicas da saúde e das normas complementares se converte em instrumento fundamental para a defesa do direito à saúde, para o enfrentamento do subfinanciamento e para a afirmação do controle social como pilar estruturante do SUS. O quadro 1 faz o resumo da legislação sobre financiamento do SUS.

Quadro 1 – Resumo sobre a legislação do financiamento do Sistema Único de Saúde

Legislação	**Marcos**	**Limitações**
Constituição Federal de 1988	- Saúde é um direito social e dever do Estado; - Financiamento compartilhado entre as três esferas de governo; - Recursos a partir de orçamentos públicos e contribuições sociais.	- Não definiu mecanismos operacionais; - Não determinou percentuais mínimos; - Não estabelece critérios de cálculos para um financiamento estável, progressivo e atendimento universal.
Lei 8080/1990	- Organiza o SUS por meio de atribuições e responsabilidades das esferas governamentais; - Recursos a partir de orçamentos públicos e contribuições sociais.	- Ausência de critérios claros sobre o que inclui nos gastos em saúde - Inexistência de percentuais mínimos definidos para todas as esferas; - Inclusão de despesas alheias às ações e serviços públicos de saúde;

		- Redução da participação da União no custeio do SUS.

Fonte: Autoria própria

Continuação do Quadro 1 – Resumo sobre a legislação do financiamento do Sistema Único de Saúde

Legislação	Marcos	Limitações
Constituição Federal de 1988	- Saúde é um direito social e dever do Estado; - Financiamento compartilhado entre as três esferas de governo; - Recursos a partir de orçamentos públicos e contribuições sociais.	- Não definiu mecanismos operacionais; - Não determinou percentuais mínimos; - Não estabelece critérios de cálculos para um financiamento estável, progressivo e atendimento universal.
Lei 8080/1990	- Organiza o SUS por meio de atribuições e responsabilidades das esferas governamentais; - Recursos a partir de orçamentos públicos e contribuições sociais.	- Ausência de critérios claros sobre o que inclui nos gastos em saúde - Inexistência de percentuais mínimos definidos para todas as esferas; - Inclusão de despesas alheias às ações e serviços públicos de saúde; - Redução da participação da União no custeio do SUS.
Lei 8142/1990	- Financiamento vinculado à participação social, e de regras de planejamento, transparência; - Conselhos de saúde: instância deliberativa; - Recursos com transferência regular e automática vinculada ao Fundo de Saúde, Plano de Saúde, RDQA, RAG, contrapartida e conselho de saúde ativo.	
Emenda Constitucional 29/2000	- Estabelece percentuais mínimos de recurso para estados e municípios; - Define critério de correção para a União.	- Não define o que são ações e serviços de saúde; - Não garante o aumento financeiro federal diante do crescimento real.
Lei Complementar 141/2012	- Define gastos de ações e serviços de saúde e regras dos percentuais mínimos; - Institui regras de movimentação de recursos pelos Fundos de Saúde; - Estabelece os mecanismos de transparência, fiscalização, avaliação e controle por meio dos instrumentos de planejamento e sistemas de informação;	-

	- Conselho de saúde tem seus parâmetros de análise de orçamento, de controle de gastos e relatórios de gestão criados.	

Fonte: Autoria própria

Situação problema	
 Fonte: Autoria de IA	O gestor encaminha a prestação de contas fora do prazo e solicita "aprovação ad referendum" do conselho para não perder recursos.
Quais dispositivos legais fundamentam a exigência de análise prévia e qualificada antes da aprovação?	

***

10.3 A lei complementar Nº 141/2012 para o controle social, leitura aplicada e minuciosa

A Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal e **organiza, de forma operacional, o que o controle social precisa cobrar para que o financiamento do SUS** seja verificável, comparável e responsabilizável, pois define o que pode ser contabilizado como ações e serviços públicos de saúde, fixa regras de cálculo dos mínimos, disciplina transferências fundo a fundo, e amarra transparência, prestação de contas e fiscalização com instrumentos e prazos.

10.3.1 Percentuais mínimos e regra federal, com base de cálculo explícita

- A **União** deve aplicar, **anualmente**, **em ações e serviços públicos de saúde**, o montante correspondente ao **valor empenhado no exercício anterior, acrescido, no mínimo, do percentual correspondente à variação nominal do PIB ocorrida no ano anterior** ao da LOA, e, se houver variação negativa do PIB, o valor não pode ser reduzido em termos nominais de um exercício para o outro.
- **Estados e Distrito Federal** devem aplicar, no **mínimo, 12% da arrecadação de impostos e das transferências constitucionais** citadas na lei, deduzidas as parcelas transferidas aos Municípios.
- No caso do Distrito Federal, há regra adicional para a arrecadação direta de impostos que não possam ser segregados em base estadual e base municipal, também com mínimo de 12%.
- **Municípios e Distrito Federal** devem aplicar, no **mínimo, 15% da arrecadação de impostos e das transferências** constitucionais mencionadas na lei.
- A **base de cálculo** deve considerar **compensações financeiras de impostos e transferências constitucionais**, além de **dívida ativa, multa e juros de mora decorrentes dos impostos**, cobrados administrativa ou judicialmente, com impacto direto no cálculo do mínimo.

Além disso, se a Constituição Estadual ou Lei Orgânica Municipal fixar percentuais superiores, vale o percentual maior, e o conselho deve cobrar o cumprimento do patamar local.



Fonte: Gemni / Nano Banana.

Pense no mínimo constitucional como uma "linha d'água" marcada no reservatório, se a base de cálculo aumenta, a linha sobe junto, e não cumprir significa deixar o sistema operar abaixo do nível de segurança, com risco de colapso em oferta, filas e acesso.

10.3.2 O que pode ser contabilizado como ações e serviços públicos de saúde, e o que é vedado

A Lei não permite que o gestor "engorde" o mínimo com despesas fora do escopo do SUS, por isso define critérios cumulativos: para contar como despesa em ações e serviços públicos de saúde, precisa ser voltada à promoção, proteção e recuperação da saúde, e atender simultaneamente princípios do SUS e diretrizes da própria Lei, incluindo acesso universal, igualitário e gratuito, aderência a objetivos e metas do Plano de Saúde, e responsabilidade específica do setor saúde, sem se confundir com outras políticas públicas, mesmo que atuem em determinantes sociais.

Exemplos do que conta, com atenção ao controle social

- ✓ Vigilância em saúde, inclusive epidemiológica e sanitária.
- ✓ Atenção integral e universal em todos os níveis, incluindo assistência terapêutica e recuperação de deficiências nutricionais.
- ✓ Capacitação de pessoal do SUS.
- ✓ Insumos específicos do SUS, como imunobiológicos, sangue e hemoderivados, medicamentos e equipamentos médico odontológicos.
- ✓ Investimento na rede física do SUS, com obras de recuperação, reforma, ampliação e construção de estabelecimentos públicos de saúde.
- ✓ Remuneração do pessoal ativo da área de saúde em atividade nas ações e serviços, com encargos sociais, o que exige do conselho checar se o profissional está alocado em atividade de saúde e se a folha não está "contaminada" por desvios de função.
- ✓ Saneamento básico de domicílios ou pequenas comunidades, apenas se aprovado pelo Conselho de Saúde do ente financiador e se estiver de acordo com as diretrizes legais, o que transforma o conselho em "condição de validade" para essa contabilização.

Exemplos do que NÃO conta, e que costuma aparecer em auditorias e impugnações

- × Aposentadorias e pensões, inclusive de servidores da saúde.
- × Merenda escolar e programas de alimentação, em regra, ainda que executados em unidades do SUS, com ressalvas específicas na Lei.
- × Limpeza urbana e remoção de resíduos.
- × Ações de assistência social.
- × Obras de infraestrutura, mesmo que beneficiem indiretamente a rede.
- × Ponto de vigilância do conselho.

A pergunta prática é sempre a mesma:

A despesa cumpre acesso universal, está no Plano de Saúde e é responsabilidade típica do setor saúde, se não cumprir os três, o mínimo pode estar artificialmente "cumprido" no papel e descumprido na vida real?

10.3.3 Fundos de Saúde, rastreabilidade e regra de movimentação

A Lei reforça que as **despesas consideradas para apuração do mínimo devem ser financiadas com recursos movimentados por meio dos respectivos Fundos de Saúde**, porque o fundo funciona como trilha contábil e financeira que permite rastrear origem, finalidade e execução, e isso dá ao controle social uma chave prática: se está fora do fundo, tende a estar fora do mínimo, ou, no mínimo, exige justificativa e prova robusta.

Ela também reconhece o **Fundo de Saúde como unidade orçamentária e gestora exclusiva dos recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde**, o que sustenta cobranças sobre segregação, conciliação bancária e consistência contábil.

10.3.4 Como o mínimo é apurado ao longo do ano, restos a pagar e correções quadrimestrais

Para **fixação inicial do mínimo**, considera-se a receita estimada na LOA, ajustada por créditos adicionais quando existirem, e as diferenças entre receita e despesa previstas e efetivamente realizadas, que resultem em não atendimento do mínimo, devem ser **apuradas e**

corrigidas a cada quadrimestre, o que oferece ao conselho um mecanismo de alerta precoce, antes do encerramento do exercício.

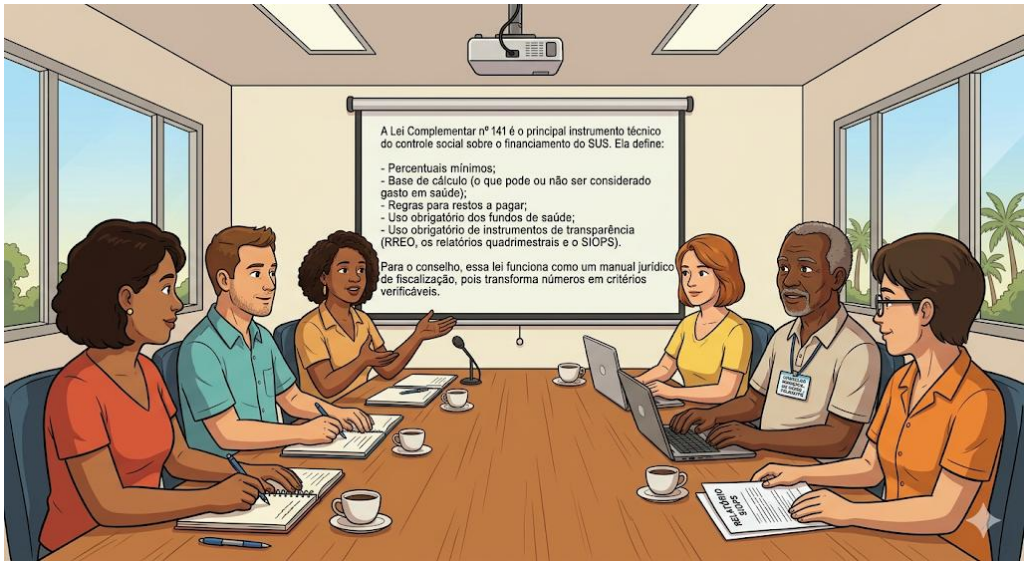
Fixação inicial do mínimo = Receita estimada na LOA + ajuste de créditos adicionais[1] + (receita – despesa previstas e realizadas)

Para o cálculo do mínimo, entram despesas liquidadas e pagas no exercício, e também despesas empenhadas e não liquidadas inscritas em restos a pagar, mas somente até o limite das disponibilidades de caixa ao final do exercício, consolidadas no Fundo de Saúde, porque resto a pagar sem caixa vira maquiagem fiscal.

Se **restos a pagar considerados para fins de mínimo forem cancelados ou prescritos**, a disponibilidade de caixa vinculada deve ser **aplicada em ações e serviços públicos de saúde até o término do exercício seguinte ao do cancelamento ou prescrição**, com dotação específica, sem prejuízo do mínimo do ano corrente, e aqui o conselho deve cobrar rastreio de "reposição do mínimo" e não aceitar que o cancelamento feche a conta sem recomposição.

Se houver diferença que implique não atendimento do mínimo em um exercício, ela deve ser acrescida ao montante mínimo do exercício subsequente, sem prejuízo do mínimo do próprio exercício de referência, o que evita anistia automática de descumprimento.

Diálogo com a conselheira e o conselheiro



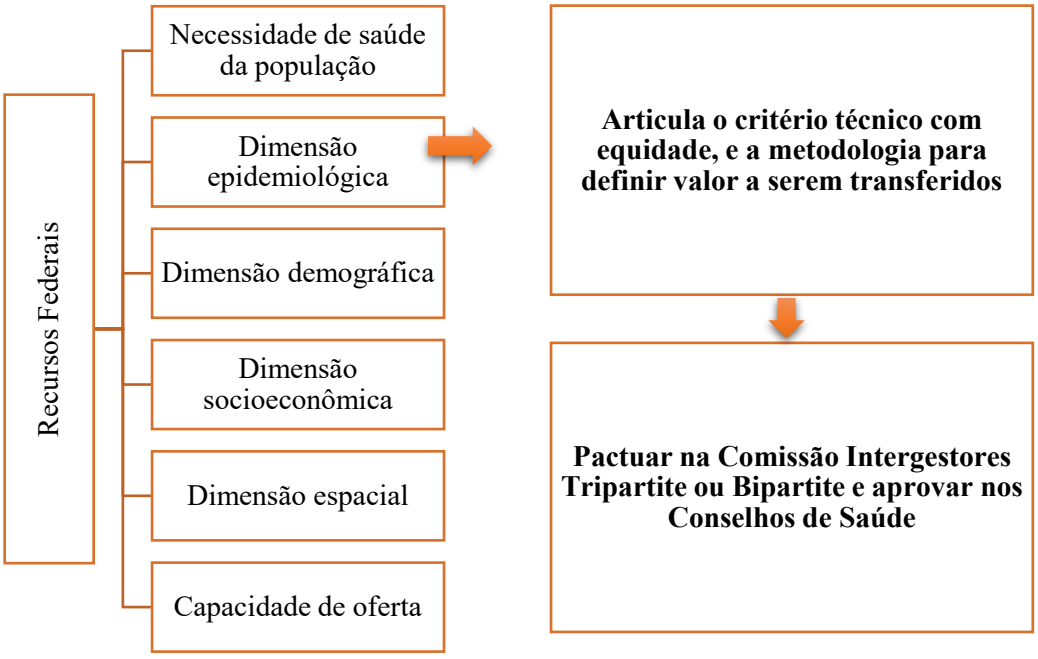
Fonte: Gemni / Nano Banana.

Situação problema	
 Fonte: Autoria de IA	Na execução orçamentária, o gestor contabiliza despesas com limpeza urbana como gasto em saúde para alcançar o mínimo constitucional.
Com base na Lei Complementar nº 141, como você identifica a irregularidade e quais providências institucionais pode adotar?	

***

10.3.5 Rateio e transferências, critério de equidade e pactuação com aprovação do conselho

O rateio de recursos federais vinculados à saúde deve observar necessidades de saúde da população e dimensões epidemiológica, demográfica, socioeconômica, espacial e capacidade de oferta, **articulando o critério técnico com equidade, e a metodologia para definir montantes a serem transferidos deve ser pactuada** na Comissão Intergestores Tripartite e aprovada no Conselho Nacional de Saúde, com publicação anual pelo Ministério da Saúde, o que dá ao controle social base para questionar critérios obscuros e variações inexplicadas entre entes e regiões.

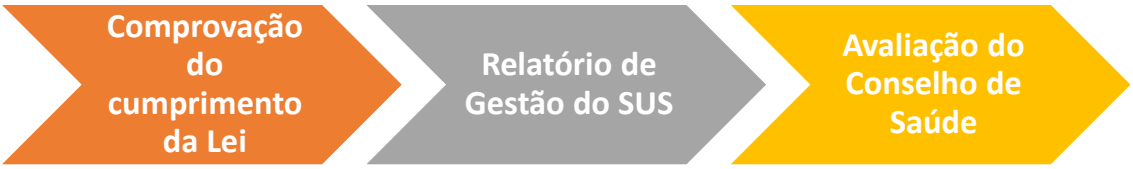


A Lei reconhece a **transferência regular e automática fundo a fundo**, com dispensa de convênio como regra, e **convênio como exceção em situações específicas**. Portanto, o conselho deve desconfiar de **"convênios como rotina" e exigir justificativa técnica e legal quando ocorrer**.

Nos Estados, o rateio para Municípios também deve considerar necessidades de saúde, dimensões epidemiológica, demográfica, socioeconômica e espacial, e a capacidade de oferta, com foco em reduzir desigualdades regionais, e os Planos Estaduais de Saúde devem explicitar metodologia de alocação e previsão anual aos Municípios, pactuadas na CIB e aprovadas pelo Conselho Estadual de Saúde, o que transforma o Plano e a aprovação do conselho em peça central para questionar distribuição injusta.

10.3.6 Transparência, prestação de contas e instrumentos que o conselho precisa exigir, com prazos

A Lei exige **ampla divulgação, inclusive por meios eletrônicos de acesso público, das prestações de contas periódicas**, com ênfase em três eixos:



A "opinião fundamentada do conselho" passa a integrar o pacote de transparência e não pode ser tratada como adorno.

Instrumentos obrigatórios que amarram finanças e resultados

a) Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO):

- Demonstrativo das despesas com saúde;
- Publicado até 30 dias após o encerramento de cada bimestre;
- Usado para subsidiar parecer prévio do Tribunal de Contas.

O conselho deve usar o bimestre para monitorar tendência e risco de descumprimento do mínimo ainda dentro do ano.

b) Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA):

- Obrigatório para todo gestor do SUS
- Deve conter no mínimo: montante e fonte dos recursos aplicados, auditorias realizadas ou em execução com recomendações, e oferta e produção de serviços na rede própria, contratada e conveniada;
- Aferir os indicadores de saúde, com apresentação em audiência pública na Casa Legislativa até o final de maio, setembro e fevereiro, e modelo padronizado pelo Conselho Nacional de Saúde, com versão simplificada para municípios com menos de 50 mil habitantes.

O conselho ganha o "momento institucional" para confronto público entre gasto, produção e resultado.

c) Relatório Anual de Gestão:

- Enviado ao Conselho de Saúde até 30 de março do ano seguinte ao da execução financeira;

- Parecer do conselho emitido conclusivo sobre o cumprimento ou não da Lei, e esse parecer deve ter ampla divulgação, inclusive eletrônica.

O controle social precisa tratar esse parecer como ato deliberativo com fundamentação, evidências e recomendações.



Fonte: Gemni / Nano Banana.

Se o orçamento é o "mapa", o Relatório Quadrimestral é o "GPS em tempo real", e o Relatório de Gestão com parecer do conselho é o "laudo de auditoria cidadã" que registra o trajeto, aponta desvios e pede correção.

10.3.7 Sistema de Informação sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) como instrumento legal de controle, fé pública e integração com controle externo

A Lei determina que o Ministério da Saúde mantenha sistema eletrônico centralizado de registro das informações de orçamento público em saúde, com acesso público, e estabelece **requisitos mínimos do SIOPS**, incluindo **registro obrigatório** e **atualização permanente**, **processos informatizados**, **disponibilização do programa**, **cálculo automático dos mínimos**

aplicados, e **módulo específico de controle externo** para registro de informações pelo Tribunal de Contas.

Além disso, é necessário a **integração com sistema de controle das transferências** para verificar exigências legais.

Isto permite ao conselho triangulação de dados entre SIOPS, Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e relatórios locais.

O gestor declarante é responsável pelo registro no prazo e pela fidedignidade dos dados homologados, aos quais se confere fé pública, então inconsistência reiterada ou manipulação pode e deve ser tratada como matéria de responsabilização e comunicação a órgãos competentes. O Ministério da Saúde, ao verificar descumprimento, deve dar ciência à direção local do SUS e ao respectivo Conselho de Saúde, além de auditoria do SUS, Ministério Público e órgãos de controle interno e externo, observada a origem do recurso, o que abre caminho formal para atuação proativa do conselho com base em comunicação oficial.

10.3.8 Condicionamento, medidas restritivas e responsabilização, o que o conselho deve acionar

A Lei admite condicionamento da entrega de recursos mediante comprovação de aplicação adicional do percentual mínimo que deixou de ser aplicado no exercício anterior.

No caso de descumprimento por Estados, DF e Municípios, a União e os Estados podem restringir, como medida preliminar, o repasse para aplicação em saúde até o montante correspondente ao mínimo não aplicado, com depósito direto em conta vinculada ao Fundo de Saúde.

Há previsão de ciência ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público quando houver desvio de objeto, com providências para devolução e responsabilização, o que deve ser lido pelo conselho como "gatilho de acionamento institucional" quando identifica descumprimento ou gasto fora do art. 3º.

Também **fica vedada limitação de empenho e movimentação financeira que comprometam a aplicação dos mínimos**. Portanto, contingenciamentos que inviabilizem o mínimo podem ser questionados com base legal, e é vedado excluir parcelas de impostos ou

transferências constitucionais da base de cálculo por vinculações a fundos ou despesas, o que protege o mínimo contra "manobras contábeis" de redução artificial da base.

10.3.9 Planejamento e orçamento, onde o conselho ganha poder de indução

A Lei determina que **PPA, LDO, LOA e planos de aplicação dos fundos sejam elaborados para dar cumprimento ao mínimo**. Detalha que o planejamento deve ser ascendente, do local ao federal, a partir das necessidades de saúde por região, com base em perfil epidemiológico, demográfico e socioeconômico, e com compatibilização entre necessidades e disponibilidade de recursos, pois é nesse encadeamento que se define meta anual e custo estimado, e o orçamento passa a ser testável contra o Plano.

Do ponto de vista do controle social, isso significa que **não basta cobrar "quanto foi gasto", é obrigatório cobrar coerência entre prioridades, metas, custo e execução, como se fosse uma cadeia lógica única**, e quando ela se rompe, a ruptura vira achado de controle.

10.3.10 Desafios para o financiamento do Sistema Único de Saúde: o desfinanciamento como projeto político

O desfinanciamento do Sistema Único de Saúde não pode ser compreendido como um fenômeno episódico, técnico ou meramente decorrente de crises econômicas conjunturais, mas como a expressão de um projeto político e econômico de restrição do Estado social, que se materializa por meio de escolhas fiscais, normativas e orçamentárias reiteradas ao longo do tempo, com impactos cumulativos sobre a capacidade do SUS de garantir direitos.

Diferentemente do subfinanciamento histórico, que marca o nascimento do SUS em um contexto de transição democrática sem ruptura com a lógica fiscal herdada do período autoritário, o desfinanciamento caracteriza-se pela retirada ativa e programada de recursos, pela compressão deliberada do gasto público em saúde e pela redefinição do papel do Estado na proteção social.

Esse processo torna-se mais evidente a partir da década de 2010, quando se consolida uma agenda de austeridade fiscal que passa a tratar o gasto social como variável de ajuste macroeconômico, deslocando o financiamento das políticas públicas do campo dos direitos para o campo das despesas a serem contidas.

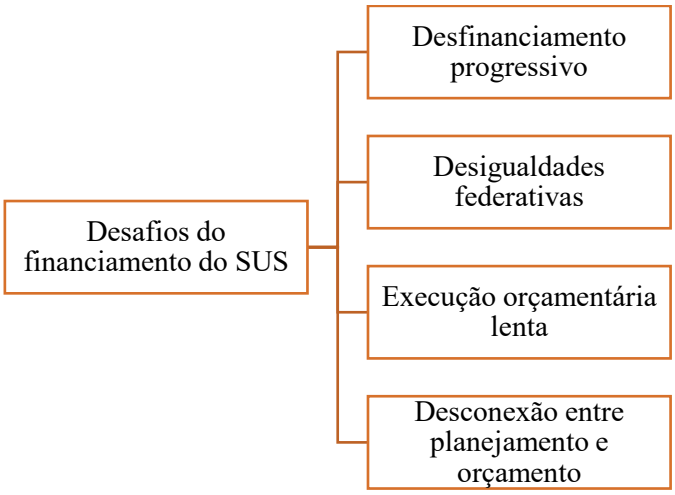
A Emenda Constitucional nº 95, de 2016 (EC 95), representa o ponto de inflexão mais agudo desse movimento, pois institui um **regime fiscal que congela, em termos reais, as despesas primárias da União por vinte anos**, **rompendo o vínculo entre financiamento da saúde e necessidades da população, crescimento demográfico, transição epidemiológica e incorporação tecnológica**. Ao limitar o crescimento do gasto à inflação do ano anterior, a EC 95 transforma o piso constitucional da saúde em um teto efetivo, promovendo perdas acumuladas ano a ano e reduzindo, de forma estrutural, a participação da União no financiamento do SUS.

As evidências analisadas nos estudos sobre financiamento demonstram que esse congelamento não é neutro, pois opera em um contexto de crescimento da demanda por serviços de saúde, envelhecimento populacional, aumento da prevalência de condições crônicas e maior complexidade assistencial. Este fator significa que, mesmo mantendo valores nominais crescentes, o SUS passa a dispor de menos recursos por habitante, menos recursos por procedimento e menos capacidade de expansão e qualificação da rede. O desfinanciamento, portanto, não se expressa apenas na redução explícita de dotação orçamentária, mas na erosão silenciosa da capacidade estatal de sustentar políticas universais.

Esse movimento também aprofunda desequilíbrios federativos, pois, ao reduzir o esforço federal, transfere implicitamente responsabilidades para estados e, sobretudo, municípios, que já aplicam percentuais elevados de suas receitas próprias em saúde, muitas vezes acima do mínimo constitucional, em um cenário de baixa capacidade arrecadatória e forte dependência de transferências intergovernamentais. **O resultado é um sistema em que os entes locais financiam a maior parte da execução direta dos serviços, enquanto a União, que concentra a maior parcela da arrecadação tributária, reduz sua participação relativa, comprometendo o princípio da solidariedade federativa inscrito na Constituição.**

Outro elemento central do desfinanciamento é a **desvinculação entre planejamento e orçamento**, pois a compressão fiscal imposta por normas como a EC 95 **esvazia a capacidade dos instrumentos de planejamento do SUS de orientarem efetivamente a alocação de recursos.** Planos de Saúde e Programações Anuais passam a operar como cartas de intenção, desconectadas da realidade orçamentária, gerando frustração institucional, baixa previsibilidade e dificuldade de pactuação intergestores. **Nesse contexto, o planejamento deixa de ser instrumento de indução de políticas e passa a funcionar como mecanismo de gestão da escassez.**

Além disso, o desfinanciamento cria **terreno fértil para processos de mercantilização e privatização indireta da saúde**, na medida em que a insuficiência de recursos públicos fragiliza a rede estatal, amplia filas e vazios assistenciais e legitima, no discurso público, soluções baseadas na compra de serviços privados, na ampliação de parcerias e na transferência de responsabilidades ao mercado. Assim, o desfinanciamento não apenas reduz recursos, mas reconfigura o modelo de sistema, tensionando o caráter público, universal e estatal do SUS.



Para o controle social, o desafio central é transformar dados financeiros em análise política, demonstrando como decisões fiscais impactam diretamente a oferta de serviços, o acesso e a qualidade do cuidado.

Situação problema	
 Fonte: Autoria de IA	Ao longo do ano, o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) indica baixa execução orçamentária da saúde, mas o gestor afirma que "o recurso está garantido".
Por que a execução tempestiva é tão importante quanto a dotação autorizada e como isso afeta o direito à saúde?	

***

10.4 O financiamento do SUS como luta permanente do controle social

Diante desse cenário, o financiamento do SUS assume centralidade estratégica para o controle social, pois é no campo orçamentário e financeiro que se materializam, de forma real, as disputas sobre o alcance dos direitos sociais.

Para as conselheiras e conselheiros de saúde, compreender o financiamento como luta significa reconhecer que **o controle social não se limita à verificação formal do cumprimento de percentuais mínimos, mas envolve a disputa política pelo fundo público, a defesa da vinculação constitucional e a denúncia de medidas que promovem desfinanciamento estrutural.** Essa luta se expressa em múltiplas dimensões.

a) **Atuação sobre o ciclo orçamentário completo**: desde o acompanhamento do PPA e da LDO até a análise da LOA e da execução financeira, articulando planejamento, orçamento e resultados em saúde.
b) **Apropriação crítica dos instrumentos de transparência**: RREO, os RDQA, o RAG e o SIOPS, não como peças burocráticas, mas como evidências políticas que permitem demonstrar, com dados oficiais, o impacto das escolhas fiscais sobre a vida da população.
c) **Luta do controle social pelo financiamento:** envolve a capacidade de incidir no debate público, traduzindo números e percentuais em consequências compreensíveis, como redução de equipes, descontinuidade de serviços, falta de medicamentos, precarização do trabalho em saúde e aumento de desigualdades regionais.

Ao fazer essa **mediação entre orçamento e cotidiano, o conselho cumpre sua função pedagógica e política, ampliando a legitimidade social do SUS e fortalecendo a defesa do direito à saúde.**

Por fim, o financiamento do SUS como luta do controle social exige uma postura ativa e contínua, pois o desfinanciamento não se apresenta de forma abrupta, mas como um processo gradual, cumulativo e frequentemente naturalizado no discurso técnico da austeridade. Enfrentá-lo requer conselheiras e conselheiros capazes de articular conhecimento técnico, leitura crítica da legislação, compreensão do contexto macroeconômico e compromisso ético com a defesa da vida, reconhecendo que cada decisão orçamentária é, em última instância, uma decisão sobre quem vive, quem adoece e quem tem acesso ao cuidado.

Diálogo com a conselheira e o conselheiro



Fonte: Gemni / Nano Banana.

Situação problema	
 Fonte: Autoria de IA	Em audiência pública, parte da população questiona a atuação do conselho, afirmando que “o conselho só aprova contas”.
Como você explica o papel estratégico do controle social na defesa do financiamento do SUS e na proteção do direito à saúde?	

***

BIBLIOGRAFIA

BRASIL. Ministério da Saúde; FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. **Manual de planejamento no SUS.** 1. ed. revisada. Brasília, DF: Ministério da Saúde; Fundação Oswaldo Cruz, 2016. ISBN 978-85-334-2327-5.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Manual de orçamento e finanças públicas para Conselheiros e Conselheiras de Saúde.** Brasília: Ministério da Saúde, 2016. 105 p.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Especializada à Saúde. Departamento de Regulação Assistencial e Controle. **Curso I: Regulação de Sistemas de Saúde do SUS: módulo 2: Gestão do SUS: Planejamento, Programação e Financiamento da Saúde** (recurso eletrônico). 1. ed. revisada. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2022.

CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE (CONASS). **Nota Técnica n. 06, 2012.** Lei Complementar n. 141, de 13 de janeiro de 2012, regulamentação da EC 29/00. Brasília, DF: CONASS, 2012.

NASCIMENTO, Claudio Ferreira do; BITENCOURT, Ruth Ribeiro; CONTE, Lizandra Nunes Coelho (org.). **O financiamento do SUS: uma luta do controle social.** 1. ed. Porto Alegre, RS: Editora Rede Unida, 2021. 156 p. Série Participação Social e Políticas Públicas, v. 11. E book (PDF). ISBN 978-65-87180-86-1. DOI 10.18310/9786587180861.

MENDES, Áquilas. A longa batalha pelo financiamento do SUS**. Saúde e Sociedade,** São Paulo, v. 22, n. 4, p. 987-993, 2013.

FUNCIA, Francisco Rózsa. Subfinanciamento e orçamento federal do SUS: referências preliminares para a alocação adicional de recursos. **Ciência e Saúde Coletiva**, v. 24, n. 12, p. 4405-4414, 2019. DOI 10.1590/1413-812320182412.25892019.

QUINTAS, Carolina Landim. **Os efeitos da Lei Complementar 141/2012 no financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS), no período de 2012-2020.** 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Economia da Saúde). Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2022.

TEXTO 10 – Participação Social No SUS: Caminhos para a equidade

11 EQUIDADE NO SUS, O QUE É E SUA APLICAÇÃO

Equidade, no SUS, integra o núcleo ético e político do direito à saúde, porque parte do reconhecimento de que pessoas e grupos não ocupam o mesmo lugar social, não enfrentam os mesmos riscos, nem encontram as mesmas barreiras de acesso, logo, exigir tratamento idêntico em um cenário desigual tende a reproduzir desigualdades.

Por isso, a **equidade ultrapassa a simples distribuição uniforme de recursos e serviços**, pois **considera necessidades, diferenças e particularidades**, com a finalidade de **superar desigualdades históricas** que incidem de forma concentrada sobre grupos vulnerabilizados, afetando acesso, acolhimento e qualidade do cuidado.

Do ponto de vista conceitual, a equidade em saúde se ancora na noção de **justiça social e de direitos humanos**, entendendo a saúde não apenas como acesso a serviços assistenciais, mas como possibilidade real de usufruir condições dignas de vida. As iniquidades em saúde são produzidas por múltiplas determinações sociais, como renda, escolaridade, inserção no mundo do trabalho, raça, etnia, gênero, território e modos de vida, as quais se combinam e se reforçam ao longo do tempo.

Assim, equidade significa **criar oportunidades justas para que todas as pessoas alcancem seu potencial máximo de saúde**, o que implica reduzir disparidades evitáveis no estado de saúde e no acesso aos serviços entre grupos com diferentes níveis de privilégio social.

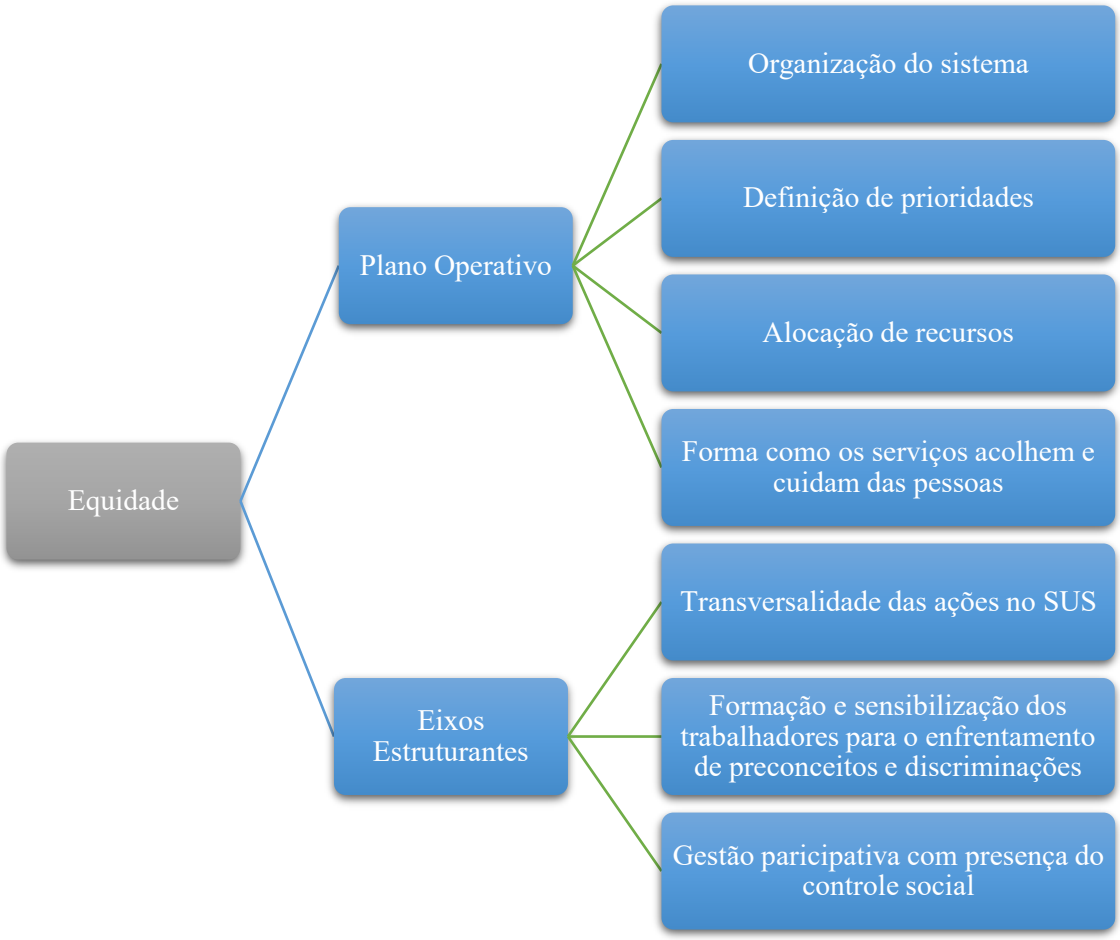
No contexto do SUS, a **equidade não se apresenta como princípio isolado, mas como elemento que qualifica a universalidade e a integralidade**. A universalidade assegura o direito de todos ao acesso ao sistema, enquanto a equidade orienta como esse acesso deve ocorrer em uma realidade social desigual.

Ao incorporar a equidade, o SUS reconhece que tratar igualmente contextos desiguais tende a perpetuar injustiças, ao passo que respostas diferenciadas, orientadas pelas necessidades, contribuem para a concretização material do direito à saúde. Esse entendimento foi progressivamente **incorporado aos debates das Conferências Nacionais de Saúde e às formulações de políticas públicas**, refletindo o amadurecimento do pensamento sanitário brasileiro em torno da relação entre saúde, cidadania e justiça social.

A aplicação da **equidade no SUS** exige que o sistema de saúde atue como agente ativo de **enfrentamento das desigualdades sociais**, **e não apenas como provedor de serviços** e

isso implica reconhecer que as iniquidades em saúde ultrapassam a dimensão econômica e alcançam outras determinações, como discriminação racial, violências institucionais, estigmatização de identidades e invisibilização de modos de vida. Nesse sentido, a equidade **orienta a formulação de políticas, programas e ações que considerem as especificidades de grupos historicamente vulnerabilizados**, integrando essas respostas ao interior das políticas universais, e não como ações paralelas ou residuais.

A **equidade** se materializa em **plano operativo** e em **três eixos** indicam que esta não se efetiva apenas por normativas, mas por práticas institucionais capazes de atravessar a gestão, a atenção e a participação social, garantindo coerência entre princípios e ações.



Para as conselheiras e os conselheiros de saúde, significa **adotar um olhar crítico** sobre planos, programas, orçamentos **compreender a equidade no SUS** e indicadores, questionando **quem são os grupos que permanecem excluídos ou subatendidos** e **quais decisões institucionais contribuem para reduzir ou aprofundar desigualdades injustas**.



Fonte: Brasil, 2026.

A equidade, nesse sentido, oferece um critério político e analítico para o exercício qualificado do controle social, pois desloca o foco da mera legalidade formal para a justiça material das políticas públicas.

Ao assumir a equidade como eixo de atuação, o controle social fortalece a democracia sanitária e contribui para que o SUS se afirme como um sistema comprometido com a dignidade humana e com a transformação das condições de vida da população.

11.1 Iniquidades e necessidades de saúde, demandas por políticas para populações vulnerabilizadas

Iniquidades são desigualdades em saúde com marca de injustiça, evitabilidade e persistência, porque se **produzem por determinantes e condicionantes que negam dignidade e condições de vida**, e não por diferença biológica inevitável. Quando se identifica que certas populações acumulam exposição a riscos, violências, discriminações e obstáculos institucionais, o SUS precisa interpretar isso como necessidade de saúde, portanto como demanda legítima por resposta pública, e não como exceção, favor ou concessão.

O debate das **políticas de promoção da equidade no SUS parte do reconhecimento de que grupos** como a população negra, os povos indígenas, os povos e comunidades tradicionais, incluindo quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, povos do campo, das águas e da floresta, a população cigana, a população em situação de rua, a população privada de liberdade, a população LGBTQIAP+, as pessoas com deficiência, as populações migrantes, refugiadas e apátridas, bem como **outros segmentos historicamente marginalizados, enfrentam restrições estruturais e persistentes no acesso aos determinantes e condicionantes da**

saúde, como renda, território, moradia, saneamento, educação, trabalho, proteção social e reconhecimento institucional, o que repercute diretamente no acesso oportuno, na continuidade do cuidado e na qualidade da atenção ofertada pelo sistema de saúde.

As políticas direcionadas a grupos historicamente marginalizados respondem a essas necessidades por reconhecer barreiras históricas e desigualdades de acesso e qualidade, e por buscar um cuidado inclusivo e justo, capaz de adequar práticas e organização do serviço às necessidades, inclusive quando o cuidado demanda enfrentamento de violência e discriminação no serviço, valorização de saberes e práticas tradicionais, e continuidade do vínculo na APS em territórios remotos.

11.2 A função do controle social para a promoção da equidade no SUS

O controle social constitui um eixo estruturante do Sistema Único de Saúde e é primordial na promoção da equidade ao possibilitar que as desigualdades injustas e evitáveis sejam reconhecidas, politizadas e enfrentadas no interior das decisões públicas.

Nos marcos da Reforma Sanitária Brasileira, a **participação social** não se limita a um mecanismo consultivo ou de fiscalização administrativa, mas **se afirma como dimensão constitutiva da democracia sanitária**, por meio da qual a sociedade intervém na formulação, no acompanhamento e na avaliação das políticas de saúde, tensionando o Estado a responder às necessidades reais da população e, em especial, das populações historicamente vulnerabilizadas.

A promoção da equidade exige que o controle social atue para além da defesa abstrata da universalidade, incorporando a análise crítica das desigualdades sociais que atravessam o acesso, a utilização e os resultados das políticas de saúde. A tensão entre políticas orientadas pela igualdade e políticas orientadas pela equidade se manifesta de forma concreta nas instâncias de participação social, uma vez que a defesa de respostas diferenciadas, baseadas nas necessidades reais da população, confronta práticas institucionais que tendem a padronizar ações e a tratar a diferença como exceção.

Diante desse cenário, o controle social cumpre a função de tornar visíveis as iniquidades, organizar demandas coletivas e afirmar a legitimidade de políticas específicas como parte constitutiva de um sistema universal comprometido com a justiça social.

No âmbito institucional, conselhos e conferências de saúde constituem espaços privilegiados para a promoção da equidade, na medida em que reúnem gestores, trabalhadores e usuários em processos deliberativos que podem incidir diretamente sobre planos de saúde, programação anual, relatórios de gestão e alocação orçamentária.

Quando orientado por uma leitura equitativa da realidade, o controle social desloca o foco da análise das médias populacionais para a identificação de desigualdades persistentes entre grupos e territórios, questionando quem acessa efetivamente os serviços, quem permanece invisibilizado nas estatísticas e quais decisões reforçam ou reduzem desigualdades injustas. Essa função analítica qualifica a participação e amplia sua capacidade de incidir sobre os rumos das políticas públicas.

A articulação com movimentos sociais, movimentos populares, bases comunitárias e comissões temáticas ampliam a capacidade do conselho de formular políticas sensíveis às especificidades de grupos vulnerabilizados.

Nesse contexto, o controle social, atua como mediador entre a experiência vivida das populações e o aparato estatal, contribuindo para que as políticas não se restrinjam ao plano normativo, mas se traduzam em práticas efetivas de cuidado e acesso.

Outro aspecto importante da função do controle social na promoção da equidade refere-se à **disputa de prioridades no financiamento público da saúde**. Ao acompanhar a elaboração e a execução dos orçamentos, **os conselhos de saúde devem questionar a distribuição dos recursos à luz das necessidades sociais e territoriais**, evidenciando como **decisões aparentemente neutras podem aprofundar desigualdades**. A equidade, nesse sentido, oferece um critério político para o controle social incidir sobre o financiamento, ao exigir que a alocação de recursos considere a concentração de vulnerabilidades e a histórica suboferta de ações e serviços em determinados contextos.

Para as conselheiras e os conselheiros de saúde, exercer o controle social orientado pela equidade significa reconhecer que **a participação não se esgota na presença formal nos espaços institucionais, mas se constrói na capacidade de analisar informações, dialogar com os territórios, articular demandas coletivas e sustentar politicamente a defesa de políticas que enfrentem desigualdades estruturais**.

O controle social se afirma como instrumento para a promoção da equidade no SUS, pois conecta democracia, direito à saúde e transformação das condições de vida, contribuindo para que o sistema avance em direção a uma justiça sanitária e socialmente referenciada.

11.3 Educação Popular em Saúde como instrumento para a equidade, contribuições de Paulo Freire

A **Educação Popular** é uma concepção educativa e política que se **fundamenta na realidade vivida pelos sujeitos e nas condições de existência das classes populare**s, tendo como referência a obra de Paulo Freire.

Para esse autor, educar não consiste em transferir conhecimentos prontos, mas em **criar condições para que homens e mulheres leiam criticamente o mundo**, **compreendam as causas de sua realidade e se reconheçam como sujeitos históricos capazes de transformá-la**.

A educação, nessa perspectiva, se estrutura a partir do **diálogo, da problematização da realidade e da valorização dos saberes populares**, rompendo com práticas autoritárias e bancárias que tratam os educandos como recipientes vazios.

No âmbito do SUS, a Educação Popular em Saúde se apropria desses referenciais freireanos ao **compreender que os processos de adoecimento e cuidado não podem ser dissociados das condições sociais, econômicas, culturais e políticas que estruturam a vida nos territórios**.



Fonte: Gemni / Nano Banana.

Inspirada na noção de **diálogo como relação horizontal entre sujeitos**, essa abordagem reconhece que profissionais de saúde, gestores e população produzem saberes distintos e complementares, e que a construção de respostas mais justas depende da escuta mútua e do respeito à experiência vivida. Assim, ao substituir a lógica da prescrição pela lógica da problematização, a Educação Popular em Saúde favorece práticas que partem das necessidades reais e enfrentam as desigualdades que produzem iniquidades em saúde nos territórios.

Outro referencial de Paulo Freire incorporado à Educação Popular em Saúde é **a emancipação, entendida como processo pelo qual os sujeitos passam a perceber as relações entre suas condições de vida, as estruturas sociais e as formas de opressão que limitam o exercício de direitos.**

No campo da saúde, esse processo permite compreender que o adoecimento recorrente de determinados grupos não decorre de escolhas individuais ou de questões culturais, mas de desigualdades históricas como o racismo, a pobreza, a exclusão territorial, a violência institucional e outras. Ao promover essa leitura crítica, a Educação Popular contribui para deslocar o foco da culpabilização individual para a responsabilização do Estado e da sociedade na garantia do direito à saúde.

A Educação Popular em Saúde também se ancora na prática refletida, segundo o qual ação e reflexão constituem um movimento indissociável. Nos serviços de saúde, isso se traduz em processos educativos que não se limitam à transmissão de informações, mas estimulam a reflexão coletiva sobre os problemas vividos, as estratégias de enfrentamento já existentes nos

territórios e as possibilidades de transformação. Essa dinâmica **fortalece a autonomia dos sujeitos e amplia sua capacidade de intervenção nos espaços de participação e controle social,** contribuindo diretamente para a promoção da equidade no SUS.

A Educação Popular em Saúde se orienta pela compreensão de que ação e reflexão caminham juntas e que não produzem mudanças quando ocorrem de forma separada, de modo que, nos serviços de saúde, essa concepção se expressa em processos educativos que ultrapassam a simples transmissão de informações e passam a favorecer a análise coletiva dos problemas vividos nos territórios. Ao mesmo tempo, esses processos consideram as estratégias já construídas pela população e as possibilidades reais de transformação das práticas e das políticas, o que contribui para ampliar a compreensão crítica da realidade.

Como resultado, a Educação Popular fortalece a autonomia dos sujeitos e, consequentemente, amplia sua capacidade de intervir de forma qualificada nos espaços de participação popular e controle social, permitindo que a equidade se traduza em decisões no âmbito do SUS.

Na prática, a Educação Popular em Saúde **qualifica o trabalho em saúde, especialmente na Atenção Primária, ao reconhecer os saberes das comunidades, fortalecer redes locais e valorizar a organização coletiva nos territórios.**



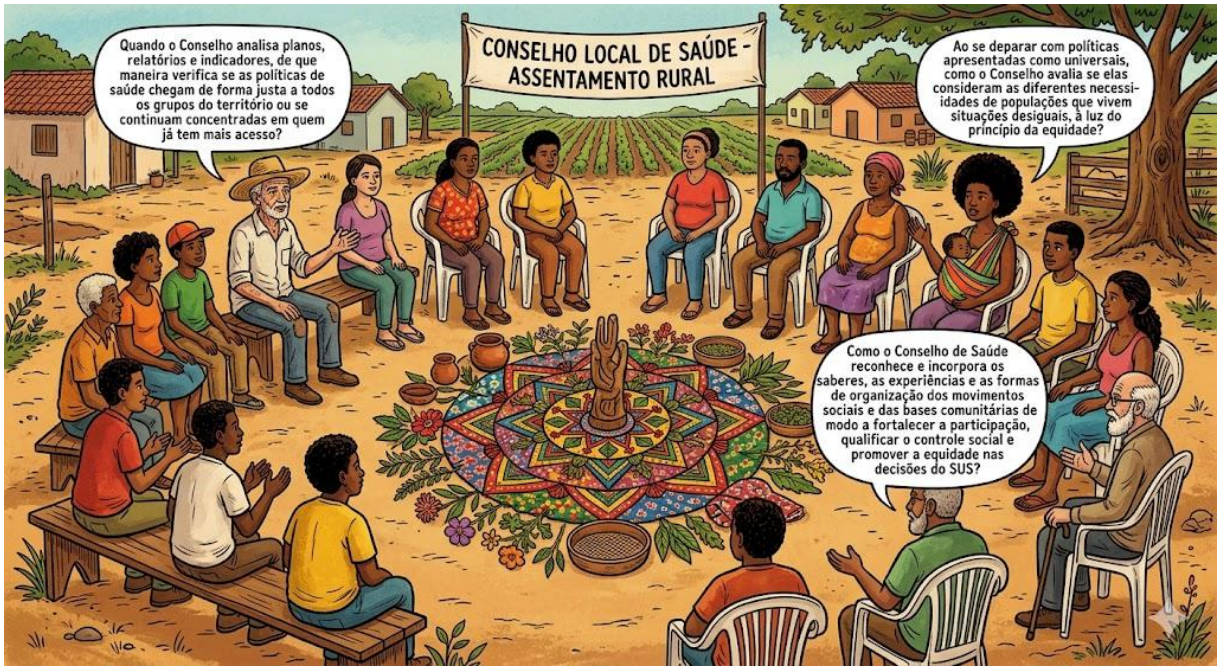
A partir desse reconhecimento, o diálogo e a reflexão construídos com base nas experiências de vida **ampliam o protagonismo das bases comunitárias e dos movimentos**

populares e sociais, permitindo identificar necessidades historicamente invisibilizadas e formular respostas mais adequadas às populações vulnerabilizadas, o que contribui para um cuidado mais acessível e sensível às desigualdades sociais.

No controle social, a Educação Popular fortalece a atuação de conselheiras e conselheiros de saúde, pois transforma vivências de sofrimento, exclusão e discriminação em conhecimento político e em demandas coletivas organizadas e com isso, a participação social ganha densidade e capacidade de incidência sobre políticas, planos e decisões públicas, de forma que a equidade deixa de ser apenas um princípio formal e passa a orientar escolhas no SUS.

Assim, a Educação Popular em Saúde se afirma como **instrumento técnico e político para a promoção da equidade,** ao articular saberes populares, participação social e compromisso com a transformação das condições de vida, contribuindo para a consolidação de um SUS universal, integral e comprometido com a justiça social.

Diálogo com você, conselheiras e conselheiros de saúde



<table>
<tr><th colspan="2">Situação problema para reflexão do Conselho de Saúde</th></tr>
<tr><td> 

Fonte: Autoria de IA</td><td>Durante a análise do Relatório Anual de Gestão, o Conselho de Saúde observa que os indicadores apontam bom desempenho do sistema e ampliação da cobertura dos serviços.

No entanto, relatos das bases comunitárias e de movimentos sociais indicam que populações vulnerabilizadas continuam enfrentando barreiras de acesso, descontinuidade do cuidado e situações de discriminação.

Diante da justificativa da gestão de que as políticas são universais e, portanto, suficientes, o Conselho se depara com o desafio de decidir se os resultados apresentados refletem acesso justo para todos ou se reproduzem desigualdades no território.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Como o Conselho pode utilizar o princípio da equidade para analisar essa situação e orientar decisões que enfrentem desigualdades injustas no acesso e no cuidado em saúde?</td></tr>
</table>

***

Quadro 1- Relação das Políticas de Equidade no SUS.

Políticas de Equidade	Finalidade/Objetivo da Política
Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, instituída pela Portaria nº 254/2002	Determinar que os órgãos e entidades do Ministério da Saúde, cujas ações se relacionem com o tema objeto da política ora aprovada, promovam a elaboração ou a readequação de seus planos, programas, projetos e atividades na conformidade das diretrizes e responsabilidades nela estabelecidas.
Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, Portaria GM MS nº 992 de 2009	Promover a equidade no acesso e na qualidade da atenção à saúde da população negra, reconhecendo o racismo como determinante social da saúde e enfrentando desigualdades étnico raciais no SUS.
Política Nacional para a População em Situação de Rua, Decreto nº 7.053 de 2009	Assegurar direitos humanos, promover cidadania e ampliar o acesso universal às políticas públicas, incluindo a saúde, enfrentando as desigualdades sociais vivenciadas pela população em situação de rua.
Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo, da Floresta e das Águas, Portaria GM MS nº 2.866 de 2011	Garantir acesso qualificado e humanizado à saúde, respeitando especificidades socioculturais, territoriais e produtivas, e reduzir riscos e impactos relacionados aos modos de vida e de trabalho dessas populações.
Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, Portaria GM MS nº 1.823 de 2012	Orientar ações de atenção integral e vigilância em saúde, com foco na prevenção, promoção e redução da morbimortalidade relacionada ao trabalho, considerando desigualdades nas condições e relações de trabalho.
Política Nacional de Educação Popular em Saúde (PNEPS-SUS), instituída pela Portaria nº 2.761/2013	Visa implementar práticas educativas, dialógicas e participativas no SUS.
Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), Instituída pela Portaria Interministerial nº 1, de 2 de janeiro de 2014	Garantir o acesso das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional ao cuidado integral no SUS.
Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, Portaria GM MS nº 2.836 de 2011, consolidada em 2017	Garantir cuidado integral, equânime e respeitoso à população LGBT, enfrentando a discriminação e a exclusão como fatores que impactam o processo saúde e doença.
Política Nacional de Promoção da Saúde, Portaria MS GM nº 687 de 2006, atualizada pela Portaria nº 2.446 de 2014, consolidada na Portaria de Consolidação GM MS nº 2 de 2017	Promover a qualidade de vida e reduzir riscos e vulnerabilidades à saúde, atuando sobre determinantes e condicionantes sociais por meio de ações intersetoriais e integradas no âmbito do SUS.

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde dos Adolescentes em Conflito com a Lei (Pnaisari), Instituída pela Portaria Consolidada/MS nº 2, Anexo XVII, de 3 de outubro de 2017, e Portaria Consolidada/MS nº 6, Seção V, Capítulo II, de 3 de outubro de 2017	Incluir essa população no SUS, organizando e ampliando o acesso aos cuidados em saúde, privilegiando as intervenções intersetoriais e articulando as diversas políticas públicas.
Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Povo Cigano/Roman, Instituída pela Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017	Estabelece o marco normativo para que o SUS organize ações e serviços que garantam atenção integral à saúde dessa população, reconhecendo as especificidades culturais, sociais e epidemiológicas do povo cigano/Romani no Brasil.

BIBLIOGRAFIA

ARROYO, Miguel González. Educação popular, saúde, equidade e justiça social. **Cadernos CEDES**, Campinas, v. 29, n. 79, p. 401–416, set./dez. 2009.

BARROS, Fernando Passos Cupertino de; SOUSA, Maria Fátima de. Equidade: seus conceitos, significações e implicações para o SUS. **Saúde e Sociedade,** São Paulo, v. 25, n. 1, p. 9–18, 2016. DOI: 10.1590/S0104-12902016146195.

BEZERRA, Ana Valéria et al. Políticas de promoção da equidade no SUS. In: **Interseccionalidade e equidade em saúde: gênero, raça e deficiências no trabalho no SUS. Vol**. 1. [S. l.]: Editora Científica Digital, 2025. ISBN 978-65-5360-872-6.

CRUZ, Pedro José Santos Carneiro; SILVA, José Carlos da; DANIELSKI, Kellin; BRITO, Pedro Nascimento Araujo. Educação popular em saúde: princípios, desafios e perspectivas na reconstrução crítica do país. **Interface: Comunicação, Saúde, Educação,** Botucatu, v. 28, e230550, 2024. DOI: 10.1590/interface.230550.

PULGA, Vanderléia Laodete; DANTAS, Vera Lúcia de Azevedo; BONETTI, Osvaldo Peralta; MATIELO, Etel; FERLA, Alcindo Antônio (org.). **Educação popular, equidade e saúde: dispositivos pedagógicos e práticas lúdicas de aprendizagem na saúde.** 1. ed. Porto Alegre: Rede Unida, 2020.

SIQUEIRA, Sandra Aparecida Venâncio de; HOLLANDA, Eliane; MOTTA, José Inácio Jardim. Políticas de promoção de equidade em saúde para grupos vulneráveis: o papel do Ministério da Saúde. **Ciência & Saúde Coletiva,** Rio de Janeiro, v. 22, n. 5, p. 1397–1406, 2017. DOI: 10.1590/1413-81232017225.33552016.

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. **Resolução nº 33, de 23 de dezembro de 1992**. Aprova o documento Recomendações para a Constituição e Estruturação de Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 131, n. 10, p. 523-524, jan. 1993.

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. **Resolução nº 453, de 10 de maio de 2012**. Aprova diretrizes para instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, n. 109, p. 138, 6 jun. 2012. Disponível em: https://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso453.pdf. Acesso em: 19 abr. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria de Consolidação nº 1, de 28 de setembro de 2017**. Consolidação das normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Diário Oficial da União: seção 1, suplemento, Brasília, DF, n. 190, p. 1, 3 out. 2017. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0001_03_10_2017.html. Acesso em: 19 abr. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria de Consolidação nº 6, de 28 de setembro de 2017**. Consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde. Diário Oficial da União: seção 1, suplemento, Brasília, DF, n. 190, p. 569-713, 3 out. 2017. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0006_03_10_2017.html. Acesso em: 19 abr. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria nº 2.203, de 5 de novembro de 1996**. Aprova a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS 01/96. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, n. 216, p. 22932-22940, 6 nov. 1996. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/1996/prt2203_05_11_1996.html. Acesso em: 19 abr. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria nº 2.135, de 25 de setembro de 2013**. Estabelece diretrizes para o processo de planejamento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, n. 187, p. 60, 26 set. 2013. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2135_25_09_2013.html. Acesso em: 19 abr. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria nº 373, de 27 de fevereiro de 2002**. Aprova, na forma do Anexo desta Portaria, a Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS-SUS 01/2002. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 139, n. 40-E, p. 52-68, 28 fev. 2002. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt0373_27_02_2002.html. Acesso em: 19 abr. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria nº 399, de 22 de fevereiro de 2006**. Divulga o Pacto pela Saúde 2006 - Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do referido Pacto. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 143, n. 39, p. 43-51, 23 fev. 2006. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0399_22_02_2006.html. Acesso em: 19 abr. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010**. Estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 147, n. 251, p. 88-93, 31 dez. 2010. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt4279_30_12_2010.html. Acesso em: 19 abr. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria nº 750, de 29 de abril de 2019**. Altera a Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para instituir o Sistema DigiSUS Gestor/Módulo de Planejamento - DGMP, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 6 maio 2019. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2019/prt0750_06_05_2019.html. Acesso em: 19 abr. 2026.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 126, n. 191-A, 5 out. 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 19 abr. 2026.

BRASIL. **Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994**. Dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os fundos de saúde estaduais, municipais e do Distrito Federal, e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, n. 167, p. 13093, 31 ago. 1994. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d1232.htm. Acesso em: 19 abr. 2026.

BRASIL. **Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011**. Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 1, 29 jun. 2011. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7508.htm. Acesso em: 19 abr. 2026.

BRASIL. **Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012**. Regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e nº 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 1-4, 16 jan. 2012. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp141.htm. Acesso em: 19 abr. 2026.

BRASIL. **Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990**. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 128, n. 182, p. 18055-18059, 20 set. 1990. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm. Acesso em: 19 abr. 2026.

BRASIL. **Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990**. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 25694, 31 dez. 1990. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm. Acesso em: 19 abr. 2026.

GUIA DE LINKS DAS FERRAMENTAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO NO SUS

- Mapa da Saúde
  Link: http://mapadasaude.saude.gov.br

- Informações de Saúde dos Indicadores do rol de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores
  Link: http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0201

- Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
  Link: http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php

- Relatório de Gestão - Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão (SargSUS)
  Link: www.saude.gov.br/sargsus

- Sistema de Acompanhamento dos Conselhos de Saúde (SIACS)

- DigiSUS Gestor – Módulo Planejamento
  Link: https://digisusgmp.saude.gov.br/

Esta obra foi elaborada entre janeiro e fevereiro de 2026
Word 2024 e PDF 10,5 MB
Folha A4
Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Secretaria de Estado da Saúde
Superintendência de Gestão Profissional e Educação na Saúde (SGPES)
Escola Tocantinense do SUS Dr. Gismar Gomes (Etsus)
606 Sul, Al. Portinari, APM 07. CEP: 77022-062
https://www.to.gov.br/saude

SECRETARIA DA SAÚDE

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO



ISBN: 978-6-58783-038-4